





دليل الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن

دائرة الصحة العامة
قسم الوقاية والسيطرة
على الامراض غير الانتقالية
شعبة صحة الكبار

٢٠٢٣



اشرف على اعداد الدليل:

- د. رياض عبد الامير الحلفي / مدير عام دائرة الصحة العامة

المشاركون في اعداد الدليل:

- د. بتول علي حسن / طبيبة استشارية / مديرة شعبة صحة الكبار
- د. سالي علاء محمد رضا / طبيبة استشارية / مسؤولة وحدة الرعاية الصحية للكبار
- د. رمال عادل كاظم / / طبيبة اختصاص دقيق تغذية سريرية/ مسؤولة وحدة الوقاية من الاعتلال العضلي العظمي
- د. علياء ادريس احمد / طبيبة اختصاص طب مجتمع/ مسؤولة وحدة الرعاية الصحية المجتمعية
- د.ميس فالح احمد فاضل / طبيبة اختصاص طب مجتمع/ وحدة الرعاية الصحية للكبار
- د. طارق جاسم محمد / طبيب اختصاص مفاصل / عضو اللجنة الفنية لتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية للكبار
- أ.د. نصيف جاسم محيميد / رئيس المجلس العلمي لاختصاص الطب النفسي /المجلس العراقي للاختصاصات الطبية
- د. ايمان جاسم محمد / طبيبة اختصاص باطنية / مديرة عيادة الكبار وعضو اللجنة الفنية لتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية للكبار
- د. احمد نزار عبد الحميد / طبيب اختصاص جراحة عيون / مستشفى ابن الهيثم
- ص. سميرة حسن عبد / رئيس صيادلة أقدم / مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة
- د. ايهاب سالم سليمان / طبيب اختصاص / مدير قسم المراكز الصحية وصحة الاسرة وعضو اللجنة الفنية لتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية للكبار
- د. ساجدة راشد كيطان / طبيبة اختصاص طب مجتمع/ مديرة شعبة الامراض غير الانتقالية في دائرة صحة الكرخ
- د. امال عبد الله مجيد / رئيس اطباء ممارسين بفرع / مديرة وحدة صحة الكبار في دائرة صحة الرصافة

الفهرست

الفصول	رقم الصفحة
الفصل الاول : التشيخ	١
ما هو التشيخ.....	٢
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن الشيخوخة.....	٢
العوامل التي تؤثر على التغيرات التي تحدث بتقدم العمر.....	٢
التغيرات التي تحدث في جسم الانسان بسبب الشيخوخة.....	٢
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن كبار السن.....	٣
الشيخوخة الصحية.....	٤
الطريق إلى شيخوخة صحية.....	٤
التشيخ الصحي المفعم بالنشاط.....	٤
اليوم الوطني والعالمي للمسن.....	٥
الفصل الثاني : برنامج الرعاية الصحية المنزلية للكبار	٦
الهدف من البرنامج.....	٧
القائمين على رعاية الكبار في المنزل.....	٧
القائمين على تقديم الرعاية الصحية المنزلية للكبار.....	٧
الفريق الصحي الزائر لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للكبار.....	٧
الفئة المستهدفة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية.....	٧
سياقات عمل برنامج الرعاية الصحية المنزلية للكبار.....	٧
❑ مهام وواجبات الطبيب المشرف على الفريق الصحي الزائر لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية.....	٧
❑ مهام وواجبات الفريق الصحي الزائر لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للكبار.....	٨
مهام وواجبات مسؤول برنامج الزائر الصحي في المركز الصحي.....	٩
استمارة برنامج الرعاية الصحية المنزلية للكبار.....	٩
حقيبة برنامج الرعاية الصحية المنزلية للكبار.....	١٠
أهم المشاكل التي تواجه الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية للكبار....	١٠
فوائد الرعاية الصحية المنزلية.....	١٠
السلامة البيئية للكبار في المنزل.....	١١
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن الامان والسلامة البيئية للكبار.....	١١
توفير البيئة الامنة للكبار.....	١١
١- البيئة الامنة داخل المنزل.	١١
٢- البيئة الامنة خارج المنزل.....	١١
الفصل الثالث : التواصل مع كبار السن	١٢
تعريف التواصل.....	١٣
معوقات التواصل مع الكبار.....	١٣
اضرار عدم او نقص التواصل مع الكبار من قبل القائمين على رعاية الكبار في المنزل....	١٣
قواعد التعامل والتواصل مع الكبار من قبل الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية الكبار المنزلية.....	١٣
قواعد التعامل والتواصل مع الكبار من قبل القائمين على رعاية الكبار في المنزل.....	١٤
طرق تحسين التواصل مع الكبار من قبل القائمين على رعاية الكبار في المنزل.....	١٤
الفصل الرابع : الاحتياجات الخاصة للكبار	١٥

١- الاستقلال الاقتصادي.....	١٦
٢- الشروط الواجب توفرها في غرفة الكبار.....	١٦
٣- دور الكبار المجتمعي.....	١٦
٤- الرعاية الصحية.....	١٦
٥- الاجراءات الصحية الوقائية.....	١٦
نوع اللقاح والفترة الزمنية له.....	١٧
٦- الادوية.....	١٧
٧- الوقاية من الحوادث.....	١٧
٨- النظافة الشخصية.....	١٧
٩- النوم.....	١٧
١٠- الرعاية الخاصة.....	١٧
١١-حماية الكبار من انواع الاساءة.....	١٨
١٢-قيادة السيارة.....	١٩
الفصل الخامس : تغذية الكبار	٢٠
التغييرات الفسيولوجية والوظيفية التي تحدث لكبار السن.....	٢١
المشاكل التي تؤثر على تغذية كبار السن.....	٢١
المشاكل الناجمة عن سوء تغذية كبار السن.....	٢١
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية فيما يخص تغذية كبار السن..	٢٢
دور القائمين على تقديم الرعاية للكبار في المنزل فيما يخص تغذية كبار السن.....	٢٢
الفصل السادس : المشاكل الصحية لدى الكبار	٢٤
اولاً / الامراض غير الانتقالية الشائعة لدى الكبار.....	٢٥
١/ ارتفاع ضغط الدم.....	٢٥
تشخيص ارتفاع ضغط الدم.....	٢٥
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن ارتفاع ضغط الدم.....	٢٥
عوامل خطورة الاصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم.....	٢٥
الاعراض الشائعة لارتفاع ضغط الدم.....	٢٦
دور القائمين على رعاية الكبار في المنزل.....	٢٦
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية.....	٢٦
٢/قصور الشرايين التاجية.....	٢٦
أهم ما يميز قصور الشريان التاجي لدى المسنين.....	٢٦
عوامل خطر الاصابة بقصور الشرايين التاجية.....	٢٦
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية.....	٢٧
٣/عجز القلب.....	٢٧
أهم ما يميز عجز القلب لدى الكبار.....	٢٧
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية.....	٢٧
٤/السكري.....	٢٨
مقدمات ما قبل السكري.....	٢٨
تشخيص ما قبل السكري.....	٢٨
مضاعفات السكري.....	٢٨
تشخيص السكري.....	٢٩

السكري والعناية بالقدمين..... ٢٩
اسباب مشاكل القدم السكري..... ٣٠
الوقاية من مشاكل قدم السكري..... ٣٠
ما هي الأشياء التي يجب الابتعاد عنها عند العناية بالقدم..... ٣١
دور القائمين على رعاية الكبار في المنزل..... ٣١
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية..... ٣١
٥/امراض الغدد الدرقية..... ٣١
اعراض اختلال نشاط الغدة الدرقية في الكبار..... ٣٢
ثانياً / المشاكل الصحية لدى كبار السن..... ٣٢
المشاكل النفسية..... ٣٢
أهم العوامل التي تؤثر على الصحة النفسية لدى كبار السن..... ٣٢
١/ الخرف..... ٣٢
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن الخرف..... ٣٣
دور القائمين على تقديم الرعاية الصحية..... ٣٣
اسباب الخرف..... ٣٣
عوامل خطر الاصابة بالزهايمر..... ٣٤
عوامل تساعد على الوقاية من الاصابة بالزهايمر..... ٣٤
٢/ الهذيان..... ٣٤
الحالات الصحية المفاجئة التي تؤدى إلى حدوث الهذيان..... ٣٤
الفرق بين الهذيان والخرف..... ٣٤
٣/ الاكتئاب..... ٣٥
أعراض الاكتئاب..... ٣٥
تختلف اعراض الاكتئاب عند كبار السن عن الفئات العمرية الاخرى..... ٣٥
٤/ القلق..... ٣٥
أعراض القلق..... ٣٥
المفاهيم الخاطئة عن الاكتئاب والقلق لدى الكبار..... ٣٦
رسائل صحية للمحافظة على الصحة النفسية للمسنين..... ٣٦
مشاكل العيون..... ٣٧
تحدث التغيرات التالية في العينين مع التقدم في العمر..... ٣٧
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن مشاكل العيون لدى الكبار..... ٣٧
١/ جفاف العين..... ٣٨
اعراض جفاف العين..... ٣٨
عوامل خطورة جفاف العين..... ٣٨
٢/ المـاء الأزرق (الجلوكومـا)..... ٣٨
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية..... ٣٨
٣/ الماء الابيض (الساد)..... ٣٩
عوامل تزيد من احتمالية الإصابة..... ٣٩
٤/ اعتلال شبكية العين..... ٣٩
اعراض اعتلال شبكية العين..... ٣٩
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية..... ٣٩

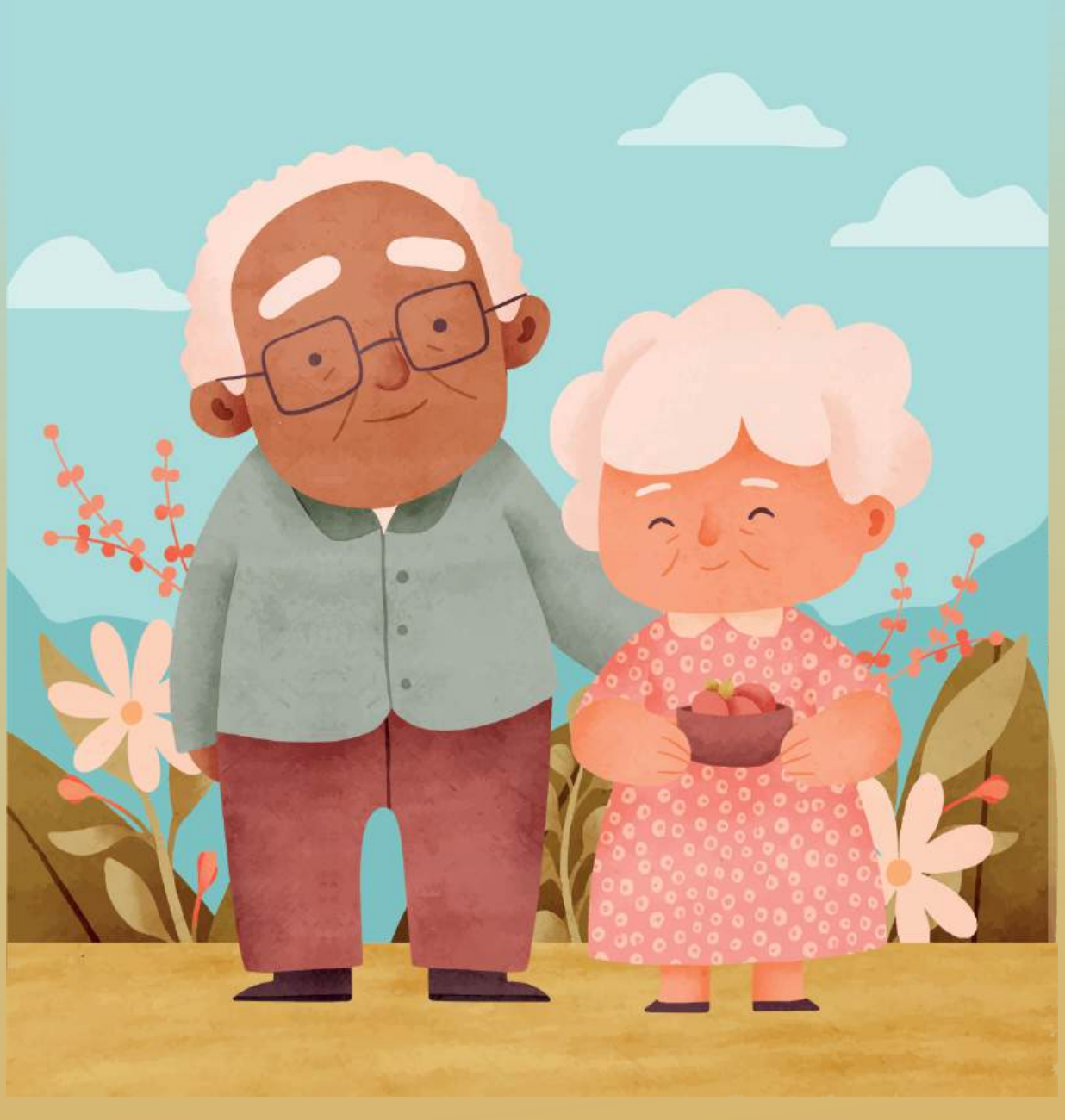
٥/ قصو البصر الشيخوخي..... ٣٩
دور القائمين على تقديم الرعاية الصحية للكبار في تقديم الارشادات العامة للحفاظ على سلامة العيون..... ٤٠
مشاكل السمع..... ٤٠
التغيرات التي تحدث في السمع مع تقدم العمر..... ٤٠
ضعف السمع وتأثيره على الكبار..... ٤١
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن مشاكل السمع لدى الكبار..... ٤١
١/ صمم الشيخوخة..... ٤١
اعراض صمم الشيخوخي..... ٤١
دور الفريق الصحي لتقديم الرعاية الصحية المنزلية..... ٤١
٢/ المشاكل المتعلقة بأستخدام المعينة السمعية..... ٤١
مشاكل الجهاز الهضمي..... ٤٢
١/ مشاكل الفم..... ٤٢
جفاف الفم..... ٤٢
ضعف حاسة التذوق..... ٤٢
فقدان الاسنان..... ٤٢
٢/ متلازمة القولون العصبي..... ٤٢
٢/ الامساك..... ٤٢
اسباب الامساك..... ٤٢
مضاعفات الامساك..... ٤٤
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية في التعامل مع مشاكل الجهاز الهضمي..... ٤٤
مشاكل الجهاز التنفسي..... ٤٥
التغيرات التي تحدث للجهاز التنفسي مع التقدم في العمر..... ٤٥
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن مشاكل الجهاز التنفسي لدى الكبار..... ٤٦
١/ الالتهاب الرئوي..... ٤٦
عوامل الخطر للاصابة بمرض الالتهاب الرئوي..... ٤٦
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية في التعامل مع الالتهاب الرئوي..... ٤٦
٢/ الامراض التنفسية الانسدادية المزمنة..... ٤٧
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن لامراض التنفسية الانسدادية المزمنة لدى الكبار..... ٤٧
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية في التعامل مع الامراض التنفسية الانسدادية المزمنة لدى الكبار..... ٤٧
مشاكل الجهاز البولي..... ٤٧
١/ السلس البولي..... ٤٧
انواع سلس البولي..... ٤٧
اعراض السلس البولي..... ٤٨
المشاكل التي تواجه المصاب بالسلس البولي..... ٤٨
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية في التعامل مع السلس البولي. ٤٩

٢/ الجفاف..... ٤٩
العوامل المؤدية لحدوث الجفاف لدى الكبار..... ٤٩
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية..... ٤٩
٣/ التهاب المجاري البولية..... ٥٠
اسباب حدوث التهاب المجاري البولية لدى الكبار..... ٥٠
اعراض التهاب المجاري البولية لدى الكبار..... ٥٠
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية..... ٥٠
مشاكل الجهاز العضلي العظمي..... ٥٠
١/ هشاشة العظام لدى الكبار..... ٥٠
عوامل الخطر للإصابة بمرض هشاشة العظام..... ٥١
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن هشاشة العظام..... ٥١
أهمية فيتامين D في بناء العظام..... ٥٢
مصادر فيتامينD ٥٢
توصي منظمة الصحة العالمية ومنظمة هشاشة العظام العالمية بأجراء فحص كثافة العظام (دكسا) لكبار السن كما يلي..... ٥٢
توصيات للوقاية من هشاشة العظام..... ٥٢
٢/ السقوط المتكرر لدى الكبار..... ٥٣
تعريف السقوط..... ٥٣
عوامل خطر السقوط..... ٥٣
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن السقوط..... ٥٤
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية..... ٥٤
٣/ ضمور العضلات لدى الكبار..... ٥٥
اسباب ضمور العضلات لدى الكبار..... ٥٥
كيف يتم تشخيص ضمور العضلات لدى الكبار..... ٥٥
الوقاية من ضمور العضلات..... ٥٥
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية..... ٥٥
التثقيف الصحي للكبير والقائمين على رعاية في اهمية تقوية العضلات من خلال..... ٥٥
٤/ الارهاق لدى كبار السن..... ٥٦
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن الارهاق لدى الكبار..... ٥٦
أهم أسباب الإرهاق لدى الكبار..... ٥٦
مشاكل الجهاز العصبي..... ٥٧
تأثير التقدم في العمر على الوظائف المعرفية للدماغ..... ٥٧
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها حول وظائف الدماغ لدى الكبار..... ٥٧
١/ السكتة الدماغية الوعائية..... ٥٧
تعريف السكتة الدماغية الوعائية..... ٥٨
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها حول السكتة الدماغية لدى الكبار..... ٥٨
عوامل الخطر في السكتة الدماغية..... ٥٨
كيف يتعامل القائمون على تقديم الرعاية الصحية الاولية مع المريض الذي يعاني من السكتة الدماغية..... ٥٨
٢/ مرض باركنسون (الشلل الرعاشي)..... ٥٩

عوامل خطر مرض باركنسون..... ٥٩
دور القائمين على رعاية الكبار في المنزل..... ٥٩
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية..... ٥٩
مشاكل الجهاز التناسلي..... ٦٠
التغيرات التي تحدث للنساء..... ٦٠
التغيرات التي تحدث للرجال..... ٦٠
عوامل الخطر التي تزيد من حدة التغيرات الطبيعية التي تحدث في الجهاز التناسلي مع تقدم العمر..... ٦٠
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن الحياة الجنسية..... ٦٠
أهم الأمراض التي تصيب الجهازالتناسلي لدى النساء الكبيرات..... ٦٠
أهم الأمراض التي تصيب الجهازالتناسلي لدى الرجال الكبار..... ٦٠
مشاكل الجلد لدى الكبار..... ٦٠
تغيرات الجلد المصاحبة للتقدم في العمر..... ٦١
نتائج تغيرات الجلد المصاحبة للتقدم في العمر..... ٦١
أمراض الجلد الحميدة الشائعة لدى الكبار..... ٦١
١/ جفاف الجلد..... ٦١
علاج جفاف الجلد..... ٦١
٢/ الحكة..... ٦١
اسباب الحكة..... ٦١
٣/ النمش..... ٦٢
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية للعناية بالجلد..... ٦٢
الفصل السابع : رعاية المسنين المقعدين (غير القادرين على الحركة) ٦٣
اسباب عدم القدرة على الحركة..... ٦٤
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن للمرضى الغير قادرين على الحركة..... ٦٤
مضاعفات عدم الحركة في المسنين..... ٦٤
دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية..... ٦٤
متى نحيل المسن المقعد الى مستويات اعلى من الرعاية..... ٦٥
تقرحات الانضغاط ٦٥
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن قرحة الفراش لدى الكبار..... ٦٥
عوامل الخطر في حدوث تقرحات الانضغاط..... ٦٥
اماكن حدوث تقرحات الانضغاط..... ٦٦
دور القائمين على رعاية الكبار في المنزل وفريق الرعاية الصحية الزائر في التعامل مع تقرحات الانضغاط..... ٦٦
وضع خطة الرعاية..... ٦٧
الجدول الاسبوعي لتقليب المسنين الملازمين للفراش..... ٦٧
الوقاية من تقرحات الفراش لدى الكبار..... ٦٧
متى نحيل المسن المقعد الى مؤسسة علاجية اعلى مستوى؟..... ٦٨
الفصل الثامن : التعامل مع الادوية ٦٩
تناول أدوية متعددة..... ٧٠
انواع تناول أدوية متعددة..... ٧٠

اسباب تناول ادوية متعددة.....	٧٠
أهم المشاكل الناتجة عن تناول أدوية متعددة.....	٧٠
الأدوات المساعدة في تنظيم تناول الجرعة الدوائية للكبار.....	٧٠
انواع ادوات تنظيم الدواء.....	٧٠
دور القائمين على تقديم الرعاية الصحية في تخفيف وطأة تناول الكبار لأدوية متعددة.....	٧١
نصائح عامة بخصوص ادوية الكبار.....	٧١
الفصل التاسع : النشاط البدني للكبار	٧٢
انواع النشاط البدني لدى الكبار.....	٧٣
المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن النشاط البدني والرياضة لدى الكبار.....	٧٣
السلامة الطبية للنشاط البدني لدى الكبار.....	٧٣
اهم المشاكل التي يعاني منها كبار السن في ممارسة النشاط البدني وكيفية ايجاد الحلول..	٧٤
فوائد الرياضة والنشاط البدني لدى الكبار.....	٧٤
الفصل العاشر : المصادر	٧٥
الفصل الحادي عشر : الملاحق	٧٦
ملحق (١) اللجان الطبية الخاصة بصرف المعينات الطبية في دوائر الصحة.....	٧٧
ملحق (٢) اداة فحص العشرة دقائق الصحي الشامل.....	٨٠
ملحق (٣) قواعد السلامة والامان في داخل وخارج المنزل للوقاية من السقوط.....	٨٢
ملحق (٤) اداة التقييم السريري للاكتئاب لدى المسنين.....	٨٥
ملحق (٥) اداة تقييم السريري السلس البولي.....	٨٦
ملحق(٦) تمارين كيجل.....	٨٨
ملحق (٧) الاداة تقييم السقوط.....	٨٩
ملحق (٨) ممارسة رياضية للوقاية من السقوط.....	٩١
ملحق (٩) اداة التقييم السريري لفقدان الذاكرة.....	٩٣

الفصـــل الأول
التـشيخ



ما هو التشيخ

التشيخ هو التغيرات الفسيولوجية غير المرضية التي تطرأ على الحالة العضوية والنفسية للانسان مع تقدمه في العمرحيث تحدث بعض التغيرات في جميع أجهزة الجسم على مستوى الخلايا والأنسجة والوظائف أيضاً، وتزيد حدة هذه التغيرات مع تقدم العمر.

لايوجد عمر معين لبدء الشيخوخة الا ان عمر ٦٠ سنة يعتبر عمر بدء الشيخوخة.

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن الشيخوخة

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
العمر الزمني للمسن هو العامل الوحيد الذي يحدد حدوث التأثيرات السلبية للشيخوخة	للعمر الزمني أهميته، ولكنه ليس العامل الوحيد الذي يحدد حدوث التأثيرات السلبية للشيخوخة
التقدم في السن لابد أن يرتبط بعوارض سلبية كالأمراض وفقدان القدرة الوظيفية	للتقدم في السن تأثيره، ولكنه لا يرتبط وحده بالأعراض السلبية للشيخوخة مثل الأمراض وفقدان القدرة الوظيفية
تعزى الكثير من الأعراض والأمراض مثل ضيق النفس وسلس البول والقصور المعرفي وغيرها إلى التقدم في السن	للأمراض أسبابها ،وكثير من الناس يصاب بها بأي عمر
يتوقف نشاط المسن وعطاءه عند التقدم بالعمر	لا يتوقف العطاء مع تقدم العمرعلى العكس تعتبر بداية لمرحلة جديدة من العطاء
صعوبة دمج المسنين في المجتمع	على الرغم من أن المسنين فئة لها احتياجاتها الخاصة، ألا انهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ويمكن الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم في الحياة
التحاق المسنين بالعمل بعد التقاعد يعد من الأمور غير الشائعة في المجتمع	المسنون يواصلون العمل طالما كانوا قادرين على العطاء، فيعملون وينتجون
تربط أي أعراض يشعر بها المسن بتقدمه في السن خاصة إن كانت غير نمطية أو غير واضحة	يجب تقييم اي اعراض يشعر بها المسن تقييماً جيداً قبل القول بأنها نتيجة الشيخوخة
يعتمد كبار السن كثيراً على افراد العائلة وهذا يشكل عبئا كبيراً على العائلة	من الواجبات العائلية المساعدة المتبادلة بين أفراد العائلة على اختلاف الأجيال العمرية

العوامل التي تؤثر على التغيرات التي تحدث مع تقدم العمر:

الوراثة ,الغذاء ,النشاط البدني واسلوب الحياة ,الامراض المزمنة ,البيئة , الحالة الاقتصادية,الحالة النفسية ,القدرة العقلية والانفعالية على التحمل.

التغيرات التي تحدث في جسم الانسان بسبب الشيخوخة:

كبير السن ممكن ان يعيش سعيد , وبصحة جيدة ويكون عنصر فعال في المجتمع طالما التغيرات التي تصاحب التقدم بالعمر من الممكن مواجهتها والتكيف لها ومن هذه التغيرات:

- **تقل الحواس الخمس :-** السمع ,البصر ,التذوق ,الشم واللمس.
- **التغيرات في العضلات والعظام - :**نقص في كتلة وقوة العضلات وقلة مرونتها ,نقص في الكالسيوم نقص في كثلة العظم ,زيادة خطورة الاصابة بالسقوط والكسورو ضعف التناغم الحركي للعضلات.
- **التغيرات التي تصيب الجلد :-** اعادة توزيع الدهون في الجسم ,ظهور التجاعيد ,الاظافر خشنة ومتقصفة وجفاف الجلد حيث يصبح اقل مرونة , قشري ورقيق.
- **التغيرات في القلب والرئتين :-** تصبح الرئتين اقل مرونة ,تقل قوة العضلات وزيادة خطورة الاصابة بالالتهابات.
- **التغيرات في التبول :-** ضعف عضلات المثانة ,تقل قابلية السيطرة على التبول ,زيادة مرات الذهاب الى الحمام ,تضخم البروستات وزيادة خطر الالتهاب.
- **التغيرات في عملية الهضم:-** مشاكل تتعلق بمضغ الطعام ومشاكل الفم والاسنان ,تقل حاسة التذوق والشم ,يقل افراز اللعاب ,تقل حموضة المعدة مما يؤدي الى تعسر الهضم, تقل الشهية, يقل الامتصاص ,تقل حركة الامعاء مما يؤدي الى الامساك.
- **التغيرات العقلية:-** زيادة خطورة الاكتئاب ,ضعف الذاكرة ,ضعف التفاعل مع المجتمع وقلة خلايا الدماغ.

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن كبار السن

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
كبارالسن يتشابهون جميعهم في الطباع ويفكرون بنفس الطريقة	الأشخاص من الأعمار الأخرى لا يتشابهون في الطباع ولا يفكرون بنفس الطريقة فلا نتوقع أن يكون كبار السن متشابهون فهم متنوعون كتنوع الإنسانية، لانهم يأتون من خلفيات تعليمية وثقافية متنوعة
كبار السن فئة مختلفة عن بقية السكان	جميع الناس يتقدمون في السن وأياً كانت المرحلة العمرية التي يحياها الناس فإنها اليوم تؤثر على صحتهم ورفاهيتهم غداً
التقدم في السن يصاحبه الإعاقة والهشاشة	يحتفظ أغلب الناس بلياقتهم وبقدرتهم على رعاية أنفسهم حتى المراحل المتأخرة من العمر ونسبة كبيرة منهم لا يشعرون بأن للتقدم بالسن تأثير مباشر على جودة حياتهم اليومية
كبار السن هم فئة غير متجدده عفا عليها الزمان	كبار السن هم الفئة الأوسع والأكثر تنوعاً في الخبرات، ويساهمون في مجتمعاتهم كقادة وعاملين وأكاديميين وعلماء ومتطوعين وفنانين وخبراء ومصادر للمعرفة والخبرات
كبار السن لا يستطيعون التعلم	التعلم لا يقتصر على الأطفال والشباب، والعمل لا يقتصر على منتصف العمر وينبغي إعداد برامج داعمة للتعلم في كل الأعمار، وإتاحة الدخول إلى أسواق العمل على مدى العمر فذلك يدعم التضامن بين مختلف الأجيال

كبار السن لا يستطيعون مساعدة أحد	كبار السن يقدمون العون لأسرهم ويقدمون لمجتمعاتهم الخبرة والحكمة
كبار السن يصاحبهم الاكتئاب	مشاعر الحزن والفقدان وتعكر المزاج مشاعر طبيعية، ولكن الاكتئاب المزمن يتداخل مع قدرة الفرد على العمل، وينصح بعلاجه من قبل الاختصاصيين
النساء الكبيرات أقل أهمية من الرجال الكبار	النساء الكبيرات لهن دور هام في الأسرة وفي المجتمع وفي رعاية أزواجهن وأحفادهن
كبار السن لا يستحقون رعاية صحية جيدة	التقدم في العمر ليس بالضرورة سبباً للمرض، ومن الضروري متابعة وضعهم الصحي من خلال الكشف المبكر والفحص الدوري للامراض

الشيخوخة الصحية:

هي القدرة على القيام بالأنشطة اليومية الأساسية مثل: تناول الطعام، وارتداء الملابس، والاستحمام، والمشي، واستخدام دورات المياه بدون مساعدة الآخرين لأطول فترة عمرية حتى وإن كان يستخدم أدوات مساعدة للمشي والتنقل مثل: العصا، ومشاية كبار السن.

الطريق إلى شيخوخة صحية:

يبدأ الاستعداد للشيخوخة الصحية من عمر مبكر؛ حيث إن هنالك بعض الأمور التي تساعد الشخص على المحافظة على صحته عندما يتقدم في السن، وتشمل:

١- المحافظة على السلوكيات الصحية مثل: النظام الغذائي المتوازن، والنشاط البدني المنتظم، والامتناع عن التدخين.
٢- الوقاية من الأمراض المزمنة في عمر ما قبل الشيخوخة يمنع تراكم الآثار السلبية لعوامل خطورتها في مرحلة الشيخوخة.
٣- الحرص على القيام بالفحوصات الطبية الدورية واللالتزام بجرعات الدواء وحسب تعليمات الطبيب المختص.
٤- البيئات الداعمة التي تساعد على القيام بالأعمال المهمة لهم بغض النظر عما فقدوه من قدرات، مثل: إتاحة المباني ووسائل النقل المأمونة والتي يسهل الوصول إليها، وطرق يسهل السير فيها.
٥- التكيف مع ضعف الحواس التي تحدث نتيجة لتقدم العمر.

التشيخ الصحي المفعم بالنشاط:

هو العملية التي يتاح فيها للمسن التمتع بالصحة والتفاعل الآمن على أفضل ما يكون لتحسين جودة حياته كلما تقدم العمر.

إن القائمين على تقديم الرعاية الصحية الأولية هم أساس الشيخوخة الصحية المفعمة بالنشاط

اليوم الوطني والعالمي للمسن:

تعزيزاً وتقديراً لحقوق الكبار في العراق والعالم ولتسليط الضوء على أهمية هذه الشريحة المهمة في المجتمع تحتفل دوائر الصحة في بغداد والمحافظات يوم ١٥ من ايلول باليوم الوطني للمسن و١ من تشرين الاول باليوم العالمي للمسن.

الفصـــل الثـــاني
ألرعاية الصحية المنزلية للكبار







برنامج الرعاية الصحية المنزلية للكبار

الهدف من البرنامج:

تحسين الرعاية الصحية لكبار السن من خلال تقديم خدمات صحية (توعوية ,وقائية ,تأهيلية ومتابعة صحية) الى كبار السن في منازلهم.

القائمين على رعاية الكبار في المنزل:

هو واحد او اكثر من افراد الاسرة الذين يسكنون مع المسن ويساعدونه في القيام بمهمام وانشطة الحياة اليومية

الفريق الصحي الزائر القائم على تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للكبار:

يعتبردور القائمين على تقديم الرعاية الصحية هاماً في التقييم الصحي الشامل والتمييز بين التغيرات الطبيعية والحالات المرضية حيث أن هناك خطأً شائعاً أن تربط أي أعراض يشعر بها المسن بتقدمه في العمر قد يكون احد الملاكات الصحية المذكورة ادناه (على ان لا يقل عدد الفريق عن ثلاثة):

١- طبيب
٢- طبيب اسنان
٣- احدى ملاكات تعزيز الصحة
٤- احدى الملاكات الصحية في الوحدة الطبية
٥- احدى الملاكات الصحي في وحدة الصحة النفس - اجتماعية
٦- احدى ملاكات العاملة في برنامج الزائر الصحي
٧- متطوع صحي (باحث اجتماعي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , متطوع من احدى منظمات المجتمع المدني او متطوع صحي مسجل في قسم تعزيز الصحة)

الفئة المستهدفة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية:

١- كبار السن (٦٠ سنة فأكثر)
٢- القائمين على رعاية الكبار ممن يسكنون معه في المنزل

سياقات عمل برنامج الرعاية الصحية المنزلية للكبار:

- ❑ **مهام وواجبات الطبيب المشرف على الفريق الصحي الزائر لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية:**

<u>المرحلة الاولى : تحضيرات الزيارة</u>

١- التنسيق مع ادارة المركز الصحي لغرض:
- **حملة توعوية واعلامية بتنفيذ البرنامج بالتنسيق مع وحدة تعزيز الصحة.**
- **خطة عمل البرنامج المتضمنة تنفيذ عشر زيارات صحية منزلية خلال ثلاثة اشهر.**

- **تحديد اعضاء الفريق الصحي الزائر وموعد تنفيذ الزيارة.**
- **تسهيل الامور اللوجستية لتنفيذ الزيارة الصحية المنزلية (مستلزمات حقيبة برنامج الرعاية الصحية المنزلية للكبار , سيارة لنقل الفريق الصحي الزائر.....)**

٢- اختيار كبير السن المراد تنفيذ الزيارة الصحية المنزلية له من خلال التنسيق مع برنامج الزائر الصحي في المركز الصحي وتكون الاولوية الى:

- **كبير السن الساكن بمفرده في المنزل.**
- **كبير السن ليس لديه قائم على رعايته في المنزل.**
- **كبير السن لم يراجع المركز الصحي لستة اشهر ماضية.**
- **كبير السن لديه عدة امراض مزمنة.**
- **كبير السن غير قادر على الحركة (مقعد).**

٣- التنسيق مع الفريق الصحي الزائر لاختيارموعد لتنفيذ الزيارة الصحية المنزلية للكبير.

٤- الاشراف على زيارة الفريق الزائر لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

٥- تحديد موعد زيارة الفريق الصحي الزائر لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية بالتنسيق مع مسؤول الزائر الصحي.

٦- تدريب الفريق الصحي الزائر على دليل الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن واستمارة الرعاية الصحية المنزلية للكبار.

المرحلة الثانية : اثناء الزيارة

١- قيادة الفريق الصحي الزائر اذا كان الطبيب احد اعضاء الفريق الصحي الزائر.

٢- المتابعة الهاتفية اثناء تنفيذ الزيارة اذا لم يكن الطبيب احد اعضاء الفريق الصحي الزائر.

المرحلة الثالثة : توثيق الزيارة

١- مراجعة استمارة الرعاية الصحية المنزلية للكبار.

٢- متابعة توثيق جميع الاجراءات المتخذة خلال الزيارة في استمارة الرعاية الصحية المنزلية للكبار بالتنسيق مع برنامج الزائر الصحي والوحدات الطبية في المركز الصحي.

٣- الاحالة الى اللجنة الطبية الخاصة بصرف المعينات الطبية وحسب مواعيد تواجدها في مراكز التأهيل والمستشفيات **ملحق (١)**.

٤- تحديد الاحتياج لزيارة ثانية من قبل فريق الرعاية الصحية المنزلية بدون طبيب او مع طبيب.

❑ مهام وواجبات الفريق الصحي الزائر من الملاكات الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للكبار:

المرحلة الاولى : تحضيرات الزيارة

١- تجهيز حقيبة برنامج الرعاية الصحية المنزلية للكبار.

٢- تحضير استمارة برنامج الرعاية الصحية المنزلية للكبار وتسجيل رقم العائلة او رقم الزائر الصحي فيها بالتنسيق مع برنامج الزائر الصحي في المركز الصحي.

٣- تحديد موعد تنفيذ الزيارة الصحية المنزلية بالتنسيق مع الطبيب المشرف على البرنامج.

المرحلة الثانية : اثناء الزيارة

١- تنفيذ الزيارة الصحية المنزلية.
٢- قياس العلامات الحيوية للكبار (ضغط الدم , قياس السكر ,النبض ,درجة الحرارة).
٣- متابعة ادوية الامراض المزمنة للكبار .
٤- فحص العشر دقائق الصحي الشامل لغربلة المشاكل الصحية العملاقة **ملحق(٢)**
٥- مشورة الكبار حول كيفية مواجهة المشاكل الصحية (التي تم تثبيتها في الاستمارة) والتي قد تصاحب التقدم بالعمر حسب دليل الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن.
٦- مشورة افراد الاسرة بكيفية الرعاية والعناية بالكبار والتعامل مع :
- التغيرات المصاحبة للشيخوخة حسب دليل الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن.
- مواجهة المشاكل الصحية التي يعاني منها الكبار ودور القائمين على رعاية الكبار في المنزل.
٧- التأكيد على تطبيق قواعد السلامة والامان داخل وخارج المنزل للوقاية من السقوط **ملحق (٣).**
٨- تحديد الاحتياجات الصحية للكبار من المعاقين والمصابين بالشلل.
٩- تقديم الدعم النفسي للكبار وافراد الاسرة القائمين على رعايتهم.
١٠- توثيق جميع الاجراءات المتخذة خلال الزيارة المتضمنة في استمارة الرعاية الصحية المنزلية للكبار.

المرحلة الثالثة : توثيق الزيارة

١- مراجعة استمارة الرعاية الصحية المنزلية للكبار مع الطبيب المشرف على البرنامج.
٢- توثيق جميع الاجراءات المتخذة خلال الزيارة المتضمنة في استمارة الرعاية الصحية المنزلية للكبار بالتنسيق مع برنامج الزائر الصحي والوحدات الطبية في المركز الصحي.
٣- حفظ الاستمارة في الملف الصحي للاسرة في ارشيف صحة الاسرة.

❑ **مهام وواجبات مسؤول برنامج الزائر الصحي في المركز الصحي:**

١- تحديث البيانات الالكترونية الخاصة بكبار السن ضمن الرقعة الجغرافية للمركز الصحي.
٢- تزويد الفريق الصحي الزائر بأستمارة الرعاية الصحية المنزلية للكبار.
٣- تحديد موعد الزيارة المنزلية بالتنسيق مع الطبيب المشرف واختيار كبير السن المراد تنفيذ الزيارة الصحية المنزلية له.
٤- أرسال رسالة نصية (SMS) الى هاتف الكبير او القائم على رعايته ان وجدت لاعلامهم بموعد الزيارة المنزلية واستحصال الموافقة على الزيارة.

❑ **استمارة برنامج الرعاية الصحية المنزلية للكبار :**

١- أُعدت الاستمارة لغرض متابعة وتقييم الوضع الصحي واتخاذ الاجراءات المناسبة من قبل الفريق الصحي الزائر والطبيب المشرف في المركز الصحي من خلال زيارة الكبير في المنزل.
٢- يتم ملئ الاستمارة من قبل الفريق الصحي الزائر لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية وحسب التعليمات الواردة فيها والتي تتضمن :-
- المعلومات التي تدون في المركز الصحي:
- المعلومات التي تدون أثناء زيارة الكبير في منزله:

- الاجراءات المتخذة من قبل الفريق الزائر:
- اجراءات الطبيب المشرف على البرنامج في المركز الصحي:

❑ حقيبة برنامج الرعاية الصحية المنزلية للكبار:

١- دليل الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن للقائمين على الرعاية الصحية المنزلية للكبار
٢- استمارة الرعاية الصحية المنزلية للكبار
٣- جهاز ضغط
٤- جهاز فحص سكر
٥- سماعة
٦- مقياس حرارة
٧- مقياس الاوكسجين (الاوكسي ميتر)
٨- كفوف + كمامات
٩- قنينة كحول تعقيم
١٠- ضمادات جروح

❑ أهم المشاكل التي تواجه الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية للكبار:

١- صعوبة التواصل مع الكبار.
٢- تعدد الأمراض المصاحبة للشيخوخة.
٣- المفاهيم الخاطئة التي تعزو الكثير من الأعراض المرضية إلى التقدم في العمر.
٤- الأعراض غير النمطية للامراض لدى الكبار.
٥- عدم رغبتهم في التحدث عن بعض المشاكل الصحية المحرجة مثل سلس البول.
٦- عدم استطاعتهم تحديد تاريخ مرضي دقيق نتيجة لقصور قدراتهم المعرفية، كما أن القائمين على رعايتهم قد يكونوا غير قادرين على ذكر التفاصيل المطلوبة.

❑ فوائد الرعاية الصحية المنزلية:

١- **الفوائد الصحية:** تعزيز الصحة الجسمانية لكبار السن حيث بينت الدراسات الحديثة ان كبار السن الذين تلقوا خدمات الصحة المنزلية يتعافون بشكل اسرع.
٢- **الفوائد النفسية:** ان بقاء كبار السن بالقرب من الاهل والاصدقاء وتلقي الخدمات الصحية في المنزل يمنحهم الشعوربالاطمئنان والراحة.
٣- **توفير الرعاية المستمرة:** استمرارية الخدمات الصحية المنزلية تضمن استمرارية المتابعة الصحية لهم.
٤- **اعادة النشاط للكبار:** تعتبر الرعاية الصحية المنزلية حافزاً للكبار في مزاولة النشاط البدني المستمر لما يلمسونه من اهتمام ورعاية.
٥- **مشاركة الكبار وافراد الاسرة في الرعاية المنزلية:** عندما يقوم فريق الرعاية الصحية المنزلية بزيارة الكبار في منازلهم ومتابعة الحالة الصحية لهم بوجود افراد الاسرة مما يشجع افراد الاسرة على متابعة صحة الكبار.
٦- **الارتقاء بصحة الكبار:** ان متابعة صحة الكبار في منازلهم ترتقي بصحة الكبار وافراد الاسرة وذلك بزيادة الوعي الصحي في الاسرة وعموم المجتمع.

❑ السلامة البيئية للكبار في المنزل:

١- يعتبر المنزل من اهم الاماكن التي يشعر بها الكبار بالامن كونها تجمعهم بمن يحبون.
٢- تؤثر البيئة التي يحيا بها الكبار على حالتهم الصحية والاجتماعية والنفسية.
٣- يجب على القائمين على رعاية الكبار في المنزل توفير بيئة ملائمة وامينة لهم.

تعتبر شروط السلامة البيئية في المنزل من الامور المهمة التي يجب الاهتمام بها من قبل العائلة لضمان حياة صحية واجتماعية ونفسية امنة للكبار ملحق (٣).

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن الامان والسلامة البيئية للكبار

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
يجب ابقاء المسن في المنزل كونه آمن	تقييم بيئة المنزل وتهيئتها للمسن من أهم العوامل التي تعزز الاستقلالية
مشاركات المسن الاجتماعية خارج المنزل تمثل عامل خطورة لاحتمال وقوع الإصابات والحوادث	المنزل ليس دائمًا بيئة أمنة للمسن ومن الممكن مشاركته في فعاليات خارج المنزل مع الاهتمام بسلامته
أمان المسن يرتبط بقلة نشاطه وحركته، وذلك لتجنب الإصابة	الحركة والنشاط البدني بصورة صحيحة مع توفير البيئة الامنة له تعزز الحالة الصحية والنفسية للمسن

توفير البيئة الامنة للكبار :

يتوجب على القائمين على رعاية الكبار بتوفير شروط البيئة الامنة داخل وخارج المنزل تجنباً للحوادث

١- البيئة الامنة داخل المنزل:

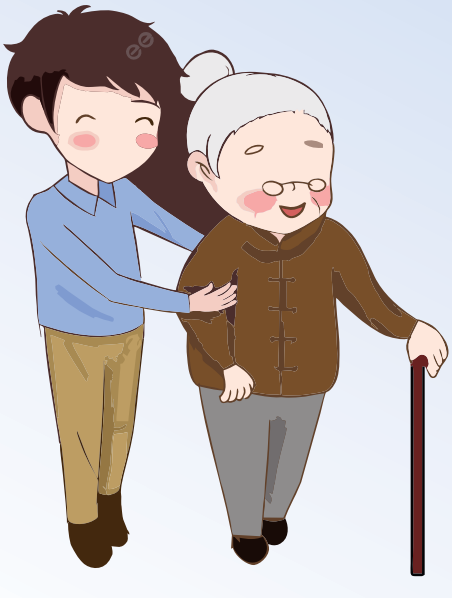
- ❖ التأكيد على توفير الإضاءة الكافية أثناء حركته لتجنب سقوطه.
- ❖ التأكد من عدم وجود الآلات الحادة والجارحة والواخزة التي تمثل خطراً عليهم ولا سيما المصابين بالخرف.
- ❖ إعادة ترتيب الأثاث الداخلي بحيث لا تعيق حركتهم وتساعدهم بالاتكاء عليها أثناء تنقلهم داخل المنزل.
- ❖ تجنب الأرضيات الزلقة واستبدالها أو تغطيتها بأسطح خشنة حتى يستطيع التنقل فوقها بأمان.

٢- البيئة الامنة خارج المنزل:

- ❖ استخدام الأجهزة المساعدة مثل سماعات الأذن، عكازة اوالنظارات الطبية.
- ❖ اصطحاب بطاقة مسجل بها الأمراض التي يعاني منها واصطحاب الأدوية التي قد يحتاجها بصورة طارئة.
- ❖ أختيار الملابس المناسبة والحذاء المناسب للطقس والمكان الذى يقصده.

الفصـــل الثـــالث
التـــواصل مع كـــبار الـسن







تعريف التواصل : هو عملية تبادل معلومات واضحة بين طرفين، وحدوث المشكلة عند أحد الطرفين يؤدي الى فجوة في عملية التواصل ولغرض لتحسين عملية التواصل مع الكبار يجب معرفة معوقات التواصل معهم

معوقات التواصل مع الكبار:

١- معوقات خاصة بالكبار:

- **ضعف الحواس:** ضعف البصر, ضعف السمع.
- **أمراض عصبية:** السكتة الدماغية, ضعف الذاكرة, مرض باركنسون.
- **عوامل نفسية:** الاكتئاب, الوحدة والانفصال عن الأسرة والأصدقاء, التقاعد عن العمل وفقدان الدور الاجتماعي

٢- معوقات خاصة بالبيئة المحيطة:

البيئة الاجتماعية : الفراغ الاجتماعي بسبب التقاعد, وفاة احد أفراد العائلة او احد الاصدقاء.

البيئة المادية: تعتبر الضوضاء وسوء الإضاءة في البيئة المحيطة عقبة هامة في التواصل مع الكبار الذين يعانون من ضعف في البصر او السمع.

٣- معوقات خاصة بالقائمين على رعاية الكبار في المنزل:

نقص في معرفة الاحتياجات الخاصة بالكبار , الالتزامات الاخرى التي تؤدي عدم الاهتمام بكل التفاصيل المتعلقة بالكبار

اضرار عدم او نقص التواصل مع الكبار من قبل القائمين على رعاية الكبار في المنزل:

١- صعوبة في علاقاتهم الأجتماعية مما يسبب الشعور بالعزلة والإحباط وقد يؤدي الى حدوث الاكتئاب والشعور بالعجز.

٢- نقص التواصل بين القائمين على تقديم الرعاية والكبار تجعل عملية الرعاية اليومية مهمة شاقة ومنهكة.

٣- نقص التواصل يجعل من الصعب على الكبار ان يعبروا عن مشاكلهم الصحية فيصابوا بالتدهور في حالتهم المرضية وصعوبة علاجهم.

قواعد التعامل والتواصل مع الكبار من قبل الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية:

١- حاول إيجاد مكان هادئ للتحدث مع الكبير.

٢- كن صبوراً وهادئاً.

٣- تكلم ببطء ووضوح واعط الكبير الوقت الكافي للإجابة ولا تتحدث مع الآخرين أمامه كما لو أنه غير موجود وتذكر دائما إشراك الكبير في المحادثة.

٤- ساعد الكبير على التعامل مع مشاعره ومواجهتها.

٥- بدلا من التركيز على ما لم يعد الكبير قادراً على القيام به، ركز على ما يمكنه فعله دائما.

٦- إذا كان لدى الكبير مشكلة صحية، ابحث واحصل على معلومات كافية حولها وعن أفضل الطرق التي يمكن تقديمها أو توفيرها لمساعدته، وابحث كذلك عن الشخص القادر على التعامل معها.
٧- قدم المعلومات الصحية بطريقة يمكن أن يفهمه الكبير.
٨- تعرف إلى التغييرات السلوكية للكبير وانصح القائم على رعايته على التآلف معها.
٩- هناك فرق بين «المساعدة» و«القيام بالعمل» لذا اعتمد قدر الإمكان نهجاً يعزز استقلالية الكبير في اداء انشطة الحياة اليومية.
١٠- عندما يتحدث الكبير عن الموت لا يجب صده ويجب مساعدته عبر طرح بعض الأسئلة، مثل: ما الذي يجعلك تقول هذا؟ وما الذي يسعدك؟
١١- عند التكلم معه من المفيد إمساك يده لطمأنته.
١٢- إجلس بجانبه وحافظ على التواصل البصري أثناء التحدث معه.
١٣- إجعل الكبير يشعر أنه مهم ويعلم أنك تصغي له.
١٤- إحترم خصوصيته ورغبته بالصمت او الكلام مع عدم تركه وحيدا وساعده على التواصل مع البيئة المحيطة به.

قواعد التعامل والتواصل مع الكبار من قبل القائمين على رعاية الكبار في المنزل:

١- منح الكبير الفرصة في المشاركة في أعمال المنزل وتدبير الشؤون المنزلية.
٢- آخذ رأي الكبير في ما يتعلق بشؤون المنزل وناقشه في وجهة نظره.
٣- معاملة الكبير بشكل لائق ومنحه الحب ,الاهتمام ,الاحترام ,المساعدة والعون.
٤- الاهتمام والانتباه كي لا يتعرض لأي موقف قد يصدر من أحد الأولاد أو الاصدقاء بقصد أو من دون قصد ويقلل من احترامه
٥- لا تسمح له بالانعزال في غرفته خاصة في المساء، والاهتمام بقضاء اكبر وقت مع العائلة في غرفة واحدة.
٦- إذا كان الكبير يعاني من عجز جسدي يجب ان نخصص له مكاناً في غرفة الجلوس ليكون قريب من العائلة.
٧- الاهتمام بتلبية احتياجاته الشخصية بدون ان يطلب هو ذلك.

طرق تحسين التواصل مع الكبار من قبل القائمين على رعاية الكبار في المنزل:

١- استعمال لغة الجسد الملائمة والمقبولة من قبل الكبارمثلا:
- ❖ يعتبر إلقاء التحية والابتسامة من الخطوات الهامة التي تجعل الكبار يشعرون بالراحة والاهتمام.
- ❖ استخدام اللمسات الحانية لاعطاء الكبار الشعور بالراحة والتركيز.

٢- تشجيع استخدام الوسائل المساعدة، مثل النظارات الطبية وسماعات الأذن ومكبرات الصوت.
٣- استعمال الوسائل المختلفة للتواصل المسموعة والمرئية ومنها المكتوبة مثل :
- ❖ استخدام الرسوم البيانية ,النماذج ,الصور والمعينات البصرية لمساعدة الكبار على فهم أفضل لحالتهم الصحية.
- ❖ كتابة التعليمات كاملة بصورة سهلة وواضحة، حتى لا ترهق الكبار بالتذكر في وقت لاحق.

الفصـــل الرابــع
الاحتياجات الخاصة للكبار







١/ الاستقلال الاقتصادي:

يعتمد أغلب الكبار اقتصاديا على غيرهم ومن الضروري ضمان تمويل احتياجات الرعاية الصحية للمسنين، مثل شراء النظارات، وسائل السمع، العكاز، ومتطلبات علاج الأمراض المزمنة.

٢/ الشروط الواجب توفرها في غرفة الكبار:

- ❖ يجب ان تكون غرفة الكبير في الطابق الارضي.
- ❖ وجود تدفئة وتبريد بحيث تكون درجة الحرارة من ٢٥-٢٠ وان لا تقل عن ٣٠درجة شتاء.
- ❖ وجود إنارة كافية وموزعة في جميع الأماكن
- ❖ توفير التهوية اللازمة مع تزويد النوافذ بمناخل وشباك حماية لايسهل فتحه.
- ❖ وجود ستائر سهلة الفتح والإغلاق ويفضل التي تعتمد على الحبال.
- ❖ اختيار ألوان متناقضة للأثاث والأرضية والجدران
- ❖ توزيع الأثاث بحيث يضمن سهولة الحركة لمستعملي الكراسي المتحركة.
- ❖ يفضل توفير الأثاث المصنوع من الخشب
- ❖ توفير مقبسان للكهرباء
- ❖ الخزائن قريبة من السرير.
- ❖ الأثاث خالي من الحواف الحادة.
- ❖ تغطية أرضية المنزل بغطاء آمن مثل السجاد

٣/ دور الكبار المجتمعي:

- ❖ يحتاج الكبار إلى أن يقوموا بدورهم في الأسرة والمجتمع وألا يشعروا بالعزلة. فالعزلة والوحدة من اكثر مسببات الاكتئاب.
- ❖ يجب ان يشعر الكبار باهميتهم في محيط الاسرة والمجتمع .

٤/ الرعاية الصحية:

يمكن أن ينتج عن الشيخوخة عدد من الأمراض والإعاقات ولكن كثيراً منها يمكن معالجته فتوفير جهاز السمع، أو النظارة، أو طقم الأسنان الصناعية، أو إجراء عملية الكاتاراكت، وغيرها يمكن أن يحسن بشكل كبير حالة الكبار.

٥/ الإجراءات الصحية الوقائية:

- ❖ الإجراءات الوقائية لها تأثير كبير في الوقاية من الأمراض مثل: قياس ضغط الدم بانتظام، متابعة وزن الجسم، شرب الماء النقي، التغذية الملائمة، الامتناع عن التدخين، والفحص الطبي الدوري.
- ❖ اللقاحات الضرورية ضد الامراض التي تهدد صحتهم العامة مع وجود امراض مزمنة في اغلب هذه الفئات العمرية ويتم شمولهم باللقاحات التالية:

نوع اللقاح والفترة الزمنية له

نوع اللقاح	الفترة الزمنية
لقاح ثنائي كبار (الخناق والكزاز Td)	كل عشر سنوات من عمر ٥٠ سنة
لقاح المكورات الرئوية المقترن (PCV13)	جرعة واحدة من عمر ٦٥ سنة
انفلونزا	سنوياً
لقاح السحايا الرباعي المقترن	جرعة واحدة كل خمسة سنوات
لقاح كوفيد ١٩	جرعة واحدة او جرعتين حسب الشركة المصنعة للقاح

٦/ الأدوية:

يجب مراعاة الحرص الشديد في توفير الادوية اللازمة لحالتهم الصحية والتي يجب أن تستخدم بمشورة من الطبيب المعالج.

٧/ الوقاية من الحوادث:

- الكبار أكثر عرضة للإصابة بالحوادث التي تقع أكثرها في المنزل.
- تقع حوادث السقوط في المنزل عادة عند النهوض من الفراش، وعند تخطي عتبة الباب، أو نتيجة الانزلاق على أرضية الحمام المبللة، أو أثناء الصعود أو الهبوط على الدرج.
- يمكن توقي هذه الحوادث **ملحق (٣)** عن طريق الإضاءة الكافية واستخدام النظارة، ووضع مساند للاستناد عليها في الحمام وعلى جوانب الفراش وجوانب الدرج.

٨/ النظافة الشخصية:

- الحفاظ على نظافة شخصية جيدة يحمي من الإصابة بالأمراض
- يجب إيلاء عناية خاصة بنظافة الفم والأسنان، ولاسيما طقم الأسنان الصناعية إذا كان مستخدماً.
- أن الاستحمام المنتظم يحافظ على نظافة الجسم.
- العناية بمظهر الكبار بلطف وحنان.

٩/ النوم:

- متطلبات النوم تقل مع تقدم العمر، وهذا أمر طبيعي
- أي محاولة لتغيير ذلك عن طريق استخدام المنومات يمكن أن تسبب مشاكل
- يساعد النشاط البدني خلال اليوم على تقليل تكرار الغفوة اثناء النهار.
- تنظيم ساعات الاستيقاظ بحسب حاجة الكبار وتجنب إحداث ضوضاء اثناء النوم.

١٠/ الرعاية الخاصة:

الكبار الضعفاء بحاجة إلى الرعاية والمساعدة في حياتهم اليومية كما في ارتداء الملابس وإعداد الوجبات، واستخدام دورات المياه، وغيرها.

١١/ حماية الكبار من كل انواع الاساءة:

- تعرف منظمة الصحة العالمية إساءة معاملة الكبار بأنها **« القيام بفعل واحد أو فعل متكرر، أو عدم اتخاذ الإجراء المناسب، (داخل أي علاقة يتوقع فيها وجود الثقة) مما يؤدي إلى إصابة الشخص المسن بضرر أو كرب .»**
- يمكن أن تتخذ إساءة معاملة الكبار أشكال مختلفة، مثل إساءة المعاملة الجسدية او اللفظية أو النفسية أو العاطفية أو الجنسية أو المالية. ويمكن أن تحدث كذلك نتيجة إهمال متعمد أو غير متعمد.
- **يمكن أن تحدث لأي شخص كبير في السن، من قبل :**
  - أحد أفراد أسرته
  - مقدم رعاية
  - شخص غريب
- **يمكن أن تحدث في :**
  - المنزل
  - في منزل أحد الأقارب
  - خارج المنزل
  - في دار لرعاية المسنين
- في كثير من الأحيان، لا يتم اكتشاف حالات إساءة معاملة الكبار وإهمالهم على الفور من قبل مقدمي الرعاية الصحية أو أعضاء المجتمع، وذلك بعكس الفئات العمرية الأخرى، لأن كبار السن قد يبقون في المنزل، بحيث لا يسهل تحديد سوء المعاملة والإهمال الممارس حيالهم.
- **قد ينظر الكبار إلى سوء المعاملة حيالهم على أنّها :**
  - طبيعية أو لا يمكن تجنبها.
  - أنها ليست مهمة بما يكفي لتلقي او طلب المساعدة.
  - أن سوء معاملتهم من قبل أقاربهم (الأولاد خصوصاً) هو شأن عائلي خاص، ويخجلون من الكشف عن ذلك.
- **اسباب كتمان الكبار إساءة المعاملة والاهمال:**
  - شعورهم بالخجل أو الاحراج نتيجة ولائهم العائلي القوي جدًا.
  - حرصهم على كرامتهم وعلى تغيير نظرة الاخرين لهم في حال اعلانهم عنها.
  - الخوف من عدم تصديقهم.
  - اعتقادهم بأنهم يستحقون ذلك وأنهم مذنبون.
  - عدم ادراكهم بأنهم يتعرضون لسوء المعاملة او الاهمال.
  - خوفهم من المعنف.
- **علامات متوقعة على ان الكبار يتعرضون لاساءة المعاملة:**
  - يبدو مكتئبا، مشوش الذهن أو منطوي على نفسه.
  - معزول عن الاصدقاء والعائلة.
  - وجود كدمات ,حروق او ندب غير مبررة.
  - تبدو على المسن علامات انعدام النظافة, نقص التغذية , الجفاف, لايتلقى علاجه ولايتلقى الرعاية الطبية اللازمة لمشاكله الصحية.

- ❖ يعاني من تقرحات الفراش او حالات اخرى من الممكن الوقاية منها.
- ❖ ليس لديه دخل مالي خاص به.

١٢/ قيادة السيارة:

قيادة السيارة بالنسبة للكبار أحد المتطلبات الهامة التي تؤثر في جودة حياتهم وفي استقلاليتهم ,هناك عوامل تؤثر على قدرة الكبار على قيادة السيارة:

- ❖ الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض المفاصل.
- ❖ اضطرابات النوم.
- ❖ الأدوية وخاصة أدوية الجهاز العصبي.
- ❖ امراض الجهاز العصبي، مثل جلطات الدماغ والشلل الرعاش والخرف.
- ❖ ضعف البصر او السمع.

عوامل تمنع الكبار من قيادة السيارة:

- ❖ الجلطات القلبية او الدماغية.
- ❖ الانخفاض في سكر الدم.
- ❖ اضطراب ضربات القلب.

الفصـــل الـخامــس
تــغذية الــكبار





التغذية السليمة وامتلاك وزن صحي خلال مرحلة الشيخوخة ضروري للحفاظ على الصحة والحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة أو تقليل مضاعفاتها ومنها مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والشرايين ،التهاب المفاصل ، هشاشة العظام، الزهايمر وبعض أنواع السرطان .

التغييرات الفسيولوجية والوظيفية التي تحدث لكبار السن:

تتأثر الاحتياجات الغذائية لكبار السن بالتغيرات الفسيولوجية والوظيفية والصحية والتي تحدث مع التقدم في السن وهي:

- ضعف حاسة الشم والتذوق وقلة الشهية.
- صعوبة البلع وصعوبة المضغ بسبب مشاكل الاسنان.
- قلة امتصاص الكالسيوم والحديد وانخفاض مستوى فيتامين B12.
- قصور بوظائف الجهاز الهضمي.
- فقدان الكتلة العضلية والعظمية.
- انخفاض في كمية الماء بالجسم مع تقدم العمر وانخفاض الإحساس بالعطش.

كذلك يعتمد تحديد هذه الاحتياجات الغذائية على عدة عوامل هي:

- العزلة و تناول الكبار الطعام بمفردهم مما يقلل اهتمامهم بالاكل.
- قلة النشاط البدني والعادات الغذائية غير الصحية .
- صعوبة الحركة تؤدي الى قلة الحصول على الغذاء.
- تدهور الحالة الاقتصادية.
- الاصابة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع الضغط و داء السكري.
- استخدام الأدوية التي تؤثر على الشهية أو القدرة على امتصاص المواد الغذائية.
- الحالة النفسية ومنها الشعور بالاكتئاب مما يسبب فقدان الشهية.
- النسيان الناتج عن مرض الزهايمر وهذا يؤدي الى نسيان تناول الطعام.

المشاكل التي تؤثر على تغذية كبار السن:

١- صعوبة المضغ والبلع.
٢- الجفاف (علامات الجفاف : قلة افراغ البول، ارتفاع حرارة الجسم ، الامساك، جفاف الفم ، الهذيان واضطراب الوعي).
٣- ارتجاع المريء.
٤- الغازات أو انتفاخ البطن
٥- كسل المعدة (تأخّر افراغها) والشبع المبكر.

المشاكل الناجمة عن سوء تغذية كبار السن:

١- السمنة او فقدان الوزن
٢- الامساك
٣- هشاشة العظام

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية فيما يخص تغذية كبار السن:

توعية وتثقيف الكبار والقائمين على رعايتهم على اتباع نمط حياة صحي من خلال اعطاء نصائح وارشادات حول التغذية الصحية وهي:

- تناول الطعام بكميات صغيرة (٥-٦ وجبات) خلال اليوم .
- تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً.
- يجب ان يحتوي النظام الغذائي اليومي على اختيارات من كل المجاميع الغذائية (الحليب والالبان، الفواكه والخضروات ، الحبوب، اللحوم والبقوليات وبدائلها من البيض والاجبان ، الزيوت والدهون).
- الحرص على تناول اللحوم البيضاء (الدواجن والاسماك) وتقليل من تناول اللحوم الحمراء.
- ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12 مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والمواد الغذائية المدعمة بفيتامين B12.
- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مع وجبات الطعام لتحسين امتصاص الحديد الموجود في مصادر الطعام النباتية مثل: برتقال، كيوي ، فلفل، بروكلي، طماطم والخضروات الورقية الخضراء.
- الحرص على تناول الاطعمة الغنية بالألياف مثل: الحبوب الكاملة مثل الخبز الاسمر، البرغل و الشوفان ، المكسرات ، الفواكه والخضروات الطازجة مع عدم ازالة القشر.
- اضافة الزيوت النباتية الى الاطعمة مثل زيت الزيتون بكميات معتدلة.
- شرب كميات كافية من السوائل (٦-٨) اكواب يوميا ويفضل وضع زجاجة الماء في مكان يسهل الوصول إليه.
- تقليل تناول القهوة والشاي.
- تجنب تناول المنتجات الغذائية الجاهزة والمشروبات الغازية والمعلبات والاطعمة الدسمة.
- تجنب الأطعمة الجافة او الخشنة جدا.
- تناول الطعام مع أفراد العائلة او الأصدقاء المقربين.
- الحفاظ على الوزن الصحي.
- الامتناع عن التدخين او تناول الكحول.
- الحصول على قسط كافي من الراحة والنوم.
- الحرص على ممارسة أنشطة الحياة اليومية والنشاط البدني.
- يوصى باستخدام المكملات الغذائية وحسب ارشادات الطبيب المختص بعد تقييم حالة كبير السن.

دور القائمين على تقديم الرعاية للكبار في المنزل فيما يخص تغذية كبار السن:

اتباع النصائح والارشادات الخاصة بتغذية كبار السن وكيفية تحضير الطعام بطريقة صحية:

- غسل اليد بشكل منتظم بالماء الدافئ والصابون السائل قبل واثناء اعداد الطعام النيء وبالأخص اللحوم النيئة.
- غسل ادوات الطهي وأسطح منطقة تحضير الطعام والحرص على تجفيفها.

- ❖ غسل الواح وادوات التقطيع المستخدمة في تقطيع اللحوم النيئة بالماء والصابون جيدا قبل البدء في استخدامها لتقطيع الاغذية التي تؤكل نيئة مثل الخضراوات والفواكه ويفضل فصلها
- ❖ لاتعد طعام النيء قريبا من الطعام الجاهز للأكل.
- ❖ تخزن اللحوم النيئة في الرف السفلي من الثلاجة وفوقها تخزن الانواع الاخرى من الاطعمة النيئة اما الطعام الجاهز للأكل يخزن في الرفوف العلوية بعيدا عن الاطعمة النيئة
- ❖ عند الحاجة الى اذابة الطعام المجمد ضعه في الثلاجة الى ان يذوب تماما
- ❖ يجمد الطعام مرة واحدة
- ❖ غسل الخضراوات والفواكه جيداً تحت الماء الجاري قبل تقشيرها وتقطيعها مع التأكد من فركها أثناء الغسل لإزالة الأوساخ العالقة بها والحرص على تجفيفها بعد الغسل.
- ❖ عند اعادة تسخين الطعام يسخن جيدا ، عدم تسخين الطعام أكثر من مرة
- ❖ تحضير الوجبات الغذائية بالبيت وبشكل صحي.
- ❖ التقليل من استخدام الملح اثناء تحضير الطعام واستبداله بالاعشاب والتوابل.
- ❖ طهي الطعام بطريقة الشواء والسلق.
- ❖ تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة ليسهل مضغها.
- ❖ عند تحضير السلطات الخضراء (مثل سلطة الخس أو سلطة المعدنوس) يجب التأكد من تنظيف الأوراق جيدا لأنها غالباً ماتكون صعبة التنظيف.
- ❖ عدم ترك الاغذية المطبوخة فترة طويلة بدرجة حرارة الغرفة.

الفصـــل الســـادس
الامراض والمشاكل الصحية لدى الكبار





اولاً / الامراض غير الانتقالية الشائعة لدى الكبار

١/ ارتفاع ضغط الدم

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأُمراض المزمنة شيوعاً لدى الكبار، وتعتبر من أهم عوامل خطر الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية التي هي أهم مسببات الوفاة في العالم

تشخيص ارتفاع ضغط الدم:

يعتبر الكبار مصابين بارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم الانقباضي يساوي أوأكثر من ١٤٠ميلي متر زئبقي أو يكون ضغط الدم الانبساطي يساوي أوأكثر من ٩٠ ميلي متر زئبقي أو كليهما في ثلاثة قياسات للضغط تؤخذ على يومين متباعدين.

- ❖ هدف منظمة الصحة العالمية هو جعل ضغط الدم تحت ٩٠/١٤٠ ميلي متر زئبقي.
- ❖ تعتبر قراءة ضغط الدم ٨٠/١٣٠ مرتفعة في حالة مرضى امراض الكلى والسكري.

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن ارتفاع ضغط الدم

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
ارتفاع ضغط الدم تغير طبيعي مع تقدم العمر	ارتفاع ضغط الدم مرض لا بد من علاجه لتفادي مضاعفاته الخطيرة
يختلف تشخيص ارتفاع ضغط الدم في البالغين عن الكبار	تعريف ضغط الدم وتشخيصه لا يختلف باختلاف الفئة العمرية
عدم وجود أعراض مرضية ينفي وجود مرض ارتفاع ضغط الدم	ارتفاع ضغط الدم هو القاتل الصامت، ولذلك يجب قياس الضغط بصورة دورية حتى بدون وجود أعراض مرضية

عوامل خطورة الاصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم:

❖ عوامل قابلة للتعديل

١- الغذاء غير الصحي (فرط تناول الملح والدهون المشبعة والمتحولة، قلة تناول الفواكه والخضار)
٢- قلة النشاط البدني
٣- التدخين
٤- تعاطي الكحول
٥- زيادة الوزن او البدانة

❖ عوامل غير قابلة للتعديل

١- التاريخ المرضي للعائلة
٢- العمر اكبر من ٦٥سنة
٣- الامراض الموجودة مسبقاً كالسكري وامراض الكلى

الاعراض الشائعة لارتفاع ضغط الدم:

- ❖ الصداع، تغيم الرؤية أو الرؤية المزدوجة، وآلام الصدر، وضيق التنفس، والدوخة، وزيادة ضربات القلب ، نزف الانف ، طنيف الاذن والغثيان او التقيؤ.
- ❖ يمكن أن **لا تظهر** أي أعراض على المصاب بأرتفاع ضغط الدم.

دور القائمين على رعاية الكبار في المنزل:

١- الاهتمام بتوفير وجبات غذائية صحية للكبير والذي تتضمن: منتجات الالبان ، الفواكة ،الخضروات ، والاكثار من الحبوب الكاملة اللحوم قليلة الدسم ،الاسماك، تقليل الملح والدهون في تحضير الطعام والاكثار من شرب الماء.

٢- مساعدة الكبير في تعزيز انماط الحياة الصحية مثل تشجيع الحركة والنشاط البدني والاندماج في الحياة الاجتماعية.

٣- توفر جهاز ضغط الدم في المنزل لغرض متابعة قياس ضغط الدم بصورة مستمرة

٤- الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج بخصوص الادوية ومراجعاته الدورية

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية:

١- قياس ضغط الدم في كل زيارة منزلية.

٢- تقييم العادات الغذائية واهمية ممارسة النشاط البدني.

٣- التثقيف الصحي للكبير وعائلته حول المرض ومضاعفاته.

٤- تدريب القائمين على رعاية الكبار في المنزل على الطرق الصحيحة لقياس ضغط الدم في المنزل.

٢/ قصور الشرايين التاجية

يعتبر قصور الشرايين التاجية من أكثر الأُمراض شيوعاً لدى الكبار ولايمكن الشفاء منه ولكن يمكن علاج الاعراض وتقليل المشاكل الصحية كالنوبات القلبية.

أهم ما يميز قصور الشريان التاجي لدى المسنين:

١- غياب الأعراض واكتشاف المرض عند حدوث المضاعفات.

٢- أعراضه غير نمطية مثل الارهاق المزمن وضيق التنفس والألم في منطقة الصدر(ذبحة صدرية).

عوامل خطر الاصابة بقصور الشرايين التاجية:

عوامل الخطر القابلة للتعديل:

١- ارتفاع ضغط الدم.

٢- السكري

٣- ارتفاع الدهون في الدم.

٤- التدخين والكحول.

٥- زيادة الوزن والنظام الغذائي غير الصحي
٦- قلة النشاط البدني.
٧- التعرض لكثير من التوتر.
٨- قلة النوم او كثرته المفرطة.

عوامل خطر غير قابلة للتعديل:

١- تقدم العمر
٢- تأريخ عائلي سابق للمرض

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية:

تثقيف الكبار والقائمين على رعايتهم حول:

١- تجنب عوامل خطر الاصابة بالمرض القابلة للتعديل.
٢- متابعة ظهور الاعراض غير النمطية للمرض مثل ضيق النفس ,الارهاق المزمن او الألم في منطقة الصدر.
٣- اذا كان الكبير مصاب بالمرض فيجب متابعته في جميع مراحل المرض لضمان جودة حياة الكبير واستقلاليته.

٣/ عجز القلب

هو من أهم أسباب الدخول المتكرر للمستشفيات لدى الكبار، ويمكن اعتباره أحد المضاعفات لكثير من الامراض مثل ارتفاع ضغط الدم وقصور الشرايين التاجية.

أهم ما يميز عجز القلب لدى الكبار:

١- تأخر التشخيص بسبب شيوع الأعراض غير النمطية، وأهمها الشعور بالأجهاد، مما يدفع الكبار الى عدم ممارسة نشاطهم اليومي لتجِب هذا الشعور.
٢- شيوع عجزالقلب باعراض غير محددة مثل ضيق التنفس والسعال المزمن.

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية:

تثقيف الكبار والقائمين على رعايتهم حول:

١- تجنب عوامل خطر الاصابة بالمرض مثل أرتفاع ضغط الدم ,قصور الشرايين التاجية تأريخ عائلي سابق للمرض.
٢- التثقيف الصحي للمريض وللقائمين على تقديم الرعاية له حول أعراض المرض وأهميته وكيفية السيطرة على عوامل خطر الاصابة بالمرض.

٤/ السكري

هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز الجسم عن إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو لا يستطيع الاستفادة من الأنسولين الذي ينتجه بفعالية.

يعتبر السكري من أكثر الأُمراض المزمنة شيوعاً بين الكبار في جميع دول العالم، كما أنه من أكثر الأُمراض التي تمثل عبئاً على الرعاية الصحية والاجتماعية، لما يسببه من مضاعفات، ويتطلبه من رعاية شاملة ومتابعة مستمرة.

لا يوجد علاج لداء السكري من النوع الثاني وإنما يمكن أن يساعد فقدان الوزن وتناول طعام جيد وممارسة التمارين في السيطرة عليه.

مقدمات السكري (ما قبل السكري):

مرحلة ما قبل السكري هي الحالة التي تسبب ارتفاع السكر لمستويات أعلى من الدم الطبيعي، لكنها لا ترتفع لمستوى داء السكري من النوع الثاني ولكن ترك الحالة دون إجراء تغييرات في نمط الحياة يجعلهم عرضةً بشكل أكبر لخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحية، وجعل النشاط البدني جزءًا من الروتين اليومي والحفاظ على وزن صحي في إعادة مستوى السكر في الدم إلى طبيعته.

تشخيص ما قبل السكري:

١- **السكر في الدم بعد الصيام:** ١٠٠-١٢٥ميلي غرام/ميلي لتر
٢- **السكر في الدم بعد الطعام:** ١٤٠ - ١٩٩ميلي غرام/ميلي لتر
٣- **السكر التراكمي (HBA1C):** تشخص النسبة من ٥,٧% - ٦,٤% على أنها مقدمات لداء السكري (يفضل اعادة التحليل سنوياً).

مضاعفات السكري:

١- **مرض القلب والأوعية الدموية:** يرتبط داء السكري بزيادة احتمال الإصابة بمرض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وتضيق الأوعية الدموية، وهي حالة تسمى تصلب الشرايين.

٢- **تلف الأعصاب في أطراف الجسم:** تسمى هذه الحالة الاعتلال العصبي. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم بمرور الوقت إلى تلف الأعصاب أو تدميرها. وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بوخز أو خدر أو حرقة أو ألم أو فقدان الشعور في نهاية المطاف، ويبدأ عادةً في أطراف أصابع القدمين أو أصابع اليدين وينتشر تدريجياً إلى الأعلى.

٣- **تلف في أعصاب أخرى:** يمكن أن يسبب الضرر الذي يلحق بأعصاب القلب مما يؤدي الى عدم انتظام ضربات القلب او تلف الأعصاب في الجهاز الهضمي إلى حدوث مشكلات مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال أو الإمساك ويمكن أن يؤدي تلف الأعصاب أيضاً إلى مشاكل جنسية.

٤- **ضمور العضلات (sarcopenia):** يرتبط مرض السكري بشكل مباشر بالفقدان المتسارع لقوة العضلات.

٥- **أمراض الكلى:** قد يؤدي داء السكري إلى الإصابة بمرض الكلى المزمن ومضاعفاته التي قد يتطلب اللجوء إلى غسيل الكلى أو زرع الكلى.

٦- **تلف العين:** يزيد داء السكري من خطر الإصابة بأمراض العين الخطيرة، ومنها إعتام عدسة العين والماء الازرق، وقد يسبب تلف الأوعية الدموية للشبكية، ومن المحتمل أن يؤدي إلى فقدان البصر.

٧- **الأمراض الجلدية:** قد يزيد داء السكري من احتمالات الإصابة ببعض مشكلات الجلد، منها العدوى البكتيرية اوالفطرية.

٨- **بطء التئام الجروح:** قد تتحول الجروح أو البثور في حالة عدم علاجها إلى أنواع خطيرة من العدوى قد لا تُشفى شفاءً مناسباً وقد يستلزم الضرر الشديد بتر إصبع القدم أو القدم أو الساق.

٩- **ضعف السمع:** تشيع الإصابة بمشاكل السمع أكثر بين المصابين بداء السكري.

١٠- **انقطاع النفس الانسدادي النومي:** تشيع حالة انقطاع النفس الانسدادي النومي بين الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. وقد تكون السمنة عامل الخطر الأساسي في الإصابة بالحالتين

١١- **مشاكل نفسية:** يزيد ارتفاع السكر في الدم المستمر ونوبات نقص السكر في الدم المتكررة من خطر الخلل الوظيفي الإدراكي وجميع أنواع الخرف وخطر الإصابة بالاكتئاب ويرتبط ضعف التحكم في مستويات سكر الدم بالتدهور السريع في الذاكرة ومهارات التفكير الأخرى.

تشخيص السكري:

١- **السكر في الدم بعد الصيام:** يساوي أو أكثر من ١٢٦ميلي غرام/ميلي لتر
٢- **السكر في الدم بعد الطعام:** يساوي أو أكثر من ٢٠٠ميلي غرام/ميلي لتر
٣- **سكر عشوائي:** يساوي أو أكثر من ٢٠٠ميلي غرام/ميلي لتر + ظهور أعراض
٤- **اختبار الهيموغلوبين السكري (HBA1C):** هو اختبار الدم إلى متوسط مستوى السكر في الدم خلال الشهرين الماضيين أو الأشهر الثلاثة الماضية وتشير نسبة ٦,٥% أو أعلى في اختبارين منفصلين الى الإصابة بداء السكري.

اهم ما يميز السكري لدى الكبار عدم وجود أعراض ، أو شيوع الأعراض غير النمطية للسكري ،مثل الأجهاد ،الالتهابات المتكررة ،السلس البولي او الهذيان

السكري والعناية بالقدمين:

إن العناية بالقدمين من المتطلبات الصحية الضرورية لاي فرد، وعند الاصابة بداء السكري تكون العناية بالقدمين أكثر ضرورة لان قدمي مريض السكر تتعرضان للجروح واللتهابات بسبب نقص الدورة الدموية وتلف أعصاب القدمين مما يؤدي إلى ضعف في الاحساس مع تنمل وخدر وإحساس بالبرودة وألالم.

اسباب مشاكل القدم السكري:

- اعتلال الاعصاب.
- قصور الدورة الدموية.
- زيادة الضغط على أماكن ارتكاز القدمين.
- الحذاء غير مناسب.
- إصابات القدمين.

الوقاية من مشاكل قدم السكري:

- التحكم الدقيق في معدل السكر في الدم هو المفتاح لتفادي المشاكل التي قد تصيب القدم.
- الالتزام بنصائح طبيب فيما يختص الغذاء الصحي، الامتناع عن التدخين، المحافظة على الوزن ،ممارسة التمارين الرياضية وتناول الدواء بأنتظام.
- فحص القدم يوميا وزيارة الطبيب فوراً عند الشعور بألم لمدة طويلة، أو التنميل، أو الوخز في أي جزء من القدم، ظهور أحمرار، تورم، التهاب، تشققات أو تقرحات مهما كانت صغيرة. (ممكن استخدام المرآة لفحص قاع القدم).
- غسل القدم يوميا بالماء الدافئ والصابون مع استخدام فرشاة جسم ناعمة جداً.
- قياس درجة حرارة الماء قبل الاستخدام ويفضل أن لا تزيد الحرارة عن ٣٧ درجة.
- تجفيف القدم جيدا وبرقة خصوصا ما بين الاصابع بفوطة ناعمة وربت عليها وعدم دعكها بقوة.
- المحافظة على جلد القدم ناعما وذلك بإضافة كريم أو سائل ترطيب وخاصة عند كعب القدم.
- المحافظة على القدم جافة، وإذا كانت من النوع الذي يعرق بسرعة ممكن استخدام بودرة خالية من أي إضافات طبية قبل ارتداء الحذاء والجوارب.
- ارتداء الجوارب المناسبة والمريحة ويجب أن لا تكون ضيقة أو مصنوعة من النايلون (يفضل أن تكون من القطن)
- تغيير الجوارب يوميا مع التأكد من خلوه من أي بقع دم.
- **عند شراء الاحذية يجب اختيارها بكل دقة بحيث تكون:**

١- مصنوعة من جلد ناعم أو قماش.
٢- أن لا تكون ضيقة وأن تكون أطول من إصبع القدم.
٣- للتأكد من أن المقاس مناسب تماما ارسم شكل القدمين على ورق مقوى ثم قص الشكل وادخله في الحذاء الجديد.
٤- لبس الحذاء الجديد بالتدريج ولساعات قليلة كل يوم.
٥- النظر في داخل الحذاء كل يوم والتأكد من عدم وجود تمزق أو خشونة أو أجسام غريبة مثل الحصى التي من الممكن أن تصيب القدمين. (استخدام اليدين لهذا الغرض وليس مجرد النظر)
٦- فحص قدمي المريض وحذائه يوميا وإذا كان المريض يعاني من ضعف البصر فعلى أحد من أفراد أسرته أن يقوم بمساعدته.
٧- تقليم الاظافر بعناية على شكل مستقيم وليس بشكل قصير جداً وليس باستدارة الظفر ومن الممكن استخدام مبرد لتسوية الاظافر.
٨- المحافظة على القدمين دافئة وتجنب تعريضها للبرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة.

٩- استشارة الطبيب عند وجود أي جروح في القدمين أو عند نمو الاظافر بداخل اللحم أو في حالة إصابة الاصابع أو القدمين بالفطريات وعند الاحساس بأي ألم أو تورم في القدمين أو بطان الساق.

ما هي الأشياء التي يجب الابتعاد عنها عند العناية بالقدم:

١- عدم استعمال أي أداة للعناية بالاظافر غير مقلم الاظافر (المقص مثلاً)
٢- تجنب محاولة إزالة الجلد السميك من القدم أو استعمال أدوات حادة لتنظيف القدمين أو أي أدوية لهذا الغرض قبل استشارة الطبيب.
٣- تجنب وضع القدمين في الماء لمدة طويلة. (لاتزيد عن ١٠دقائق)
٤- تجنب استخدام الماء الحار أو الكمادات الساخنة أو آلات المساج.
٥- تجنب وضع القدم على سطح ساخن جداً.
٦- تجنب المشي حافيا بدون حذاء.
٧- تجنب استخدام شريط لاصق أو مواد كيميائية على جلد القدم.
٨- تجنب المشي بأحذية مبللة.
٩- تجنب ارتداء الاحذية المكشوفة أو ما يعرف بالصنادل أو الاحذية الغير مريحة.
١٠- تجنب ارتداء الاحذية بدون جوارب.

دور القائمين على رعاية الكبار في المنزل:

١- الاهتمام بتوفير وجبات غذائية صحية للكبير والذي تتضمن الفواكة ،الخضروات ،اللحوم خالية الدسم ،الاسماك والحبوب الكاملة.
٢- مساعدة الكبير في تعزيز انماط الحياة الصحية مثل تشجيع الحركة والنشاط البدني والاندماج في الحياة الاجتماعية.
٣- توفير جهاز لقياس السكر في الدم ومتابعة قياسه.
٤- الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج بخصوص الادوية ومراجعاته الدورية.

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية:

١- تقييم العادات الغذائية وممارسة النشاط البدني.
٢- قياس السكر في الدم في كل زيارة منزلية.
٣- تدريب القائمين على رعاية الكبير في المنزل على الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز قياس السكر في الدم.
٤- التثقيف الصحي للكبير وعائلته حول :

- المرض ومضاعفاته وأهمية اتباع العلاج غير الدوائي للسيطرة على السكري، وتغير النمط الغذائي، وتشجيع ممارسة النشاط البدني.
- الرعاية الذاتية للسكري: رعاية القدمين والاهتمام بنظافتها وحمايتها من الجروح القطعية.
- الفحص الطبي المنتظم للعيون والكلى والقلب.

٥/ امراض الغدد الدرقية

يعد اختلال نشاط الغدة الدرقية من الامراض التي تؤثر وتتأثر بالحالة الصحية للكبار ويمكن علاجها.

اعراض اختلال نشاط الغدة الدرقية في الكبار:

١- من الممكن ان لا تكون هناك اي اعراض ترافق امراض الغدة الدرقية
٢- خمول الغدة الدرقية في الكبار من أهم أسباب الأعراض غير النمطية والتي يمكن علاجها بسهولة ،مثل الاكتئاب وزيادة الدهون بالدم والاجهاد غير المبرر والسمنة والامساك وفقر الدم.
٣- ازدياد نشاط الغدة الدرقية في الكبار من أهم أسباب الاعراض غير النمطية والتي يمكن علاجها
٤- بسهولة، مثل هبوط عضلة القلب واضطراب ضربات القلب.

ثانياً / المشاكل الصحية لدى كبار السن:

المشاكل النفسية

أن معظم كبار السن يتمتعون بصحة نفسية جيدة، إلا أن العديد منهم معرضون لخطر الإصابة باضطرابات نفسية، أو اضطرابات عصبية.

أهم العوامل التي تؤثر على الصحة النفسية لدى كبار السن:

١- يفقدون قدرتهم على العيش بصورة مستقلة، بسبب محدودية الحركة، أو الألم المزمن، أو الضعف.
٢- يكونون أكثر عرضة للمعاناة من الحوادث مثل مشاعر الحزن والحداد.
٣- انخفاض الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ظل التقاعد.
٤- العزلة، وفقد الاستقلال، والشعور بالوحدة، والضيق النفسي لدى الكبار.
٥- الاهمال البدني وسوء المعاملة.
٦- التراجع في نشاط الحواس خاصة النظر والسمع.
٧- الاصابة بالامراض المزمنة (القلب والشرايين, التنفسية, سكري, مفاصل, سرطان).
٨- الاثار الجانبية للادوية.

أهم المشاكل النفسية التي يعاني منها الكبار:

١/ الخرف

متلازمة تتسم ب:

١- حدوث تدهورتدريجي في الذاكرة وفي التفكير والسلوك.

٢- إضطراب الإدراك للزمان والمكان والأشخاص.

٣- تغير في الشخصية وتدهور في القدرة على أداء الأنشطة اليومية.

❖ **التدهور يحدث بوتيرة تتجاوزالتدهور المتوقع في مرحلة الشيخوخة العادية**

- **يؤثر سلباً على جودة الحياة للمريض والقائمين على رعايته حيث يواجهون مشاكل نفسية ,اجتماعية واقتصادية.**

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن الخرف

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
جميع المسنين سيصابون بالخرف خلال مراحل مختلفة من الشيخوخة	الخرف ليس جزءاً طبيعياً من التشيخ لكنه يصيب بشكل رئيسي الاشخاص المسنين.
كل انواع الخرف من نمط خرف الزهايمر	خرف الزهايمر هو اكثر انواع الخرف شيوعاً لكن هناك انواع اخرى للخرف تعتمد على الاسباب المرضية
لا توجد وسائل علاجية للتعامل مع خرف الزهايمر	علاجه يؤدي الى بطء تفاقم المرض والسيطرة على الاعراض

دور القائمين على تقديم الرعاية الصحية:

التثقيف الصحي للقائمين على الرعاية المنزلية للمريض المصاب بالخرف:

١- شرح طبيعة المرض ومراحل تطوره.
٢- متابعة تطور المرض وتشخيص اي مضاعفات او اعراض جديدة.
٣- متابعة الامراض المزمنة للمريض.
٤- توفير بيئة آمنة للمريض لتجنب الحوادث.
٥- عدم السماح له بالخروج بدون مرافق.
٦- مساعدة المريض على دخول الحمام بفواصل قصيرة ومتتابعة حسب جدول.
٧- عدم تغيير الطقوس التي يعتاد عليها المريض.
٨- تجنب سوء التغذية والجفاف والمضاعفات الناتجة عن قلة الحركة.
٩- تقديم التشجيع والدعم النفسي للقائمين على رعاية المريض للتعايش مع المشكلة.

اسباب الخرف :

١- خرف الزهايمر (يعتبر من أهم الاسباب)
٢- الخرف الوعائي الناتج عن قصور الدورة الدموية الدماغية او الجلطات الدماغية.
٣- الاقل شيوعاً الخرف الناتج عن الامراض العضوية او النفسية او الجراحية مثل:
   - نقص هرمون الغدة الدرقية.
   - نقص فيتامين ب١٢
   - الاكتئاب
   - تمدد الاوعية الدموية الدماغية
٤- الخرف المختلط الزهايمر+ الخرف الوعائي.

عوامل خطر الاصابة بالزهايمر:

١- التقدم بالعمر.
٢- العوامل الوراثية.
٣- أمراض عضوية كالسمنة ,ارتفاع الضغط والسكري.
٤- نقص فيتامين ب ١٢ وحامض الفوليك.
٥- التعرض للاصابات المزمنة في الرأس أو حالات التسمم ببعض المعادن.
٦- الاصابة بالاكتئاب.

عوامل تساعد على الوقاية من الاصابة بالزهايمر:

١- ارتفاع درجة التعلم
٢- التحكم الجيد بضغط الدم وسكر الدم
٣- ممارسة الرياضة
٤- الاندماج في الانشطة الاجتماعية

٢ / الهذيان

الهذيان هو تدهور مفاجيء في القدرة العقلية مع تدهور في الوعي وفقدان الانتباه، وهي حالة تشتد وتخف على مدى اليوم، وترتبط دائما بوجود مشكلة صحية حادة، وقد يصاحبها أحيانا اضطراب أو هياج.

الحالات الصحية المفاجئة التي تؤدى إلى حدوث الهذيان:

١- ارتفاع درجة الحرارة نتيجة لحدوث التهابات في أي جهاز من أجهزة الجسم.
٢- الجفاف .
٣- الاحتباس البولي الحاد.
٤- الانسداد المعوي الناتج عن الامساك المزمن.
٥- الالم بجميع أنواعه.
٦- تناول أدوية متعددة.
٧- تناول بعض الادوية، مثل أدوية الامراض النفسية والمضادة للحساسية.

الفرق بين الهذيان والخرف

الهذيان	الخرف
يبدأ بصورة مفاجئة	يبدأ تدريجياً
يرتبط باسباب مرضية حادة	ليس له سبب واحد ظاهري
متذبذب الحدة	يزيد تدريجياً وببطء
تزول اعراضه بزوال الاسباب المرضية	تسوء الاعراض ببطء
يحدث تدهور في الوعي	لا يحدث تدهور في الوعي

٣/ الاكتئاب

الاكتئاب من الأمراض النفسية الاكثر شيوعًا بين كبار السن، والذي قد يؤدي إلى ضعف في الأداء الجسدي والعقلي والاجتماعي، مما يزيد حدة الأمراض المزمنة ويؤخر التحسن ويزيد الأدوية المستخدمة.

أعراض الاكتئاب:

مرض الاكتئاب ليس مجرد حالة عابرة من الحزن، بل تتعدى ذلك ليواجه الشخص الأعراض التالية:

١- الحزن المستمر.
٢- الانسحاب من الأنشطة التي كانت ممتعة سابقاً.
٣- صعوبة في النوم.
٤- الشعور بعدم الراحة.
٥- اليأس.

تختلف اعراض الاكتئاب عند كبار السن عن الفئات العمرية الاخرى:

- ❑ منها التركيز على الموت والرغبة به
- ❑ وجود آلام الجسدية كآلام المفاصل والصداع اكثر من الحزن.

غالباً ما يتغاضى عن أعراض الاكتئاب لدى كبار السن ولا تتم معالجتها لأنها تتزامن مع امراض بدنية وتفسر على انها أعراض طبيعية ناجمة عن تقدم السن.

وجود الاكتئاب لدى المسن يؤثر سلبا على نتيجة المرض البدني ان وجد مثل أمراض الرئة أو ضغط الدم أو السكري ويقلل من الانتفاع بالخدمات الطبية، ويزيد تكاليف الرعاية الصحية.

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية في الكشف عن حالات الكآبة لدى الكبار:

- ❖ يقوم اعضاء الفريق بسؤال الكبير " هل تشعر احياناً كثيرة بالحزن او الاكتئاب؟
- ❖ اذا كان الجواب نعم يتم عمل " التقييم السريري للاكتئاب" **ملحق(٤)**.
- ❖ اذا كان مجموع النقاط أكثر من ٥ في التقييم السريري للاكتئاب يحال الى الطبيب.
- ❖ اذا كان مجموع مجوع النقاط أقل من ٥ في التقييم السريري للأكتئاب اذهب الى الرسائل صحية للمحافظة على الصحة النفسية للمسنين **صفحة ٣٦**

٤ / القلق

يرتبط القلق غالبًا بالاكتئاب، أي أن أغلب الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب يعانون القلق كذلك، ويصعب تشخيص القلق عند كبار السن لأنه غالبًا يظهر كأعراض جسدية وليس شكوى نفسية.

أعراض القلق:

١- الشعور المستمر بالخوف والتوترمن دون سبب واضح.
٢- الاستجابة المفرطة للمؤثرات الخارجية .
٣- عدم الاستقرار وعدم القدرة على التركيز .

٤- اضطراب في النوم أو اضطراب في الأكل (زيادة في تناول الطعام او بالعكس).
٥- اعراض جسدية مختلفة مثل: الصداع ، والتعب، وألم في الصدر وضيق في التنفس واعراض الجهاز الهضمي.
٦- العزلة الاجتماعية : ناتجة من فقد علاقاتهم مع العائلة والأصدقاء.
٧- استخدام الكحول وغيرها من المواد.

المفاهيم الخاطئة عن الاكتئاب والقلق لدى الكبار

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
الميل الى الاكتئاب أو الافراط في القلق ظاهرة طبيعية مع التقدم السن	الكبار يكونون أكثر اتزانا عاطفيا ونفسياً
في حال إصابة الكبار باضطراب نفسي فإن أستجابته للعلاج تكون محدودة	أستجابة الكبار للمعالجة النفسية لا تقل عن أستجابة غيرهم من الفئات العمرية الاصغر عمراً

رسائل صحية للمحافظة على الصحة النفسية للمسنين:

التواصل مع الآخرين:

- منح كبار السن الحب غير المشروط وبث الطمأنينة في نفوسهم وإشعارهم بأنهم ليسوا وحدهم، وحمايتهم من أي نوع من الإيذاء أو الاستغلال.

إيجاد المتعة في الأنشطة اليومية:

- تجنب العزلة ومشاركة المسنين في العمل والنشاط الاجتماعي.
- ممارسة هواية سابقة أو تجربة هواية جديدة.
- اللعب مع الأحفاد أو الحيوانات الأليفة المفضلة.
- تعلم شيء جديد (لغة أجنبية، لعبة جديدة).
- الانخراط في المجتمع (التطوع أو حضور حدث محلي).
- الانضمام إلى أندية صحية أو اجتماعية.
- السفر إلى أماكن جديدة.
- تغيير الروتين اليومي لكسر الملل وتجديد الطاقة، عن طريق الخروج في نزهات أو زيارات الى اماكن يحبها كبير السن.
- يشعر المسنون بعد التقاعد بالوحدة والفراغ، وقلة الجدوى في ظل انتهاء العمل الذي كان يمنحهم الشعور بالأهمية والقيمة، وهو ما يمكن ان يتطور مسبباً الاكتئاب، ولذا، فمن المفيد أشغال وقت فراغهم بأيٍ من الهوايات المفضلة لديهم كالحرف اليدوية البسيطة او كتابة مذكرات عن تجارب الحياة.

- العناية بإدراك وعقل المسنين يمثل أولوية كبرى، وذلك عن طريق تشجيع القراءة، ومناقشتهم واستشارتهم في أمور الحياة، وتشجيع صلة الرحم، مما يجعل أدمغتهم تعمل بطاقة أفضل، ويؤخّر المشاكل العقلية لديهم.
- تشجيع كبار السن على ممارسة النشاط البدني وحسب ما مذكور في الفصل التاسع.
- دمج كبار السن مع أشخاص قريبين منهم في العُمر، إذ يمنحهم ذلك التسلية والمودة والفهم.
- الاهتمام بتحضير الوجبات الصحية حيث تناول الفواكه والخضراوات تحسن الحالة النفسية على العكس من التغذية غير السليمة التي تؤثر سلبياً على الحالة المزاجية للكبار وتزيد من تفاقم الأمراض.
- في حالة الشك بالإصابة بأيٍ من الأمراض النفسية سابقة الذكر يجب الاسراع في طلب الاستشارة الطبية.

مشاكل العيون

تحدث التغيرات التالية في العينين مع التقدم في العمر:

- تتراجع مرونة عدسة العين، مما يجعل التركيز على الأجسام القريبة أكثر صعوبة.
- تصبح عدسة العين أكثر كثافة، مما يزيد من صعوبة الرؤية في الضوء الخافت.
- تستجيب الحدقة ببطء أكثر للتبدلات في الضوء.
- تصبح عدسة العين ذات لون أصفر، مما يُبدل من إدراك الشخص للألوان.
- تنتج العينان كميات أقل من السوائل، مما يجعلهما جافتان.
- قد تظهر حلقة بيضاء-رمادية (قوس الشيخوخة arcus senilis)على سطح العين تتكون هذه الحلقة من أملاح الكالسيوم والكوليسترول ولا تؤثر في القدرة على الرؤية.
- قد تغور العين في تجويف محجر العين بسبب تراجع كمية الدهون المحيطة بها.

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن مشاكل العيون لدى الكبار

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
ضعف حدة البصر هو المؤشر الجيد لتحديد قوة البصر	فحص حده البصر يجرى دائما في ظروف قياسية (غرفة فحص البصر)
عدم وجود قصور في حدة البصر يعنى عدم وجود ضعف بالبصر	أن حساسية البصر للإضاءة المتوهجة والاضاءة الخافتة أكثر دلالة على ضعف البصر من قياس حدة البصر
الاستعانة بالنظارة الطبية يكفي لتصحيح عيوب البصر وتأثيرها على الحياة الوظيفية للكبار	النظارة الطبية وحدها لا تكفي لتصحيح عيوب البصر لتلافي تأثير ضعف البصر على الكبار، ولابد من تكاتف فريق العمل مع المريض والعائلة والقائمين على تقديم الرعاية الصحية الاولية واختصاصي العيون واختصاصي البصريات للوصول الى أقصى درجة من التكيف والاستقلالية

١/ جفاف العين

هي حالة تحدث عندما تقل كمية او جودة الدموع في العين وبالتالي تقل درجة رطوبة العين وتؤثر في الرؤية.

اعراض جفاف العين:

١- حرقــة فــي العـين آلام كـالـوخـــــزات
٢- إحمـــرار العينيـــن
٣- إرهـــــاق العـيـــــن او صعوبــة الرؤيــة
٤- الشعور بوجود جسم غريب في العين
٥- حساسية من الضوء

عوامل خطورة جفاف العين:

١- تـقـدم العمر
٢- بعض الادوية العلاجية تسبب جفاف العين (مثل مضادات الحساسية , مضادات الاحتقان , بعض ادوية ضغط الدم او مضادات الأكتئاب)
٣- اصابة الغدة الدمعية
٤- عمليات الليزر والليزك (مؤقتاً)
٥- استخدام العدسات اللاصقة لساعات طويلة

يجب مراجعة الطبيب في حالة احمرار او ألم في العين او اختلاف في الرؤية

٢/ داء الزرقاء (الجلوكومـا)

داء الزرقاء هي مجموعة من العوامل التي تلحق الضرر بالعصب البصري، الذي يعد صحته ضرورية للرؤية بصورة جيدة. يحدث هذا الضرر غالبا بســبب ارتفاع الضغط بشكل غير طبيعي في العين.

- **هو ثانـي مـسبـب لـلإصـابـة بالـعـمى عـالـمـياً**
- **لايوجد أعــراض واضحة في المراحل المبكرة**
- **يزيد معدل الإصابـــة مع التقدم في العمر**
- **الوراثة العائلية تزيد من خطر الإصابة بالجلوكوما**
- **استخدام قطرات الكورتيزون بدون إشراف طبي يؤدي إلى ارتفاع ضغط العين**

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية:

١- إجراء فحص دوري كل سنة على الأقل
٢- التحكم بالحالات الطبية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم
٣- اذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض ينصح بفحص جميع أفراد العائلة مبكراً

٣/ الماء الابيض (الساد)

١- وجود غشاوة على العين

٢- عدم القدرة على تحمل الضوء الساطع
٣- ضعف تدريجي في البصر بدون ألم
٤- تغيّر لون بؤبؤ العين من الأسود الطبيعي إلى الرمادي أو الأبيض

عوامل تزيد من احتمالية الإصابة:

١- التقدم في العمر
٢- العامل الوراثي
٣- التدخين
٤- السكري
٥- أصابة او جراحة سابقة في العين

قد يسبب مرض الساد العمى إذا لم يتم اجراء عملية جراحية

٤/ اعتلال الشبكية السكري

يعتبر من احد المضاعفات الي قد يسببها مرض السكري

اعراض اعتلال الشبكية السكري:

١- ضعف تدريجي او مفاجيء في النظر.
٢- ظهور أجسام متحركة او وميض او عتمة في مجال البصر
٣- ألم بداخل العين
٤- ازدواجية في الرؤية

قد لا تظهر هذه الاعراض إلا في الحالات المتقدمة

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية:

توعية القائمين على رعاية الكبار في المنزل بخصوص الوقاية من المرض من خلال :
١- المحافظة على مستوى السكر الطبيعي في الدم والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.
٢- يجب مراجعة طبيب اختصاص عيون سنوياً عند بداية التشخيص بالسكري وبشكل دوري
٣- الامتناع عن التدخين.

٥/ قصو البصر الشيخوخي

هو الفقدان الطبيعي لقدرة التركيز القربية التي تحدث للجميع تقريباً بعد عمر الاربعين.

يجب فحص عيون جميع الكبار بواسطة طبيب أخصائي او تقني بصريات كل سنه للكشف عن أكثر اضطرابات العين شيوعا على سبيل المثال، داء الزرقاء وعتمة عدسة العين، واضطرابات الشبكية

دور القائمين على تقديم الرعاية الصحية للكبار في تقديم الارشادات العامة للحفاظ على سلامة العيون:

١- فحص العيون بشكل دوري كل سنة.
٢- حماية العيون عند التعرض للادخنة او الابخرة الضارة.
٣- تناول الغذاء الصحي المحتوي على الخضروات الورقية والاسماك (سمك التونا ,السردين والسلمون)

٤- الإكثار من شرب الماء واستخدام قطرات العين المرطبة عند الحاجة لتجنب الجفاف.
٥- التحكم بـالأمراض المزمـنة: مثـل داء السكري وضغط الدم.
٦- الحـرص على اتبـاع تعليمـات السلامة عند استخدام العدسات اللاصقة المناسبة للنظر.
٧- الامتناع عن التدخين.
٨- مراجعة الطبيب عند وجود: احمرار، حكة، إفرازات، آلام، أو أعراض غريبة في العين.
٩- حماية العين من أشعة الشمس من خلال ارتداء النظارات الشمسية عند التعرض لأشعة الشمس خصوصًا في وقت الذروة.
١٠- عدم لمس العين إلا بعد غسل اليدين بالماء والصابون.
١١- عدم الجلوس لوقت طويل أمام شاشة التلفاز.
١٢- استخدام إضاءة مناسبة في الغرفة عند القراءة.
١٣- الحصول على فترة كافية من النوم في الليل، وتجنب السهر.
١٤- القيام بتمارين العين التي تسهم في تقوية النظر، ومن هذه التمارين: الإمساك بقلم وتركيز النظر عليه، وتقريبه إلى الأنف بشكل تدريجي، ثم إبعاده عن العين لأقصى مدى؛ حيث إن هذا التمرين يساعد على تقوية النظر.

مشاكل السمع

يعتبر ضعف السمع ثالث أكثر الامراض المزمنة انتشارا في مرحل الشيخوخة، حيث تبلغ نسبته ١٦% لدى الكبار (الاكبر من ٦٠عاما) وتصل إلى ٦٤% لدى الكبار (الاكبر من ٨٠عاما).

التغيرات التي تحدث في السمع مع تقدم العمر:

١- تلف الخلايا العصبية بالاذن الداخلية.
٢- تكلس الاغشية والالياف العصبية الحسية في الاذن الداخلية.
٣- تلف الخلايا السمعية بالمخ.

تؤدي تلك التغيرات إلى:

١- صعوبة سماع الاصوات النقية.
٢- صعوبة تمييز الاصوات.
٣- صعوبة تمييز الكلام وفهمه.

فقدان السمع عند كبار السن يمكن أن يؤثر سلباً على الرفاه الجسدي والعاطفي والمعرفي

ضعف السمع وتأثيره على الكبار:

١- يؤدي ضعف السمع لدى الكبار الى صعوبة التواصل مع البيئة المحيطة به مما يدعوه إلى العزلة والاكتئاب.
٢- يعرض ضعف السمع لدى الكبار الى الاصابه بمخاطر حيث يصعب عليه تمييز ومعرفة مصادر الصوت ومنها أصوات الانذار أو التنبيه.
٣- يؤدي ضعف السمع لدى الكبار الى فقدان الاستقلالية وزيادة الاعتماد على الاخرين في أنشطة الحياة اليومية.

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن مشاكل السمع لدى الكبار

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
الأعاقة السمعية هي تغير طبيعي يظهر مع تقدم العمر	ضعف السمع هو التغير الطبيعي مع تقدم العمر وليس الأعاقة السمعية
عادة ما يشكو ويشعر المسن عندما يصاب بضعف السمع	المسن قد يشعر بوجود قصور في تأدية أنشطة حياته اليومية، ولكن عادة لا يدرك أن ذلك من الممكن أن يكون مرتبطا بضعف السمع
لا توجد فائدة من استخدام سماعة الاذن مع تقدم العمر	سماعة الاذن من الوسائل المساعدة التي تحسن جودة حياة المسن

١/ صمم الشيخوخة

عبارة عن فقدان سمع عالي التردد وتدريجي وهو أكثر أسباب ضعف السمع شيوعا بين المرضى الكبارحيث يقلل من القدرة على تفسير الكلام الذي يمكن أن يؤدي إلى تناقص قدرة التواصل مما يترتب عليه زيادة خطر العزلة الاجتماعية والاكتئاب.

اعراض صمم الشيخوخة:

١- يطلب عادة تكرار الكلام.
٢- يرفع مستوى صوت الراديو او التلفاز.
٣- يلقى صعوبة في التواصل وفهم المحادثات الجماعية مع الاهل والاصدقاء.
٤- يلقى صعوبة في فهم ما يقال عبر الهاتف.
٥- يلقى صعوبة في سمع اصوات جرس الباب , المنبه او رنين الهاتف.
٦- يشعر رنين في الاذن (طنين الاذن).
٧- عادة ما يتكلم بصوت مرتفع.

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية:

١- مراجعة الطبيب المختص في حالة ظهور اعراض الصمم الشيخوخي.
٢- توعية القائمين على رعاية الكبار في المنزل بخصوص ما يلي:

- التحدث معه وجهاً لوجه.
- تجنب تغطية الوجه اثناء الحديث.
- التأكد من توفر اضاءة جيدة في المنزل.
- عدم التحدث معه وانت تأكل.
- التحدث بصوت عالي وواضح وتجنب الصراخ.
- الانتباه الى طريقة نطق الكلمات.
- تقليل معوقات التواصل مثل (صوت التلفاز او الراديو , الضوضاء.....).

٢/ المشاكل المتعلقة بأستخدام المعينة السمعية

اذا كان المسن يرتدي المعينة السمعية فيجب أن تزال وتفحص حيث أن قالب الأذن وأنابيب البلاستيك يمكن أن تسد بالشمع أو قد تكون البطارية منتهية المفعول ويعرف ذلك من غياب صوت صفارة عند رفع حجم صوت المعينة السمعية.

الحاجة الى اعادة فحص السمع وبرمجة المعينة السمعية بصورة دورية وقالب الاذن يستبدل كل سنتين الى ثلاث سنوات.

مشاكل الجهاز الهضمي

١/ مشاكل الفم

جفاف الفم : يسبب جفاف الفم التهاب اللثة ,تسوس الاسنان وصعوبة البلع.

ضعف حاسة التذوق : يؤثر التقدم في العمر على حاسة التذوق كما يتأثر التذوق بعدد من الامراض أهمها:

- تسوس الأسنان
- التدخين
- جفاف الفم
- التهاب الجيوب الانفية
- نقص فيتامين B12.
- يتأثر التذوق ببعض الادوية مثل المضادات الحيوية

فقدان الاسنان: تعتبر من اهم المشاكل التي يعاني منها الكباروالتي تحدث بسبب تسوس الاسنان او امراض اللثة.

٢/ متلازمة القولون العصبي:

يعتبر من اضطربات الجهاز الهضمي الاكثر تشخيصاً، وهواضطراب وظيفي يتميز بألم متكرر في البطن وتغير في حركة الامعاء بين الامساك والاسهال مما يؤثرعلى عمليات الهضم والامتصاص ولايوجد سبب واحد متفق عليه ولكن هناك عدة اسباب تؤدي الى حدوثه منها تغير في حركة الامعاء الطبيعية والقلق والاكتئاب وغيرها.

٣/ الامساك

الامساك من أهم المشكلات الصحية التي تؤثر على جودة الحياة لدى الكبار، واكثرها شيوعاً ومن الأخطاء الشائعة اعتبار الامساك مشكلة حتمية لدى الكبار

الامساك هو صعوبة التغوط والتي تتميز بقلة حركات الامعاء وكذلك يعرف الامساك بالتغوط اقل من ٣ مرات بالاسبوع حيث ان معدل حركة الامعاء الطبيعي من ٣ مرات في اليوم الى ٣ مرات في الاسبوع.

اسباب الامساك:

١- الطعام:

- ❖ قلة تناول الطعام.
- ❖ تناول اطعمة قليلة الالياف.
- ❖ شرب كميات قليلة من السوائل.

٢- قلة الحركة بسبب:

- ❖ المرض.
- ❖ الالم.
- ❖ نمط حياة خاملة.
- ❖ الكبير الراقد في السرير لدخوله في المستشفى.

٣- قلة الذهاب الى التواليت:

- ❖ التواليت في مكان غير ملائم.
- ❖ التواليت غير مريح.
- ❖ انعدام الخصوصية.
- ❖ طول المسافة الى التواليت.
- ❖ (جميع العوامل آنفاً تؤدي الى خمول ارادي وارتداد الغائط)

٤- ادوية تسبب الامساك ومنها:

- ❖ الادوية المنومة.
- ❖ ادوية الامراض النفسية.
- ❖ الادوية التي تحتوي على الحديد او الكالسيوم.
- ❖ بعض ادوية المضادات الحيوية
- ❖ الاستخدام المزمن للمليناات.
- ❖ مضادات الحموضة.
- ❖ بعض الادوية المدررة.

٥- اسباب كيميائية واخرى تتعلق بالغدد الصماء ومنها:

- ❖ زيادة الكالسيوم في الدم.
- ❖ انخفاض قاعدية الدم.
- ❖ خمول الغدة الدرقية.
- ❖ زيادة نشاط الغدة جنب الدرقية.

٦- امراض الجهاز الهضمي ومنها:

- ❖ تهيج القولون
- ❖ الانسداد بسبب سرطان القولون، وجود زوائد أو تضيق في القولون.
- ❖ امراض الشرج مثل فطر شرجي او البواسير.

٧- اسباب عصبية ومنها:

- ❖ امراض الحبل الشوكي
- ❖ تليف الاعصاب المنتشر
- ❖ جلطة دماغية.

٨- اسباب نفسية ومنها:
- ❖ الكأبة أو الانعزال.
- ❖ النسيان والذهان.

مضاعفات الامساك:

١- الجهاز الهضمي:
- ❖ الانسداد او انحشار الغائط.
- ❖ القولون المتضخم.
- ❖ عدم السيطرة على الغائط.
- ❖ هطول المستقيم .
- ❖ البواسيرالشرجية.
- ❖ فقدان الشهية اوالتقيؤ.

٢- الجهاز البولي:
- ❖ انحباس البول.
- ❖ عدم السيطرة على الادرار.
- ❖ التهاب المجاري البولية.

٣- اخرى : مثل القلق والاكتئاب ، عدم انتظام دقات القلب.

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية في التعامل مع مشاكل الجهاز الهضمي:

توعية كبار السن والقائمين على رعايتهم حول:

➢ جفاف الفم:

- ينصح بتناول كميات كافية من السوائل يوميا.
- ينصح بتناول الاطعمة الطرية اوالمهروسة.
- تجنب تناول الاطعمة الجافة او الخشنة جدا.

➢ ضعف حاسة الذوق:

تحسين مذاق الطعام عن طريق اضافة الاعشاب العطرية او التوابل بكميات معتدلة.

➢ صحة الاسنان:

- تنظيف الأسنان بفرشاة اسنان ناعمة مرتين يوميا على الأقل واستعمال كمية صغيرة من معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد.
- استعمال خيوط الأسنان بعد كل وجبة.

- غسل الفرشاة بانتظام واستبدالها كل ثلاثة شهور.
- تجفيف الفرشاة في الهواء ،حتى لا تنمو عليها البكتيريا وحفظها غير مغطاة.

➢ العناية بالاسنان الصناعية:

- خلع الأسنان الصناعية بعد كل وجبة وغسلها وتنظيفها واللثة مرتين يومياً باستعمال الماء والصابون.
- خلعها في الليل وحفظها في كوب فيه ماء.
- استشارة طبيب الأسنان إذا كانت غير ملائمة للفم بشكل جيد، أو سببت آلاماً أو تقرحات أو التهابات بالفم، ويفضل أن تكون زيارة طبيب الأسنان سنوياً.

➢ الامساك:

- تناول كميات كافية من الاطعمة الغنية بالالياف مثل: الحبوب الكاملة (الخبز الاسمر، البرغل) ، الخضروات الطازجة والفواكه (الخيار ، التين، الخوخ) والفواكه المجففة (المشمش)، المكسرات.
- اضافة زيوت نباتية مثل زيت الزيتون للطعام.
- شرب المشروبات الساخنة قبل نصف ساعة من الدخول الى الحمام.

➢ متلازمة القولون العصبي:

- تجنب الاطعمة الدسمة والمشروبات الغازية.
- تجنب الاستلقاء بعد النوم مباشرة.
- تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيدا.
- ينصح باستخدام الاكواب لشرب السوائل.
- تجنب الاطعمة المحتوية على مواد غذائية مسببة للغازات وهذه الاطعمة تختلف من شخص لأخر مثل: (البصل، الفاصوليا، العدس، الذرة، القرنبيط، الحليب وغيرها).
- ينصح بشرب شاي اليانسون لما له من تاثير جيد على تقليل الانتفاخ.

➢ مشاكل الجهاز التنفسي

الجهاز التنفسي من أجهزة الجسم الحيوية التي يتأثر بها أعضاء كثيرة بالجسم وأحد أهم الأمراض الحادة التي تصيبه هو الالتهاب الحاد وأهم الأمراض المزمنة هي الامراض التنفسية الانسدادية المزمنة

➢ التغيرات التي تحدث للجهاز التنفسي مع التقدم في العمر:

- ❖ تقلص في الحويصلات الهوائية وسطح التبادل الغازي.
- ❖ فقدان مرونة القفص الصدري.
- ❖ ضمور عضلات التنفس وانخفاض قوة عضلة الحجاب الحاجز.

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن مشاكل الجهاز التنفسي لدى الكبار

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
يبالغ العديد من الكبار بأعراض الجهاز التنفسي لأسباب متعددة مثل القلق	العكس هو الصحيح فقد لا يبالي معظم الكبار بأعراض الجهاز التنفسي
مشاكل الجهاز التنفسي سهلة التشخيص والعلاج	غالبا ما تكون الاعراض غير نمطية مثل السقوط المتكرر أو الهذيان او أعراض النمطية مثل ضعف التنفس أثناء النوم ,ضعف عضلة القلب او ارتجاع المرئ
وجود ضيق النفس أو السعال البسيط يعني أن المرض بسيط	شدة الأعراض لدى الكبار كثيراً ما تكون غير مرتبطة بشدة المرض
السعال عرض مزمن عند كل كبار السن لهذا لا يجب الاهتمام به	فينبغي السؤال عن السعال والأهم هو السؤال عن تغير في نمط السعال

١/ الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي من أهم الأمراض المعدية التي تؤدي إلى حدوث الوفاة لدى الكبار.

عوامل الخطر للاصابة بمرض الالتهاب الرئوي:

- تقدم العمر.
- ارتجاع المريء.
- وجود قصور في الوظائف المعرفية.
- التدخين.
- شرب الكحول.
- أمراض القلب.
- أمراض الجهاز التنفسي.
- السكري.
- سوء التغذية.
- استعمال أنبوب التغذية عبر الأنف إلى المعدة.
- استعمال أجهزة التنفس الصناعي.
- المعالجة بالأدوية المثبطة للمناعة.
- وجود صعوبة في البلع.

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية في التعامل مع الالتهاب الرئوي:

- التأكد من جدول اللقاحات.
- الوعي بعوامل خطورة الألتهاب الرئوي وتفاديها.
- الوعي بالأعراض والعلامات النمطية (ضيق النفس ,السعال ,الحمى ,ألم الصدر) والغير نمطية (الخمول ,السقوط المتكرر ,الهذيان ,الدوار ,فقدان الشهية).

❖ الوعي باجراءات مكافحة العدوى الأساسية.

٢/ الامراض التنفسية الانسدادية المزمنة

مجموعة من ألامراض التنفسية تتميز بالسعال، وضيق التنفس، والالتهابات التنفسية المتكررة، وكثرة البلغم

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن الامراض التنفسية الانسدادية المزمنة لدى الكبار

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
السعال المزمن وضيق التنفس جزء من الشيخوخة الطبيعية	السعال المزمن وضيق التنفس يخفيان امراضاً ينبغي علاجها أو تقليل مضاعفاتها
لا توجد فائدة من الاقلاع عن التدخين بعد التقدم في العمر	التدخين هو أهم عامل يسبب الامراض خصوصاً التنفسية منها

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية في التعامل مع الامراض التنفسية الانسدادية المزمنة لدى الكبار:

❖ التوعية بالمرض وبالمفاهيم الخاطئة عنه.
❖ التأكيد بضرورة الاقلاع عن التدخين.
❖ التوعية بفائدة فقدان الوزن الزائد ومعالجة السمنة المفرطة.
❖ الرصد المبكر لأي زيادة في حدة المرض وعلاجها المبكر.
❖ التأكيد على حصول الكبار وذويهم ومن يقدم الرعاية الصحية لهم على التطعيم بلقاح الانفلونزا ولقاح المكورات الرئوية المقترن.

مشاكل الجهاز البولي

١/ السلس البولي

نزول البول بشكل غير إرادي ومن دون سيطرة

انواع سلس البولي :

١- سلس بولي حاد مؤقت (اذا مر عليه أقل من ستة أسابيع)

اسبابه:

- ادوية مرض الهذيان.
- احتباس البول بسبب انسداد أو ارتخاء المثانة نتيجة الامراض وتناول الادوية.
- صعوبة الحركة.
- الامساك وتحجر البراز.
- التهابات الجهاز البولي.

- كثرة التبول بسبب الاصابة بالسكري.
- كثرة تناول السوائل.
- فشل أو قصور القلب.
- تناول الادوية المدررة للبول.

٢- سلس بولي مزمن (اذا مر عليه أكثر من ستة أسابيع)

انواعه:

- **سلس الشدة أو الضغط:** ويحدث عند ارتفاع الضغط داخل جدار البطن بسبب السعال أو العطس أو الضحك أو الجري أو حمل الأثقال بسبب ضعف عضلة التحكم بالتبول في المثانة وأشهر أسبابه الولادة المتعسرة أو تكرار الحمل والولادة أو بعد سن الامان لغياب الهرمون الأنثوي في السيدات وبعد جراحة البروستات وهنا تكون المثانة طبيعية.
- **السلس الطارئ المفاجئ:** ويحدث نتيجة خلل المثانة، حيث تنقبض فجأة لا إرادياً مفرغة ما بها من بول لخلل في عضلة المثانة أو العصب المغذى لها، وهنا تكون عضلة التحكم في التبول سليمة وتكون المثانة زائدة النشاط وتتعدد مرات التبول أكثر من ٨ مرات نهاراً والاستيقاظ ليلاً عدة مرات للتبول.

  يصاب المريض بهذا النوع نتيجة تضرر أعصاب المثانة أو أجزاء أخرى من الجهاز العصبي، أو حتى تضرر عضلات أسفل الحوض.
- **السلس المركب:** وهو نوع مركب من النوعين السابقين معاً.
- **السلس الاحتباسي:** يحدث عندما تمتلئ المثانة تماما ويكون هناك مانع أو مقاومة لإفراغها مثل ضيق عنق المثانة وضيق قناة مجرى البول والتضخم الشيخوخي للبروستات فإن البول الزائد على الحد الأقصى لسعة المثانة يخرج لا إرادياً.
- **سلس الإصابات:** يفقد المصاب السيطرة على المثانة في حالات إصابة العمود الفقري ومرض باركنسون وجلطة الدماغ وأورام المخ.

اعراض السلس البولي:

١- الشعور بالحاجة الملحة لتفريغ المثانة بصورة مفاجئة.
٢- الشعور بالألم والحرقة اثناء التبول.
٣- زيادة كبيرة في وتيرة التبول.
٤- تسرب البول بصورة متفاوتة اثناء الضحك ,العطاس ,الانتقال من وضعية الجلوس الى الوقوف.
٥- الاستيقاظ من النوم ليلاً ٣-٤ مرات لغرض تفريغ المثانة.

المشاكل التي تواجه المصاب بالسلس البولي:

١- يحد المريض من نشاطاته اليومية حتى لا يبتعد عن المرحاض.
٢- يميل الى العزلة بسبب الاحراج.
٣- من الممكن ان يصاب بالقلق والاكتئاب.

٤- مشاكل جلدية مثل الاحمرار او التقرح نتيجة لتحلل مادة اليوريا الموجودة في البول لتنتج مادة قلوية تشكل بيئة مناسبة لتكاثر البكتريا والفطريات.

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية في التعامل مع السلس البولي :

١- استخدام تقييم السلس البولي **ملحق(٥)**.
٢- السؤال عن التاريخ المرضي حول السلس ومدته وشدته ومسبباته وتوقيت حصوله، وتلازمه مع الضغط في البطن أو حصوله تلقائياً بدون ضغط أو اقترانه بالالحاح الشديد على التبول مع عدم التمكن للوصول إلى الحمام بسرعة قبل تسرب البول ودرجة تبللها بالبول، تاريخ الولادات وعددها ومدتها بالنسبة للنساء والاصابة بداء السكري أو أمراض اخرى قد يكون لها علاقة بالسلس أو الافراط في شرب السوائل خصوصاً التي تدّر البول كالقهوة والشاي وبعض المرطبات
٣- السؤال التفصيلي عن الادوية التي يتناولها
٤- تقوية عضلات الحوض بممارسة (تمارين كيجل) **ملحق (٦)**.
٥- نصائح مهمة للقائمين على رعاية الكبار في المنزل لمساعدة كبار السن المصابين بالسلس البولي:

- تقييم البيئة المحيطة مثل سهولة التنقل والوصول للمرحاض.
- تذكير المريض بالذهاب الى المرحاض بشكل دوري.
- مساعدته للذهاب الى المرحاض و مساعدته على خلع ثيابه وارتدائها والجلوس على كرسي المرحاض.
- الانتباه للعلامات الغير لفظية مثل كثرة الحركة التي تشير الى ان الشخص بحاجة للذهاب الى المرحاض خاصة عندما لا يكون المريض قادراً على تمييز الاحساس بأمتلاء المثانة.
- تجنب الباس المريض البسة ذات مثبتات معقدة مثل الجينز ذي الازرار ويفضل استعمال البسة ذات مطاط حول الخصر.
- ترك باب الحمام مفتوح ومضاء و وضع صورة للمرحاض او اشارة تدل عليه خصوصاً للمصابين بالخرف.
- تجنب الاطعمة الحارة و المتبلة بالبهارات.
- الابتعاد عن شرب الشاي ,القهوة او الكولا مساءاً.
- الاكثار من اكل الخضروات والفواكة ويفضل ان تكون مقطعة قطع صغيرة.

٢/ الجفاف

الجفاف من أهم المشاكل التي يسهل حدوثها لدى الكبار والتي تؤدي الى تكرار دخولهم الى المستشفيات وحدوث المضاعفات في الكلى.

العوامل المؤدية لحدوث الجفاف لدى الكبار:

- نقص الاحساس بالعطش وهو تغير طبيعي يزداد مع التقدم في العمر.
- نقص قدرة الكلى على الحفاظ على توازن السوائل.

- انخفاض نسبة السوائل في الجسم مع تقدم العمر.

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية:

التثقيف الصحي للكبار وعوائلهم حول أهمية تناول السوائل بكثرة تبعاً للحالة المرضية، والعلاج السريع للامراض التي تؤدي إلى فقدان السوائل مثل:

- النزلات المعوية مثل الاسهال.
- الحمى.
- ارتفاع سكر الدم.
- استخدام ادوية مدرارت البول.

٣/ التهاب المجاري البولية

يعتبر التهاب المجاري البولية ثاني اكثر الأسباب انتشاراً بين حالات العدوى لدى الكبار بعد التهابات الجهاز التنفسي

اسباب حدوث التهاب المجاري البولية لدى الكبار:

- التغيرات في الجهاز التناسلي للمرأه وتضخم البروستات في الرجال
- انخفاض المناعة لدى الكبار خاصة المصابين بالسكري واستخدام القسطرة البولية.

اعراض التهاب المجاري البولية لدى الكبار:

١- قد يكون دون اي اعراض.
٢- اعراض نمطية مثل الالم عند التبول والحمى وتعدد مرات التبول خلال اليوم.
٣- اعراض غير نمطية مثل سلس البول , فقدان الشهية او الهذيان.

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية:

١- العمل على تفادي تكرار الالتهابات بالتثقيف الصحي ومتابعة عوامل الخطورة مثل تضخم البروستات ,الحصى ,هبوط الرحم لدى النساء واستخدام القسطرة البولية.
٢- التثقيف الصحي للمرضى الذين يستخدمون قسطرة بولية لتفادي الالتهابات المتكررة في المجاري البولية.

مشاكل الجهاز العضلي العظمي

١/ هشاشة العظام لدى الكبار

يعرف المرض على انه قلة كثافة وجودة العظام, حيث تصبح العظام هشة ويزداد خطر كسرها إلى حد كبير.

في كثير من الأحيان لا توجد أعراض للمرض حتى يحدث الكسر الأول , يزيد احتمال حدوث هذه الكسور في الورك والعمود الفقري وعظم الرسغ، مع تقدم العمر لدى النساء والرجال على حد سواء.

عوامل الخطر للإصابة بمرض هشاشة العظام :

عوامل غير قابلة للتغيير:

- التقدم في العمر
- الجنس الانثوي
- وجود تاريخ مرضي عائلي.
- تاريخ الكسر السابق

عوامل قابلة للتغيير:

- قلة النشاط البدني.
- نقص الوزن.
- نقص الكالسيوم.
- نقص الفيتامينD.
- تعاطي المشروبات الكحولية.
- التدخين والتدخين السلبي.
- تناول بعض الادوية مثل الكورتيزون ، مضادات الذهان ،مضادات الصرع ومضادات الحموضة.
- الاصابة ببعض الامراض مثل سوء الامتصاص ، التهاب المفاصل الرثوي،امراض الدم السرطانية واضطربات الغدد الصماء.

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن هشاشة العظام

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
الالم يعتبر من أهم أعراض هشاشة العظام	مرض هشاشة العظام غير مؤلم، والكسور الناتجة عنه هي المسببة للالم
الآم المفاصل وأسفل الظهر تحدث بسبب هشاشة العظام	هشاشة العظام لا تسبب تلك الآلام الا إذا حدثت الكسور
تناول منتجات الالبان بكثرة يغنى عن المكملات الغذائية من الكالسيوم وفيتامين D .	الوقاية من هشاشة العظام تزداد بتناول المكملات الغذائية من الكالسيوم وفيتامين D حسب ارشادات الطبيب الاختصاص والتغذية الصحية.
الرياضة ممنوعة على مرضى هشاشة العظام	تعتبر الرياضة من عوامل الوقاية من هشاشة العظام ويمكن اختيار النشاط البدني المناسب لكل شخص

أهمية فيتامين D في بناء العظام :

فيتامين D ضروري لبناء العظام من خلال المساعدة في امتصاص الكالسيوم من الطعام في الأمعاء، وضمان التجديد المستمر وادخال المعادن الى الأنسجة العظمية.

مصادر فيتامين D :

❖ فيتامين D من التعرض لأشعة الشمس:

فيتامين D يصنع في الجلد عندما يتعرض للأشعة فوق البنفسجية نوع B; في الأطفال والبالغين تعرض الآيدي والوجه والذراعين لأشعة الشمس لمدة ١٠ إلى ١٥ دقيقة يوميا عادة ما تكون كافية لمعظم الأفراد. ومع ذلك، فإن كمية فيتامين D التي يتم إنتاجها من أشعة الشمس تعتمد على الوقت من اليوم، المكان الذي يعيش فيه الانسان ولون البشرة.

❖ فيتامين D من الطعام والمكملات الغذائية:

١- المصادر الغذائية محدودة إلى حد ما، وتشمل الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والبيض والكبد، وفي بعض البلدان الأطعمة المدعمة مثل الزبدة والألبان والحبوب.
٢- نظرا للعيش في الأماكن المغلقة لمعظم كبار السن، و قلة أشعة الشمس في أشهر الشتاء، والعوامل الفسيولوجية المختلفة المتعلقة بالشيخوخة، فمن الشائع جدا لكبار السن أن يكون هناك نقص في فيتامين D لذلك نوصي بتناول ٦٠٠ وحدة دولية من فيتامين D يومياً.

توصي منظمة الصحة العالمية ومنظمة هشاشة العظام العالمية بأجراء فحص كثافة العظام (دكسا) لكبار السن كما يلي:

١- كل النساء بعد عمر ٦٥ سنة والرجال بعد عمر ٧٠ سنة.
٢- كل النساء اقل من ٦٥ سنة او الرجال اقل من ٧٠ سنة مع وجود عوامل خطر الاصابة بهشاشة العظام.
٣- المرضى الذين يتناولون دواء الكورتيزون لفترات طويلة (١٥ ملغم يومياً لمدة ثلاثة اشهر).
٤- تكرار الفحص كل ثلاث سنوات اذا كان الكبير مصابا بهشاشة العظام ، ويكرر كل خمس سنوات لكبار الاصحاء.

توصيات للوقاية من هشاشة العظام:

١- الاقلاع عن التدخين.
٢- التوقف عن تعاطي المشروبات الكحولية.
٣- الحرص على تناول الاطعمة التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين D والبروتين.
٤- تقليل شرب المواد التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة, الشاي والامتناع عن المشروبات الغازية.
٥- ممارسة الرياضة خصوصاً رياضة القوة والاتزان.
٦- تناول الليمون والبرتقال مع الاطعمة التي تحتوى على الكالسيوم لمساعدة الامتصاص.

٧- تناول ٦٠٠ وحدة دولية من فيتامين D يومياً.
٨- التعرض لاشعة الشمس.

٢/ السقوط المتكرر لدى الكبار

تعريف السقوط:

يعرف على انه حادثة تؤدي الى انهيار الشخص دون قصد على الارضية او سطح الارض او اي مستوى متدن اخر

عوامل خطر السقوط:

١- عوامل طبية :
- ضعف العضلات و هشاشة العظام وامراض المفاصل.
- عدم انتظام ضربات القلب وهبوط الضغط عند الوقوف.
- القلق ، التوتر ، الاكتئاب او مرض الخرف.
- عدم الاتزان نتيجة امراض الاعصاب او الاذن الوسطى.
- الجلطات الدماغية ومرض باركنسون.
- مشاكل السمع والنظر.
- سلس البول العاجل.
- تحدب الظهر.
- الاثار الجانبية للأدوية مثل(المؤثرات العقلية، المسكنات).

٢- عوامل شخصية :
- العمر : (فقدان القوة والقدرة على الاستجابة السريعة) كلما تقدم العمر.
- الاناث اكثر من الذكور.
- قلة النشاط والحركة او تاريخ سقوط سابق.
- ضعف المهارات والقدرات العقلية.
- نظام غذائي غير صحي (سوء التغذية، نقص فيتامين D ، الجفاف) .
- التدخين .
- شرب الكحول.

٣- عوامل في المنزل : عدم وجود تدابير السلامة داخل او خارج المنزل لمنع السقوط.
- ارضيات زلقة او رطبة.
- ضعف الاضاءة.
- اشياء تعرقل المشي مثل الاسلاك الكهربائية والاثاث
- وجود مفارش ارضيات غير ثابتة.
- ارتداء احذية ليست مناسبة.

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن السقوط

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
السقوط المتكرر يعد ظاهرة طبيعية لدى الكبار	ينبغي التعرف على أسباب السقوط من خلال معرفة البيئة المحيطة في المنزل و الحالة الصحية للكبار
أفضل وسيلة لوقاية الكبار من السقوط هي الحد من حركتهم	منع حدوث السقوط يكون بالتعرف على أسبابه في البيئة المحيطية وجعل المنزل بيئة خالية من خطر السقوط
السقوط لدى الكبار يعنى وقوعهم على الارض من وضع الوقوف	من الممكن للكبار التعرض للسقوط من وضعية الجلوس

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية :

١- تقييم خطر السقوط :

- إذا لوحظ عليه صعوبة الأتزان.
- إذا سقط مرة واحدة خلال الستة أشهر الماضية.
- إذا سقط مرتين أو أكثر خلال العام السابق.

٢- تقييم البيئة المنزلية لخطر السقوط:

- أضاءة المنزل
- ارضية المنزل
- حمامات المنزل

٣- تقييم الحالة الصحية لخطر السقوط :

- الامراض التي تعتبر عامل خطر للسقوط
- الادوية التي تعتبر عامل خطر للسقوط

٤- تطبيق اداة تقييم السقوط :

في حالة حدوث سقوط في وقت سابق يتم تطبيق اداة تقييم السقوط **ملحق (٧)**.

٥- مضاعفات السقوط المتكرر لدى الكبار :

- اعراض نفسية مثل القلق والاكتئا ب.
- الخوف من تكرار السقوط.
- فقدان الاستقلالية والتأثير السلبي على الحياة.
- قلة النشاط والحركة وزيادة الاعتماد على الاخرين.
- التعرض للكسور خصوصاً لمرضى هشاشة العظام.
- الحد من الانشطة الاجتماعية خوفا من الاحراج بالسقوط.

٦- تزويد القائمين على رعاية الكبار في المنزل ب :

- متطلبات السلامة داخل وخارج المنزل للوقاية من السقوط ملحق (٣).
- الممارسات الرياضية للوقاية من السقوط ملحق (٨).

٣/ ضمور العضلات لدى الكبار:

هو متلازمة خاصة بالتقدم في العمر، تشمل التناقص المستمر لكتلة العضلات بصورة عامة، يصاحبه نقص في قوتها وجودة انقباضها.

من النتائج السلبية المصاحبة لضمور العضلات الضعف ,الاعاقة الجسدية والحركية مما يؤدي إلى فقدان الاعتماد على الذات، وسوء جودة الحياة وزيادة تكاليف الرعاية الصحية.

اسباب ضمور العضلات لدى الكبار:

يحدث ضمور العضلات على شكل مراحل وليس دفعة واحدة اعتماداً على عدة عوامل خطورة منها

١- الشيخوخة.
٢- الامراض المزمنة ومنها السكري والفشل الكلوي وفشل عضلة القلب وفشل وظائف الرئة وتليف الكبد وخشونة المفاصل والالم المزمن والالتهاب المزمن وبعض الادوية.
٣- عادات الحياة غير الصحية مثل نقص تناول البروتينات، سوء التغذية، السمنة، الخمول البدني ,التدخين وتعاطي المشروبات الكحولية.
٤- تلعب الجينات والاستعداد الوراثي دورا هاما في حدوث ضمور العضلات المصاحبة للشيخوخة.
٥- نقص فيتامين D ونقص مضادات الاكسدة.

كيف يتم تشخيص ضمور العضلات لدى الكبار:

١- نقص كتلة العضلات
٢- نقص قوة العضلات
٣- انخفاض الاداء البدني
٤- اختلاف سرعة المشي
٥- ضعف قوة قبضة اليد

الوقاية من ضمور العضلات:

للوقاية من ضمور العضلات ينبغي تقوية الكتلة العضلية للجسم في المراحل العمرية المبكرة، ويرتكز ذلك على ثلاثة محاور هي تحسين العادات الصحية، والتغذية الجيدة، والنشاط البدني المستمر

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية:

التثقيف الصحي للكبير والقائمين على رعايته في اهمية تقوية العضلات من خلال:

- ممارسة تمارين تقوية العضلات على مدار يومين أو أكثر خلال الاسبوع وهي التمارين التي تحرك مجموعات العضلات الاساسية في الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والكتفين والذراعين.
- يوجد العديد من الطرق لتقوية العضلات، سواء في المنزل او خارجه ومن الامثلة على نشاطات تقوية العضلات:

١- اعمال البستنة في حديقة المنزل.
٢- المشي داخل وخارج المنزل مع مراعاة اجراءات السلامة للوقاية من السقوط.
٣- تشجيع النشاط البدني وحسب ما تم ذكره في الفصل السابع من الدليل.

٤/ الارهاق لدى كبار السن:

يعد الشعور بالارهاق من أهم الاعراض شيوعا لدى الكبار، وبالرغم من كونه عرضا غير محدد، ويصاحب الكثير من الامراض ، إلا أنه ذو أهمية قصوى كعرض غير نمطي لبعض الامراض الشائعة لدى الكبار.

يعتبر الارهاق من أهم الاعراض المؤثرة على جودة حياة الكبار، وعلى قدرتهم على تأدية أنشطة الحياة اليومية، وعلى حالتهم النفسية والاجتماعية.

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن الارهاق لدى الكبار

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
الشعور بالإرهاق هو إحساس طبيعي مع تقدم العمر	الشعور بالارهاق لدى الكباريعتبر من الاعراض المرضية التي يجب الاهتمام به وتقييمه وعلاج أسبابه
الاكتئاب هو السبب الرئيسي للشعور بالإرهاق لدى الكبار	الشعور بالارهاق لدى الكبار له أسباب متعددة ،ولا يقتصر التشخيص على النواحي النفسية فقط
الإرهاق هو الإحساس بالتعب عند تأدية أنشطة الحياة المعتادة يوميا	الارهاق لدى الكبار يشبه الاعراض الاخرى مثل الاحساس بالملل، وضيق التنفس عند القيام بمجهود، وصعوبة النوم ، والاحساس بالضعف ،وعدم القدرة على تأدية أي نشاط

أهم أسباب الإرهاق لدى الكبار:

١- تعدد الامراض.
٢- تناول أدوية متعددة والاعراض الجانبية لبعض تلك الادوية.
٣- الاكتئاب.
٤- اتباع أنماط غير صحية.
٥- أحد الاعراض غير النمطية لكثير من الامراض مثل :

- الفشل الكلوي
- فشل الكبد
- ارتفاع ضغط الدم
- السكري
- أمراض الغدة الدرقية
- عجز القلب
- قصور الشرايين
- فقر الدم
- الالتهابات
- السرطان

مشاكل الجهاز العصبي

تحدث تغيرات في الجهاز العصبي ومن ضمنها الدماغ لكنها لا تؤثر على الأداء الوظيفي للكبار ويظل قادراً على اداء حياته اليومية بصورة مستقلة

تأثير التقدم في العمر على الوظائف المعرفية للدماغ:

١- من الناحية التشريحية يقل حجم المخ ويقل حجم الخلايا العصبية.
٢- لا يتأثر الذكاء ولكن تقل القدرات الابداعية.
٣- يتأثر الانتباه وخاصة حين يكون الانتباه موجه إلى عدد من الأهداف.
٤- تقل القدرة على استيعاب المعلومات الجديدة والقدرة على التعلم.
٥- تقل القدرة على استرجاع المعلومات الجديدة.
٦- من المعتاد حدوث قصور تدريجي في الذاكرة القصيرة المدى.

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها حول وظائف الدماغ لدى الكبار

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
يعتبر القصور في الوظائف المعرفية للدماغ بجميع درجاته مرتبطاً بتقدم العمر	هناك فارق جوهري بين قصور الوظائف المعرفية مع تقدم العمراوالقصور المرضي في الوظائف المعرفية للدماغ
يصعب التفريق بين الحالات المرضية للقصور في الوظائف المعرفية والحالات المرتبطة بتقدم السن	يصعب ذلك في بعض الحالات المبكرة، ولكنه ممكن من خلال التقييم الصحي الشامل
يتم التعامل مع هذه التغيرات على أنها حتمية وغير قابلة للتحسن	يحدث التحسن بواسطة تدريب المريض والقائمين على رعايته على كيفية التغلب على هذا القصور بواسطة وسائل مساعدة.

قد تؤدي بعض الأمراض المزمنة الى زيادة حدوث التغيرات المرضية في الوظائف المعرفية المرتبطة بتقدم العمر وهي:

١- ارتفاع ضغط الدم.
٢- السكري
٣- تصلب الشرايين
٤- سوء التغذية

١/ السكتة الدماغية الوعائية:

تعتبر السكتة الدماغية الوعائية أكثر أمراض الجهازالعصبي شيوعا لدى الكبار

تعريف السكتة الدماغية الوعائية : تحدث عندما تنقطع أو تنخفض إمدادات الدم عن جزء من الدماغ مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأوكسجين والعناصر المغذية وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق وتحدث الاعراض بسرعة بسبب عجز في وظائف المخ وتستمر أكثر من ٢٤ ساعة.

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها حول السكتة الدماغية لدى الكبار

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
الاعاقة أو الوفاة نهاية حتمية لكل المصابين بالسكتة الدماغية	بعض المرضى تزول عنهم الاعراض تماما
السكتة الدماغية تسبب الوفاة دائما	لا تحدث الوفاة الا عند تأثر المراكز الحيوية مثل مركز تنظيم التنفس في المخ أو جذع المخ (تحدث عادة في بداية المرض) وكثيراً ما يعيش المرضى بالسكتة الدماغية فترات طويلة
ما يفقده المريض من قدرات وظيفية في السكتة الدماغية لا يرجع	يمكن استعادة القدرات الوظيفية كليا أو جزئيا حتى ستة أشهر من حدوث السكتة الدماغية بالعلاج الطبيعي التأهيلي

عوامل الخطر في السكتة الدماغية :

- تقدم العمر.
- وجود أمراض الاوعية الدموية (داخل او خارج الدماغ).
- وجود أمراض بالقلب (مثل الارتجاف ألاذيني).
- الكحول ، التدخين والتدخين السلبي بكل أنواعه.
- سمنة وزيادة الوزن.
- ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط.
- السكري.
- ارتفاع الدهون بالدم (الكولسترول).
- الاصابة بسكتة دماغية قديمة.

كيف يتعامل الفريق الصحي الزائر على تقديم الرعاية الصحية الاولية مع المريض الذي يعاني من السكتة الدماغية:

- ❑ يجب إجراء التقييم الشامل للمريض متضمناً الحالة الصحية والاجتماعية **ملحق (٢)**
- ❑ استكشاف ما يتمتع به القائمون على رعاية المريض من قدرات، وتدريبهم، وزيادة أعدادهم، وتقديم الدعم لهم، وتخفيف إنهاكهم وإجهادهم.
- ❑ فحص الحالة العقلية **ملحق (٩)** وقياس الاكتئاب **ملحق (٤)** والمتابعة الدورية.
- ❑ التثقيف الصحي حول طبيعة وتطور السكتة الدماغية، والتعامل مع المضاعفات المحتملة، مثل الالتهاب الرئوي، ومتلازمة الفراش مثل تقرحات الفراش وجلطات الاوردة العميقة والجلطات الرئوية وتوفير التغذية السليمة.

- ❑ التوعية حول عوامل خطورة واعراض السكتة الدماغية وقصور الشرايين التاجية وبالتالي تفاديها كضبط ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر في الدم . وتغيير نمط الحياة مثل: التوقف عن التدخين والحفاظ على وزن صحي.
- ❑ التوعية حول مشاكل الجهاز الحركي مثل تيبس المفاصل وفقدان القوة العضلية وخطر حدوث السقوط المتكرر ومشاكلها وكيفية الوقاية منها.
- ❑ تقديم المعلومات عن خدمات الدعم المتوفرة مثل مراكز التأهيل **ملحق (١)**
- ❑ المساعدة في تأهيل البيئة الداخلية للمنزل مثل الحمام والمطبخ للوقاية من خطر السقوط.
- ❑ الاشراف ومراجعة الادوية لتفادي تناول أدوية متعددة وتجنب المضاعفات.

٢/ مرض باركنسون (الشلل الرعاشي):

مرض ضموري عصبي مزمن يبدأ تدريجيا بالتفاقم مع مرور الوقت، ويتميز بوضوح من خلال أعراضه الحركية: وهي بطء الحركة ، الرعاش أثناء الراحة ، تجمد الخطوات وعدم التوازن، صعوبة الكلام، وصعوبات البلع . ولايوجد علاج للمرض وانما علاج للاعراض.

عوامل خطر مرض باركنسون:

١- تقدم العمر.
٢- الرجال أكثر من النساء.
٣- الجينات الوراثية.
٤- تناول بعض الادوية.
٥- التعرض لبعض المواد الكيمياوية.

دور القائمين على رعاية الكبار في المنزل:

١- أداء دور فعال في تنظيم شؤون العلاج وشؤون الحياة الاخرى التي تتطلب مهارات التواصل مع المريض.
٢- الوعي بمسار المرض وتطوره واعراضه ومضاعفاته.
٣- مشاكل الحركة والسقوط.
٤- تأهيل المنزل لتسهيل حركة المريض وحمايته من السقوط.
٥- الاهتمام بتوفير العلاج الدوائي والتأهيل الطبي من خلال العلاج الطبيعي بشكل مستمر.

دور الفريق الصحي الزائر على رعاية الصحية للكبار في المنزل:

- ❑ التثقيف الصحي حول طبيعة وتطور المرض، والتعامل مع المضاعفات المحتملة، مثل مشكلات في مضغ الطعام والبلع ،اضطرابات النوم ومشكلات في المثانة .
- ❑ التوعية حول اهمية إعادة التأهيل في تحسين الأداء ونوعية الحياة للأشخاص المصابين بمرض باركنسون مثل: تدريبات القوة والمشي والتوازن والعلاج المائي.
- ❑ التوعية حول مشاكل الجهاز الحركي مثل تيبس المفاصل وفقدان القوة العضلية وخطر حدوث السقوط المتكرر ومشاكلها وكيفية الوقاية منها.

مشاكل الجهاز التناسلي

هناك العديد من التغيرات الطبيعية التي تحدث في الجهاز التناسلي في مرحلة الشيخوخة والتي قد تؤثر على جودة الحياة بشكل عام.

التغيرات التي تحدث للنساء:

- انقطاع الطمث نتيجة لانخفاض حاد في هرمون الاستروجين.
- جفاف المهبل وحدوث الالتهابات الناتج عن ضمور الغشاء المبطن له.

التغيرات التي تحدث للرجال:

- تحدث تغيرات هرمونية وانخفاض في الوظيفة الجنسية لكن من الممكن ان يكون قادر على الانجاب في الظروف العادية.

عوامل الخطر التي تزيد من حدة التغيرات الطبيعية التي تحدث في الجهاز التناسلي مع تقدم العمر:

- الملل أو الخوف والتعب
- الحزن والاكتئاب
- الاعاقة الجسمية

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن الحياة الجنسية

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
الحياة الجنسية غير مرغوبة لدى كل الكبار	الكبار لديهم حياة عائلية متكاملة، فقد تقل رغبتهم في ممارسة العلاقة الزوجية، أو يقل تواترها، ولكن لا تنعدم رغبتهم الجنسية
من المعيب أن يلجأ الكبار للطبيب لشكوى خاصة بالعلاقة الزوجية	السؤال عن القدرة الجنسية جزء من التقييم الصحي الشامل للكبار
يجب أن يتحفظ الطبيب حين يستشيره الكبار في مشكلاتهم الجنسية	أن على الطبيب أن يسأل الكبار عن شكواهم التي تخص مشكلاتهم الجنسية ،لأنها قد تؤثر على جودة حياتهم

أهم الأمراض التي تصيب الجهازالتناسلي لدى النساء الكبيرات:

- اضطراب عضلات الحوض اوهبوطها والتي قد تسبب السلس البولي
- اورام الجهاز التناسلي مثل اورام الرحم ,المبيض او المهبل

أهم الأمراض التي تصيب الجهازالتناسلي لدى الرجال الكبار:

- قصور الغدد التناسلية.
- التضخم الحميدي للبروستات.

- ❖ سرطان البروستات.

مشاكل الجلد لدى الكبار

تغيرات الجلد المصاحبة للتقدم في العمر:

١- يتناقص سمك الجلد ويصاحب ذلك نقص في الخلايا والأوعية الدموية والغدد العرقية والدهنية والخلايا العصبية الحسية.
٢- يتناقص محتوى الجلد من الكولاجين والدهون
٣- يشيب الشعر نتيجة تناقص الخلايا الفارزة للميلانين في بصلة الشعر.
٤- ينقص سمك صفيحة الاظافر ومعدل نمو الأظافر.

نتائج تغيرات الجلد المصاحبة للتقدم في العمر:

١- يصبح الجلد رقيقا وتظهرالتجاعيد عليه.
٢- تتضاءل قدرة الجلد على تبادل الحرارة الداخلية أو الاحتفاظ بها.
٣- تتزايد معدلات إصابة الجلد بالعدوى والقروح وتقل قدرته على الشفاء.
٤- تزداد سهولة تكسر الأظفار.
٥- تزداد كل هذ التغيرات بعوامل أخرى مصاحبة للتقدم في العمر مثل التدخين وسوء التغذية والجفاف.

أمراض الجلد الحميدة الشائعة لدى الكبار:

١/ جفاف الجلد:

تعتبر المشكلة الجلدية الأكثر شيوعاً، وفيها يصبح الجلد جافاً متقشراً وخشناً ، وقد يصاحبها حكة. وتزداد الاصابة بها في فصل الشتاء.

علاج جفاف الجلد: استخدام الزيوت المرطبة والصابون المرطب وتجنب الماء الحار الذي يزيد من جفاف الجلد وفي حالات الجفاف الشديدة تستخدم المراهم الجلدية المرطبة.

٢/ الحكة:

هناك اعتقاد سائد أن السبب الأساسي للحكة هو وجود مرض جلدي، إلا أن أكثر أسبابها شيوعا هو جفاف الجلد. وقد يصعب تحديد سبب الحكة لدى الكبار.

اسباب الحكة:

- ❖ امراض جلدية
- ❖ الفشل الكلوي
- ❖ مرض السكري
- ❖ امراض القناة الصفراء
- ❖ رد فعل لعلاج دوائي

❖ عوامل نفسية

التعامل مع الحكة لدى الكبار صعب بسبب تعدد العوامل التي تسببها وصعوبة تشخيصها، إلى جانب الحذرالواجب من العلاج بمضادات الهستامين لما تسببه لدى الكبار من آثار جانبية ضارة.

٣/ النمش:

بقع بنية اللون مسطحة الملمس تظهرعلى الوجه وظاهر اليدين والقدمين نتيجة التعرض للشمس لفترة طويلة، وهي غير ضارة.

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية للعناية بالجلد:

- ❖ تبدأ العناية بالجلد بالنظافة الشخصية والتغذية الجيدة والوقاية من الجفاف وتقليل التعرض لأشعة الشمس وتجنب التدخين.
- ❖ لا يجب التعرض لأشعة الشمس المباشرة بين ١٠صباحا و ٣عصراً، ويجب ارتداء قبعات عريضة وأكمام طويلة .
- ❖ ضرورة الأهتمام بالأعراض الجلدية مثل الحكة قد تكون نتيجة لجفاف الجلد البسيط، وقد تكون علامة لامراض اخرى.

الفصـــل الســـابع
رعاية المسنين المقعدين
(غير القادرين على الـــحركة)







اسباب عدم القدرة على الحركة:

١- اسباب في الجهاز العضلي الهيكلي مثل امراض المفاصل والكسور وتشوهات القدمين
٢- اسباب في الجهاز العصبي مثل السكتة الدماغية وداء باركنسون واصابات المخيخ التي تؤدي الى خلل بالتوازن
٣- اسباب في الجهاز القلبي الوعائي
٤- اسباب في الجهاز التنفسي
٥- سوء التغذية
٦- استخدام المهدئات والادوية التي تخفض ضغط الدم مثل المدررات
٧- ضعف الحواس مثل اعتلال الاعصاب المحيطية او الطرفية وضعف الابصار
٨- اسباب نفسية مثل الاكتئاب والخوف من السقوط
٩- اسباب خارجية بيئية مثل الارتباط بالمحاليل الوريدية واستخدام القسطرة البولية وعدم توفر ادوات المساعدة الحركية وسوء الاضاءة وعدم توفر اجراءات الامان البيئية

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن المرضى غير القادرين على الحركة

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
الراحة بالفراش مفيدة للنقاهة واسترداد الطاقة	الراحة لها مضاعفات عديدة بعضها قد يكون قاتلاً
عدم قدرة المسن على الحركة اسبابها عضوية فقط	ممكن ان تكون الاسباب نفسية كغياب الامن البيتي

مضاعفات عدم الحركة في المسنين:

تصيب اغلب اجهزة الجسم ويمكن تفادي الكثير منها وهي:

١- مضاعفات في الجلد: قرحة الانضغاط في الفراش
٢- مضاعفات الجهاز العضلي الهيكلي: ضمور العضلات وتليف الاربطة وهشاشة العظام
٣- مضاعفات الجهاز القلبي الوعائي: جلطات الاوردة العميقة في الساقين وهبوط ضغط الدم عند الوقوف
٤- مضاعفات في الرئة: التهابات الرئة بسبب استنشاق السوائل
٥- مضاعفات في الجهاز الهضمي: الامساك وفقدان الشهية وسلس براز
٦- مضاعفات الجهاز البولي: التهاب المجاري البولية وحصى المثانة وسلس البول
٧- مضاعفات الحالة النفسية : الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم
٨- مضاعفات في الاداء الوظيفي: فقدان الاستقلالية

دور الفريق الصحي الزائر لتقديم الرعاية الصحية المنزلية:

١- البحث عن السبب الذي يؤدي الى اعاقة الحركة وتقييم ذلك لاستشارة الطبيب المشرف.
٢- توعية القائمين على الرعاية حول التغذية الجيدة لكبير السن المقعد (بروتين وفيتامينات) والوقاية من الجفاف .
٣- الدعم النفسي للكبير والقائمين على رعايته.

٤- تقييم قدرة المريض على اداء باقي انشطة الحياة اليومية والقدرة على التقلب من الفراش والانتقال الى المقعد المتحرك وتحريكه.
٥- التوعية بخصوص استعمال وسائل المساعدة على الحركة (العصا والمشاية والعكاز والكرسي المتحرك).
٦- تقييم المنزل واعداده لتسهيل اداء المريض لانشطته اليومية مثل تزويد الممرات بالمقابض وابواب تتسع لمرور الكرسي المتحرك.
٧- منع حدوث تقرحات الانضغاط بتقليب المريض كل ساعتين واستعمال فراش هوائي والعناية بالجلد.
٨- الوقاية من الجلطات في اوردة الساق بأستعمال الادوية المانعة للتجلط والجوارب المطاطية.
٩- اعطاء كميات كافية من السوائل والاطعمة لتنظيم حركة الامعاء حسب الحاجة وتسجيل نشاط الامعاء يومياً.

متى نحيل المسن المقعد الى مستويات اعلى من الرعاية؟

الاحالة الى المستشفى: وذلك عند حدوث المضاعفات الخطيرة التي لا يمكن للقائمين على تقديم الرعاية الاولية التعامل معها مثل الالتهاب الرئوي ، تقرحات الانضغاط بالفراش الملتهبة ، الجفاف واختلال شوارد الدم ، الهذيان ...الخ

تقرحات الانضغاط : هي اي اصابة للجلد والنسيج التي تحته بضرر نتيجة الضغط المستمر.

- تشكل مشكلة كبيرة في الكبار المقعدين وتسمى احياناً بقرحة الفراش لانها تحدث نتيجة ملازمة الفراش لكنها قد تحدث نتيجة الانضغاط من الجلوس في الكرسي او غير ذلك ،

- وهي مثل الجبل الجليدي لان حجم التلف في الانسجة تحت الجلد يكون اكبر من حجم التلف في الجلد.

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن قرحة الفراش لدى الكبار

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
قرحة الفراش ظاهرة طبيعية في المسنين قليلي الحركة	قرحة الفراش مرض لا يقتصر على المسنين ويمكن الوقاية منها وعلاجها
قرحة الانضغاط ليست خطيرة	قد تتفاقم لتصل الى الانسجة العميقة وتسبب مضاعفات خطيرة
قرحة الانضغاط معدية	ليست معدية لكن من الممكن ان تكون مصحوبة بالقيح وتسبب عدوى بكتيرية

عوامل الخطر في حدوث تقرحات الانضغاط:

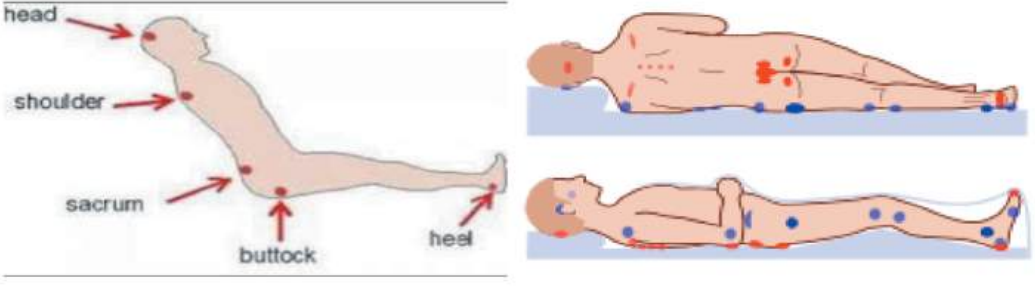
١- ملازمة الفراش.
٢- السمنة.
٣- السكري .
٤- سوء التغذية .
٥- البلل المستمر.

٦- التهاب الجلد.
٧- ضعف الاحساس بالجلد.

اماكن حدوث تقرحات الانضغاط:

تظهر في مناطق الجسم التي تحتوي على بروزات عظمية والتي تشمل:

١- الوركين.
٢- الأرداف.
٣- الظهر.
٤- عظم العجز (العصعص).
٥- الكاحل.
٦- الكعب.
٧- الكتف.
٨- مؤخرة الرأس.
٩- المرفقين.
١٠- الركبتين.



صورة توضح اماكن حدوث تقرحات الانضغاط

دور فريق الرعاية الصحية الزائر في التعامل مع تقرحات الانضغاط:

تثقيف القائمين على رعاية الكبار في المنزل حول:

١- التعرف على الاماكن الشائعة لحدوث قرحات الانضغاط وحسب الصور اعلاه
٢- التعرف على درجات تقرحات الانضغاط:
- ❖ **الدرجة الاولى:** احمرار في الجلد لايزول.
- ❖ **الدرجة الثانية:** وجود كدمة او فقاعة اوتآكل لا يتعدى الجلد او الانسجة تحته.
- ❖ **الدرجة الثالثة:** وصول التلف الى الانسجة العميقة مثل العضلات والمفاصل والاربطة.

٣- التعرف على المضاعفات الاخرى المتوقعة لمتلازمة الفراش:
- ❑ جلطة الاوردة العميقة وانسداد الشريان الرئوي.
- ❑ انحباس البول والامساك.
- ❑ التهاب المجاري البولية والالتهاب الرئوي.
- ❑ الاكتئاب.

- ❑ سوء التغذية.
- ❑ فقدان قوة العضلات وتليفها .
- ❑ فقدان حركة المفاصل وتيبسها.
- ❑ هشاشة العظام وحصوات الكلى.
- ❑ تلف العضلات وزيادة البوتاسيوم ووجود المايوكلوبين بالدم واتلافه للكليتين.

وضع خطة الرعاية:

١-القاعدة الذهبية للتعامل مع تقرحات الفراش هي تثقيف القائمين على الرعاية (الوقاية خير من العلاج).
٢-التأكد من التغذية السليمة.
٣-استخدام مرتبات او فراش يخفف تأثير الضغط مثل المرتبة الهوائية.
٤-ضماد الجروح والتقرحات فور حدوثها من قبل طبيب او ممرض متخصص.
٥-يجب رفع الانضغاط بتغيير الوضع كل ساعتين ويفضل استخدام جدول التقليب ادناه:

الجدول الاسبوعي لتقليب المسنين الملازمين للفراش

الوقت	الايـــــام						
	السبت	الاحد	الاثنين	الثلاثاء	الاربعاء	الخميس	الجمعة
٨-١٠ صباحاً							
١٠-١٢ ظهراً							
١٢-٢ مساءً							
٢-٤ مساءً							
٤-٦ مساءً							
٦-٨ مساءً							
٨- ١٠ مساءً							
١٠-١٢منتصف الليل							
١٢-٢ صباحاً							
٢-٤ صباحاً							
٤-٦ صباحاً							
٦-٨ صباحاً							

الوقاية من تقرحات الفراش لدى الكبار:

١- تغيير وضعية الجلوس أو النوم باستمرار.
٢- الحرص على فحص الجلد بشكل يومي.
٣- المحافظة على نظافة الجلد وذلك بغسله وتجفيفه جيدًا.
٤- غسل أغطية السرير والتأكد من عدم تجعدها بعد وضعها على السرير.
٥- دعم المناطق التي تحتوي على بروزات عظمية بوسائد مريحة.
٦- الحفاظ على التغذية الجيدة وتناول السوائل.
٧- المحافظة على وزن صحي.

٨- الإقلاع عن التدخين.

متى نحيل المسن المقعد الى المستشفى؟

١- تدهور الحالة الصحية وعدم امكانية استمرار الرعاية في المنزل.
٢- الحاجة لتداخل جراحي مثل ترقيع الجلد.
٣- وجود مضاعفات لمتلازمة الفراش لا يمكن علاجها بالمنزل.

الفصل الثـــامن
التـــعامل مع الأدوية



تناول أدوية متعددة : هو استخدام خمسة أدوية أو أكثر مما يحتاجه المسن وهو شكل من أشكال إساءة استخدام الأدوية.

انواع تناول أدوية متعددة :

- ❖ تناول أدوية متعددة بدون سبب واضح.
- ❖ تناول أدوية متعددة لمعالجة نفس المرض.
- ❖ تناول أدوية متعددة تتعارض في فعاليتها.
- ❖ تناول أدوية متعددة بجرعات غير صحيحة.
- ❖ تناول أدوية متعددة لمواجهة الأعراض الجانبية لأدوية أخرى.

اسباب تناول ادوية متعددة:

١- تعدد الأمراض لدى الكبار
٢- سهولة صرف الأدوية دون وصفة من الطبيب.
٣- تعدد الوصفات الطبية من تخصصات مختلفة.
٤- عدم اهتمام بعض الأطباء بخطورة تناول أدوية متعددة لدى الكبار ،وعدم اهتمام أسرهم بذلك
٥- المعتقدات الشائعة بأن الأعشاب وبعض الأدوية مثل الفيتامينات والمنشطات والملينات آمنة تماماً ولا تسبب أي أضرار أو تفاعلات.

أهم المشاكل الناتجة عن تناول أدوية متعددة:

١- التفاعلات الدوائية بين الأدوية والجسم وبين بعض الأدوية وبعضها الآخر، وقد تؤدي هذه التفاعلات إلى مضاعفات قاتلة .
٢- الدخول المتكرر للمستشفيات.
٣- صعوبة التنسيق بين الأدوية الكثيرة العدد يؤدي الى عدم الانتظام في العلاج ،مما يؤدي الى تدهور حالتهم الصحية.
٤- زيادة التكلفة المالية للادوية والتي يصعب توفيرها سواء من ميزانية وزارة الصحة أوالشراء من الصيدليات الخاصة.

الأدوات المساعدة في تنظيم تناول الجرعة الدوائية للكبار:

إن تعبئة الأقراص والكبسولات في أداة تنظيم الجرعات تعتبر وسيلة شائعة و موثوقة لمساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى تناول أدوية متعددة و جرعات متعددة كل يوم.

انواع ادوات تنظيم الدواء:

١- أداة التنظيم متعددة الحجرات:
تستخدم لجميع الأقراص والكبسولات اللازم تناولها في كل وقت من اليوم و في كل يوم من أيام الأسبوع.
٢- الوسائل الإلكترونية المساعدة لتناول الجرعة الدوائية:

تعتمد على استخدام أنظمة برمجية مختلفة متوفرة في الهاتف المحمول والتي ترسل تنبيهات إلى مقدم الرعاية الصحية لاخذ الجرعة الدوائية.

دور القائمين على تقديم الرعاية الصحية في تخفيف وطأة تناول الكبار لأدوية متعددة:

١- معرفة جميع الأدوية التي يتناولها كبار السن.
٢- تجنب تناول الادوية للأعراض البسيطة والغيرالمحدودة بدون استشارة طبيب.
٣- استخدام العلاج غير الدوائي كلما أمكن كبديل للعلاج الدوائي.
٤- مراجعة الأدوية بصفة دورية من حيث أنواعها ,الحاجة إليها ,فعاليتها ,جرعاتها وتأريخ انهاء مفعولها.
٥- التواصل مع الكبير ومع القائمين على رعايته حول الأدوية التي يتناولها وأسباب استخدامها.
٦- أثناء زيارة الطبيب :

- ❖ يجب إخبار الكبير ومن يرعاه بالمنزل أن يجلب جميع الأدوية التي يستخدمها المسن اثناء مراجعته للطبيب.
- ❖ وصف الدواء في الشكل المناسب لقدرات كبير السن للمبررات التالية :
  - يعاني بعض كبار السن من صعوبة في البلع فتكون الأدوية السائلة مناسبة أكثر لهم.
  - يعاني كبار السن من صعوبة في بلع الأقراص الكبيرة .
  - يعاني بعض كبار السن من ضعف البصر أو التهاب مفاصل اليد إذ يجدوا صعوبة في استخدام الأقراص الصغيرة.

نصائح عامة بخصوص ادوية الكبار:

١- التأكد بإلتزام الكبير بأخذ الدواء بالمواعيد المحددة من قبل الطبيب.
٢- ضرورة مساعدة الكبير بتناول الدواء وخاصة للذي لا يستطيع تناوله بنفسه.
٣- ان تكون الادوية قريبة من متناول يده.
٤- التأكد من توفير ادوية الكبير بشكل مستمر.
٥- التخلص من الأدوية المنتهي تاريخ صلاحيتها.
٦- كتابة قائمة دقيقة بجميع الأدوية التي يتناولها الكبير.

الفصل التـــاسع
النشاط البــدني للكبـار



تشجيع الكبار لممارسة النشاط البدني بمعدل ٣٠ دقيقة باليوم الواحد / خمسة ايام في الاسبوع وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

انواع النشاط البدني لدى الكبار: المشي ,صعود الدرج ,ركوب الدراجة , الاعتناء بالحديقة.

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها عن النشاط البدني والرياضة لدى الكبار

المفاهيم الخاطئة	المفاهيم الصحيحة
يتوقف نشاط المسن بالتقدم في العمر	انها مرحلة عمرية جديدة ويجب ان تكون مفعمة بالنشاط
الشيخوخة تؤثر على أداء أجهزة الجسم المختلفة في الظروف العادية	الشيخوخة تؤثر على الآحتياطي الفيزيولوجي ولا تؤثر على أداء أجهزة الجسم في الظروف العادية طالما أنها سليمة (غير مريضة)
الكبار لا يستطيعون ممارسة الرياضة	يستطيع الكبار ممارسة الرياضة بأمان، وذلك بعد وصف الرياضة المناسبة له
ممارسة الرياضة لا تأتي بالمنافع المتوقعة لها لدى الكبار	أن ممارسة الرياضة مثل المشي البسيط مهمة جداً مهما كان عمر الانسان
بعض التمارين لا تناسب الكبار مثل تمارين القوة	يستطيع الكبارممارسة جميع أنواع الرياضة ،بما فيها تدريبات القوة والتحمل، بعد الاستشارة الطبية
وجود بعض الأمراض كأمراض القلب لدى الكبار يمنعهم من ممارسة الرياضة	أمراض القلب المستقرة لدى الكبار لا تعوق ممارسة الرياضة، وإنما تستدعي استشارة متخصصة لطبيب القلب وطبيب المفاصل لوصف الرياضة المناسبة
يجب تقبل رفض الكبار لممارسة النشاط البدني اوالرياضة	يجب توجيه النصح بممارسة الرياضة أو النشاط البدني مع إيضاح فائدته ،وإجراء الأستشارات التخصصية التي تطمئنهم

السلامة الطبية للنشاط البدني لدى الكبار:

١- يعتبر المصابون بأمراض القلب والاوعية الدموعية من الفئات الخطرة حيث لا بد من اجراء التقييم الطبي قبل الشروع في اي نشاط بدني.
٢- يجب ان يكون المكان مناسب لممارسة النشاط البدني للوقاية من السقوط.

اهم المشاكل التي يعاني منها كبار السن في ممارسة النشاط البدني وكيفية ايجاد الحلول

المشكلة	الحل
ممارسة النشاط البدني هو من الاعمال الشاقة	ابدأ بالمشي العادي ، أو تمارين خفيفة تستطيع القيام بها وانتظر النتيجة.
ليس لدي الوقت.	قد يكون هذا صحيحًا ، لكنك لن تعرف على وجه اليقين ما لم تحاول تخصيص وقت لممارسة النشاط البدني.
ممارسة النشاط البدني متعب بالنسبة الي.	أخبر نفسك ، "هذا النشاط سيعطيني المزيد من الطاقة." تحقق مما إذا لم يحدث ذلك.
أنا قلق من الفشل في الاستمرار في ممارسة النشاط البدني لذا لن أفعل.	النشاط البدني ليس اختبارًا. لن تفشل إذا كنت اخترت النشاط الذي تريده وابدأ ببطء تحديد أهداف واقعية معقولة تقلل من فرص بالفشل.
ليس لدي أي شخص يمارس النشاط البدني معي.	ربما لم تسأل جار أو زميل عمل قد يكون شريكًا راغبًا. أو يمكنك اختيار نشاط تستمتع به بنفسك
ليس هناك مكان مريح	اختر نشاطًا يمكنك القيام به في مكان مناسب مثلا المشي في منطقتك أو مركز تجاري قريب ، أو القيام بتمارين مع برنامج تلفزيوني أو شريط فيديو في المنزل.
أنا خائف من حدوث أصابات	المشي في منطقة مضاءة جيداً تعتبر ممارسة ممتازة وآمنة.
الطقس سيء للغاية	حاول ممارسة انشطة بدنية تقوم بها بنفسك في مكان ووقت مناسب.
أنا لدي سمنة	اختيار التمرين مهم, المشي مثلا ليس لديه علاقة بالسمنة
عمري كبير	دائما هناك الوقت ,اي شخص وخاصة الكبير يحتاج النشاط البدني للحفاظ على الصحة

فوائد الرياضة والنشاط البدني لدى الكبار:

١- تقلل الرياضة والنشاط البدني من حدوث الأمراض الشائعة في الكبار مثل : هشاشة العظام وخطر السقوط ومضاعفاته من الكسور، السكري ، أمراض القلب والشرايين التاجية، ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وامراض المفاصل كما تقلل من معدلات الوفاة.

٢- تساعد الرياضة والنشاط البدني في تحسين الحالة النفسية والعقلية وتقلل من اضطرابات النوم.

٣- تساعد ممارسة رياضة المشي على تعزيز استقلالية وجودة الحياة، وتحسن كفاءة كل أجهزة الجسم مثل القلب ,الرئتين ,الامعاء والعضلات.

الفصل العاشر

المصادر:

- الرعاية الصحية الأولية للمسنين: دليل إقليمي للعاملين في الرعاية الصحية الأولية / منظمة الصحة العالمية, المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ,٢٠١٩.

- مجتمع لكل الاعمار/ دليل إرشادي وتدريبي حول قضايا كبار السن وسبل وقايتهم من التعرض للعنف والإهمال ,٢٠١٨.

- دليل تدريبي لمجموعات ممثلي الاحياء والمتطوعين الصحيين , الجزء ٤ الامراض غير السارية / منظمة الصحة العالمية, المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ,٢٠٠٩.

- الدليل الوطني للمراكز الودية للـــــمسن/ قسم الوقاية والسيطرة على الأمراض غير الانتقالية شـعبة صـــحة الكـــبار ,٢٠٢١.

- الدليل الوطني للوقاية من مرض هشاشة العظام للكوادر الصحية العاملة في مراكز الرعاية الصحية الاولية,٢٠٢١.

- الدليل الإرشادي لبرنامج رعاية المسنين في المراكز الصحية الاولية / الطبعة الثانية,٢٠١٤.

- دليل نمط الحياة الصحي لكبار السن,٢٠٢٣.

- دليل الاسرة لرعاية كبار السن / وزارة الصحة الاردنية ,٢٠٠٩.

- عش بصحة / دليل صحة العين ,وزارة الصحة السعودية ,٢٠٢١.

- الرعاية الصحية المنزلية/ المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ,٢٠٢٢.

- المرجع الوطني لتثقيف مرضى داء السكري / وزارة الصحة السعودية / الوكالة المساعدة للطب الوقائي / الادارة العامة للامراض غير المعدية / الاصدار الاول ٢٠١١.

الفصل الحادي عشر

الملاحق

ملحق (١)

جدول (أ) اسماء المراكز ومستشفيات التأهيل الطبي للمعوقين التي تعقد فيها اللجان الطبية الخاصة بصرف المعينات الطبية في دوائر الصحة

ت	اللجنة	الدائرة
١-	مركز التاهيل الطبي وامراض المفاصل	دائرة صحة بغداد /الرصافة
٢-	مستشفى ابن القف لاصابات الحبل الشوكي	
٣-	مركز الحمزة لتاهيل المعوقين	دائرة صحة بغداد/ الكرخ
٤-	مركز المصطفى لتاهيل المعوقين	
٥-	مستشفى الامامين الكاظميين	
٦-	مركز الناصرية لتاهيل المعوقين	دائرة صحة ذي قار
٧-	مركز كركوك لتاهيل المعوقين	دائرة صحة كركوك
٨-	مركز الموصل لتاهيل المعوقين	دائرة صحة نينوى
٩-	مركز النجف لتاهيل المعوقين	دائرة صحة النجف الاشرف
١٠-	مركز بابل لتاهيل المعوقين	دائرة صحة بابل
١١-	مركز الانبار للاطراف الصناعية	دائرة صحة الانبار
١٢-	مركز الفلوجة لتأهيل المعاقين	
١٣-	مركز الديوانية لتاهيل المعوقين	دائرة صحة الديوانية
١٤-	مستشفى دجلة لتأهيل المعوقين	دائرة صلاح الدين
١٥-	مركز الكوت لتاهيل المعوقين	دائرة صحة واسط
١٦-	مركز العمارة لتاهيل المعوقين	دائرة صحة ميسان
١٧-	مركز السماوة لتاهيل المعوقين	دائرة صحة المثنى
١٨-	مركز كربلاء لتاهيل المعوقين	دائرة صحة صحة كربلاء المقدسة
١٩-	مركز البصرة لتاهيل المعوقين	دائرة صحة البصرة
٢٠-	مستشفى بعقوبة العام	دائرة صحة ديالى
٢١-	مستشفى خانقين العام	
٢٢	مستشفى جلولاء العام	
٢٣	مستشفى الخالص العام	

٢٤	مستشفى المقدادية العام	
٢٥	مستشفى بلدروز العام	
٢٦-	مركز هيلينا للتاهيل الطبي في اربيل	اقليم كردستان
٢٧-	مركز التاهيل الطبي في دهوك	اقليم كردستان
٢٨-	مركز التاهيل الطبي للاطفال في السليمانية	اقليم كردستان

جدول (ب) مراكز تاهيل المعوقين

ت	المركز	الدائرة
١-	مركزالسلام لتاهيل المعوقين	دائرة صحة بغداد/ الرصافة
٢-	مركز الغدير لتاهيل المعوقين	
٣-	مركز المؤمل لتاهيل المعوقين	
٤-	مركز التاهيل الطبي وامراض المفاصل	
٥-	مركز الحمزة لتاهيل المعوقين	دائرة صحة بغداد/ الكرخ
٦-	مركز المصطفى لتاهيل المعوقين	
٧-	مركز ذي قار لتاهيل المعوقين	دائرة صحة ذي قار
٨-	مركز كركوك لتاهيل المعوقين	دائرة صحة كركوك
٩-	مركز الموصل لتاهيل المعوقين	دائرة صحة نينوى
١٠-	مركز البصرة لتاهيل المعوقين	دائرة صحة البصرة
١١-	مركز النجف لتاهيل المعوقين	دائرة صحة النجف الاشرف
١٢-	مركز بابل لتاهيل المعوقين	دائرة صحة بابل
١٣-	مركز الانبار لتاهيل المعوقين	دائرة صحة الانبار
١٤-	مركز الديوانية لتاهيل المعوقين	دائرة صحة الديوانية
١٥-	مركز الكوت لتاهيل المعوقين	دائرة صحة واسط
١٦-	مركز العمارة لتاهيل المعوقين	دائرة صحة ميسان
١٧-	مركز السماوة لتاهيل المعوقين	دائرة صحة المثنى
١٨-	مركز كربلاء لتاهيل المعوقين	دائرة صحة صحة كربلاء المقدسة

جدول (ج) مراكز الاطراف الصناعية

ت	المركز	الدائرة
١-	مركز بغداد للاطراف الصناعية	دائرة صحة بغداد/الرصافة
٢-	مركز صدر القناة للاطراف الصناعية والمساند	
٣-	ورشة المساند الطبية في مستشفى الواسطي	
٤-	ورشة الاطراف في م. الشهيد محمد باقر الحكيم	دائرة صحة بغداد/ الكرخ
٥-	مركز الاطراف والمساند في النجف الاشرف	دائرة صحة النجف الاشرف
٦-	مركز الاطراف والمساند الطبية في البصرة	دائرة صحة البصرة
٧-	مركز الاطراف والمساند في بابل	دائرة صحة بابل
٨-	مركز الفلوجة للاطراف والمساند	دائرة صحة الانبار
٩-	مركز الاطراف والمساند في مستشفى التأهيل	دائرة صحة صلاح الدين
١٠-	مركز الاطراف والمساند في الديوانية	دائرة صحة الديوانية
١١-	مركز الاطراف والمساند في واسط	دائرة صحة واسط
١٢-	مركز الاطراف والمساند في الناصرية	دائرة صحة ذي قار
١٣-	مركز الاطراف والمساند في ميسان	دائرة صحة ميسان
١٤-	مركز الاطراف والمساند في كركوك	دائرة صحة كركوك
١٨-	مركز السماوة للاطراف الصناعية	دائرة صحة المثنى
١٩-	مركز جعفر الطيار للاطراف الصناعية	دائرة صحة كربلاء المقدسة
٢٠-	مركز الطواريء في السليمانية للاطراف	اقليم كردستان
٢١-	مركز نينوى للاطراف	دائرة صحة نينوى
٢٢-	ورشة المساند في مستشفى سامراء	دائرة صحة صلاح الدين

جدول (د) مستشفيات التاهيل الطبي

ت	المركز	الدائرة
١-	مستشفى ابن القف لاصابات الحبل الشوكي ١٢٠سرير	دائرة صحة بغداد/ الرصافة
٢-	مستشفى التأهيل الطبي	دائرة صحة صلاح الدين

ملحق (٢) اداة تقييم فحص العشرة دقائق الصحي الشامل

اولاً/ الذاكرة

اعطي التعليمات التالية لكبير السن " سأقوم بتسمية ٣ اشياء **(قلم ، شاحنة، كتاب)** سوف اطلب منك ان تعيدها بعد دقيقة من الان.....رجاءً حاول ان تتذكرها"

سجل ذلك بعد سؤال القدرات البدنية الوظيفية (الفقرة رابعاً)

ثانياً/ السلس البولي

١-اسأل " خلال السنة الماضية .. هل فقدت السيطرة على الادرار ولو لمرة واحدة؟
نعم_____ كلا _____
اذا كان الجواب كلا انتقل الى ثالثاً
اذا كانت الاجابة نعم أسال السؤال الثاني
٢-"هل فقدت السيطرة على الادرار في الاسبوع الماضي؟

نعم _____ كلا_____

اذا كان الجواب نعم **للسؤالين** يحال الى " التقييم السريري للسلس البولي" **ملحق(٦)**

(الجزء الاول يتم بواسطة ملاك صحي مدرب والجزء الثاني يتم بواسطة الطبيب)

ثالثاً / الاكتئاب

اسأل " هل تشعر احياناً كثيرة بالحزن او الاكتئاب؟

نعم _____ كلا _____

اذا كان الجواب نعم يحال الى " التقييم السريري للاكتئاب" **ملحق (٥)**

(يتم بواسطة المريض نفسه او ملاك صحي مدرب)

رابعاً / القدرات البدنية الوظيفية (عدم الحركة)

اسأل " هل انت قادر على

١- الركض/ المشي السريع للحاق بالحافلة؟ نعم ____كلا ____

٢-اداء الاعمال المنزلية الثقيلة مثل غسل الشبابيك والجدران والارض؟ نعم___ كلا ___

٣-التسوق من البقالة او شراء الملابس؟ نعم _____ كلا _____

٤- الذهاب الى اماكن خارج منطقة السكن بأستخدام سيارة او حافلة ؟ نعم _____كلا_____

٥- الاستحمام وقوفاً او باستخدام حوض الاستحمام؟ نعم _____ كلا _____

٦-ارتداء الملابس ، مثل ارتداء القميص ،غلق الازرار او ارتداء الاحذية؟ نعم_____كلا_____

يعتبر التقييم ايجابي (لكل سؤال) اذا كان المريض غير قادر او قادر بمساعدة او اشراف شخص اخر وتكون الاجابة بـ (كلا).

اذا كان التقييم ايجابي اذهب الى المشورة حول النشاط البدني (الفصل التاسع من الدليل)

هل اكمل المريض استذكار الاشياء الثلاثة التي تم تسميتها مسبقاً

اسأل عن هذه الاشياء الثلاثة:

١)_____ ٢)_____ ٣)_____

هل تم تسمية الاشياء الثلاثة ؟ نعم _____ كلا _____

اذا كان الجواب كلا يحال الى " التقييم السريري لفقدان الذاكرة" **ملحق (١٠)**
(يتم بواسطة الطبيب)

خامساً/ السقوط

١-هل تعرضت للسقوط مرتين او اكثر خلال ال ١٢ شهرا الماضية

نعم _____ كلا _____

اذا كان الجواب كلا .. فقم بما يأتي:

٢- اعط التعليمات التالية " اقم من على الكرسي ، در حوله بدون ان تمسك بشيء"

قادر على ذلك نعم_____ كلا _____

متزن نعم _____ كلا _____

اذا كان الجواب كلا لسؤال واحد على الاقل يحال الى " التقييم السريري للسقوط" **ملحق (٨)**

(الجزء الاول يتم بواسطة ملاك صحي مدرب والجزء الثاني بواسطة الطبيب)

ملحق (٣) قواعد السلامة والامان في داخل وخارج المنزل للوقاية من السقوط

نصائح السلامة خارج المنزل

١- ارتدي حذاء منخفض الكعب مع باطن مطاطي للحصول على أساس أكثر صلابة وارتدي أحذية دافئة في فصل الشتاء.

٢- استخدام القضبان اليدوية اثناء الصعود والنزول من السلم وعلى السلالم المتحركة.

٣- أنظر بعناية في أسطح الأرضيات في المباني العامة. ان الأرضيات المصنوعة من الرخام المصقول للغاية أو البلاط يمكن أن تكون زلقة جدا وعندما تكون هذه الأسطح رطبة ، فإنها قد تصبح خطيرة.

٤- المشي في الممرات اوالشوارع الخالية من القمامة أو الفوضى والانتباه الى المنحدرات لتجنب خطر السقوط.

٥- قم بتشغيل الضوء الخارجي للمنزل قبل مغادرته في وقت مبكر من المساء بحيث يكون لديك ضوء في الهواء الطلق عند العودة للمنزل بعد حلول الظلام.

٦- استخدم حقيبة الكتف أو حقيبة الظهر اذا كانت لديك ادوات تحملها معك لترك يديك فارغة اثناء المشي.

٧- استخدم عكازة او مشاية حسب الحاجة.

٨- تعرف على الخدمات المجتمعية التي يمكن أن تقدم المساعدة، مثل الصيدليات على مدار ٢٤ ساعة ومحلات البقالة التي تأخذ الطلبات عبر الهاتف أو الإنترنت خاصة في حالة سوء الأحوال الجوية.

٩- التحقق من ارتفاع السلم قبل الصعود أو النزول.

١٠- ارتداء حماية الورك اثناء المشي بالنسبة للمرضى المصابين بهشاشة العظام.

نصائح السلامة في الأماكن المغلقة وداخل المنزل

جرّب النصائح التالية لمنع السقوط عندما تكون داخل منزلك:

حول المنزل:

١- ضع الاغراض التي تستخدمها في أغلب الأحيان في متناول اليد هذا يمنعك من الاضطرار إلى القيام بالكثير من التوقف والانحناء.

٢- استخدم الأجهزة المساعدة لتساعدك في تجنب الإجهاد أو الإصابة، على سبيل المثال استخدم الة المسك الطويل لالتقاط الاشياء بدون الانحناء.

٣- تأكد من وجود الهاتف اللاسلكي أو الهاتف الخليوي للاتصال من غرفة إلى غرفة حتى تتمكن من الحصول على مساعدة.

الارضيات

١- إزالة جميع الأسلاك الفضفاضة، والحبال وقطع السجاد المتحركة.

٢- حافظ على الأرضيات خالية من الفوضى.

٣- تأكد من أن جميع قطع السجاد مقاوم للانزلاق أو يتم تثبيتها على الأرض.

٤- عدم استخدام مواد تنظيف زلقة على الأرضيات.

٥- الحفاظ على الأثاث في مكانه المعتاد.

الحمام

١- تثبيت مساند على جدران الحمام بجانب حوض الاستحمام والدوش والمرحاض.

٢- استخدام دواسة مطاطية غير زلقة في ارضية الحمام وحوض الاستحمام.

٣- إذا كنت غير قادر على الوقوف على قدميك في الحمام، بالامكان استخدام كرسي من البلاستيك في الحمام وحوض الاستحمام.

المطبخ

١- استخدم الحصير أو السجاد الثابت على الأرض بالقرب من الموقد واماكن تصريف الماء.

٢- تنظيف الرطوبة بمجرد حدوثها (في المطبخ وفي أي مكان في المنزل).

غرفة النوم

١- وضع مفاتيح الإضاءة قرب السرير وضوء ليلي بين غرفة النوم والحمام.

٢- الجلوس ببطء بعد الاستيقاظ مباشرة لتجنب الدوار او الدوخة التي قد تتسبب بالسقوط.

٣- الاحتفاظ بمصباح يدوي مع بطاريات جديدة بجانب السرير.

٤- الحفاظ على الأدوية ومساعدات المشي بالقرب من الكبير

الدرج

١- حافظ على السلالم مضاءة جيدًا، مع مفاتيح الإضاءة في اعلى واسفل الدرج.

٢- تثبيت مساند قوية على كلا الجانبين.

٣- وضع علامة على درجات السلم العلوية والسفلية مع شريط فسفوري وتأكد من أن السجاد آمن.

بالإضافة إلى المخاطر الداخلية والخارجية، هناك بعض سلوكيات نمط الحياة التي تجعل الشخص أكثر عرضة للسقوط إليك بعض النصائح حول نمط الحياة لمساعدتك:

١- ابق في حالة تأهب وتركيز عندما تكون في الأماكن العامة.

٢- تذكر أن ترتدي الأحذية المناسبة سواء في داخل اوخارج المنزل.

٣- إذا كنت في عجلة من امرك حاول ان لا تسرع لان الحوادث أكثر عرضة لحدوثها عندما تستعجل.

٤- تأكد من نظاراتك جيداً.

٥- إجراء مراجعة سنوية للأدوية من قبل مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي.

٦- تجنب شرب الكحول لانه قد يسبب الدوخة أو الارتباك.

٧- تجنب الخروج من المنزل في حال استخدام الأدوية التي تزيد من خطر السقوط.

ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي المتوازن يومياً يحتوي على الكميات الموصى بها من الكالسيوم وفيتامين D.

ملحق (٤) اداة التقييم السريري للأكتئاب لدى المسنين

التعليمات	إختر الجواب الأنسب لحالتك النفسية خلال الأسبوع الماضي		
١-	هل أنت بشكل عام راضٍ عن حياتك ؟	نعم	**كلا (١)**
٢-	هل تخليت عن العديد من نشاطاتك و إهتماماتك ؟	**نعم (١)**	كلا
٣-	هل تشعرُ أن حياتك فارغة ؟	**نعم (١)**	كلا
٤-	هل تصاب بالملل عادة ؟	**نعم (١)**	كلا
٥-	هل أنت في مزاجٍ حسن في أغلبية الوقت ؟	نعم	**كلا (١)**
٦-	هل تخاف أن يصيبك مكروه ؟	**نعم (١)**	كلا
٧-	هل تشعرُ بالسعادة أغلبية الوقت ؟	نعم	**كلا (١)**
٨-	هل تشعرُ عادةً أنك بحاجة إلى مساعدة ؟	**نعم (١)**	كلا
٩-	هل تفضل البقاء في غرفتك على الخروج و القيام بنشاطات جديدة ؟	**نعم (١)**	كلا
١٠-	هل تشعرُ أنّ مشاكل الذاكرة تصيبك أكثر من غيرك ؟	**نعم (١)**	كلا
١١-	هل تعتقد أنه لأمر رائع بقاؤك حياً الآن ؟	نعم	**كلا (١)**
١٢-	هل تشعرُ أنك لا تجدي نفعاً في الوقت الحالي ؟	**نعم (١)**	كلا
١٣-	هل تشعرُ أنك شديد النشاط ؟	نعم	**كلا (١)**
١٤-	هل تعتقد أن وضعك ميؤوس منه ؟	**نعم (١)**	كلا
١٥-	هل تعتقد أن أغلبية الناس بوضعٍ أفضل من الذي أنت عليه ؟	**نعم (١)**	كلا
	مجموع النقاط (تسجل نقطة واحدة لكل اجابة بالخط العريض)		

اذا كان مجموع النقاط أكثر من ٥ , فأن المسن قد يكون مصاب بالاكتئاب ويحال الى الطبيب

ملحق(٥) اداة التقييم السريري للسلس البولي

الغاية منه	تقييم سلس البول
يتم بواسطة	الجزء الاول : ممرض أو ملاك صحي مدرب الجزء الثاني: طبيب
كم يستغرق	١٥ دقيقة

الجزء الأول

الاسم: ---------- العمر:----------تاريخ ----------

تاريخ المرضى للجهاز البولي والتناسلي:

□سرطان المثانة □التهابات المجاري البولية □حصى الكلى □ تضخم البروستات للرجال

للنساء فقط:

عدد الاحمال السابقة ----------

انقطاع الطمث؟ نعم □ عدد سنوات انقطاع الطمث ---------

كلا □

علاج هرمون الاستروجين نعم □ كلا □

□ عملية إزالة الرحم □ عملية ازالة المبيضين □ تاريخ عائلي لسرطان الثدي

موجز سلس البول:

١- متى بدأت المشكلة؟

هل يؤثر ذلك على نشاطاتك اليومية؟ نعم □ كلا □

إذا كان الجواب نعم، كيف؟ ----------

٢- ما الذي يجعل المشكلة أسوأ؟

□ الركض □ العطاس □ السعال □ الضحك

□ حمل الاثقال □ الانحناء للاسفل □ سماع صوت الماء الجاري

٣- ما هي المشاكل التي تواجهها عند التبول في الحمام؟

□ مشكلة في بداية التبول

□ مشكلة تدفق البول بطيء

□ مشكلة عدم الراحة اثناء التبول

□ مشكلة الادرار الدموي

□ مشكلة افراغ غير كامل للمثانة

٤- مشاكل أفراغ المثانة

□يعاني من بلل بدون ان يشعر

هل تستطيع السيطرة (تحبس)على الادرار؟ □ سيطرة تامة في جميع الاوقات □دقيقة او دقيقتين

□عدة دقائق □ التبول الليلي غير الارادي

PART 2(by doctor)

- Medication review – What medication are you currently taking? (Note beta blocker, sedative, narcotic, diuretic, anticholinergic, calcium channel blockers, non-prescription drugs, cold remedy, and herbals)
- **Treatment (as indicated)**

ملحق (٦) تمارين كيجل

كيف تمارس تمارين كيجل؟

قبل البدء بممارسة تمارين كيجل ، يجب معرفة العضلات الصحيحة التي يجب التركيز عليها اثناء التمرين. أفضل طريقة لمعرفة ذلك من خلال التخيل بالحاجة الملحة للتبول والتغوط معا ولايقاف ذلك يتم من خلال تقليص عضلات قاع الحوض حيث ان هذه العضلات المستخدمة هي التي سيتم تقويتها للمساعدة في التحكم في سلس البول، ولإجراء تمارين كيجل يجب اتباع الخطوات التالية:

- إفراغ المثانة قبل البدء.
- شد عضلات قاع الحوض لمدة ثلاث ثوان ثم الاسترخاء لمدة ستة ثوان .
- يمكن القيام بهذا التمرين ثلاث مرات باليوم في كل مرة ١٠ تكرارات ويمكن زيادة عدد المرات تدريجيا خلال اليوم .
- يمكن ممارسة التمرين مستلقيا او اثناء الجلوس على الكرسي او الاسترخاء على الاريكة.

متى تمارس تمارين كيجل؟

يجب ان يكون ممارسة تمارين كيجل جزء من نظام الحياة اليومي ويمكن ممارسة هذه التمارين في أي وقت.

ملحق (٧) اداة تقييم السقوط

الغاية منه	تقييم السقوط
يتم بواسطة	الجزء الاول : ممرض أو ملاك رعاية صحية مدرب الجزء الثاني: طبيب
كم يستغرق	٢٠ دقيقة

الجزء الأول

الاسم :---------- العمر:----- التاريخ :----------

تاريخ التعرض للسقوط

لغرض وصف السقوط نحن بحاجة لسماع تفاصيل مشكلة السقوط الخاص بك حتى نتمكن من معرفة الاسباب. أجب على الأسئلة التالية عن اخرسقوط تعرضت له.

١- متى تعرضت للسقوط ؟ ----------
٢- التاريخ (تقريبي)---------- في اي وقت من اليوم----------
٣- ماذا كنت تفعل قبل أن تسقط؟ ----------
٤- هل تتذكر سقوطك، أم أن أحدهم أخبرك عنه؟----------
٥- كيف كان شعورك قبل ان تسقط؟ ----------
٦- كيف كان شعورك وأنت تسقط؟ ----------
٧- على أي جزء من جسمك سقطت؟ ----------
٨- على ماذا سقطت؟ ----------
٩- هل ادى السقوط الى حدوث جروح؟----------
١٠- هل تتذكر أي شيء آخر اثناء السقوط؟ ----------
١١- هل تعتقد أنك أغمي عليك اثناء السقوط؟ ----------
١٢- هل لديك ألم في المفاصل؟ ----------
١٣- هل لديك عدم استقرار(ضعف) في المفاصل؟ ----------
١٤- هل لديك مشاكل في القدم ؟ ----------
١٥- هل تستخدم العصا او حجلة اثناء المشي؟ ----------

كم مرة سقطت في الأشهر الستة الماضية؟

PART 2(by doctor)

What medication are you currently taking?

□Psychotropic medications □Diuretics □Antiarrhythmic
Noticed any vision changes □Yes/ □ Non
Eye exam past year □ Yes/□ Non

Feet – any abnormalities □ Yes □ No

Gait analysis

Gait: normal abnormal

Up-and-Go test: ____sec

Up-and-Go test:
-Stand from chair,
-Walk 10 feet (3 meters),
-Turn around,
-Walk back,
-Sit down

Is at risk (patient who takes more than 30 second)

Abnormal if: Hesitant start

□Broad-based gait
□Extended arms
□Heels do not clear toes of other foot
□Heels do not clear floor
□Path deviates

Balance test: YES NO

(1) Side-by-side, stable 10 sec □ □

(2) Semi-tandem, stable 10 sec □ □

(3) Full tandem, stable 10 sec □ □

Balance test
(1) side-by-side: feet side by side, touching;
(2) Semi-tandem: side of the heel of one foot touching the big toe of the other;
(3) tandem: heel of one foot directly in front of and touching the toes of the other foot.
Each stance is progressively more difficult to hold. People unable to hold a position for 10 seconds are not asked to attempt further stands

Tick if abnormal

	STRENGTH		TONE	
	Left	Right	Left	Right
ARM				
LEG				

Quadriceps strength: can rise from chair without using arms Yes □ No□

Treatment (to be completed by the doctor):

1-

2-

ملحق (٨) ممارسة رياضية للوقاية من السقوط



التمرين ١: الموقوف على طرف واحد

من الأفضل أن تبدأ مع تمارين التوازن البسيطة لكبار السن. وإليك كيف يمكنك القيام بهذا : الوقوف وراء كرسي ثابت وصلب (لا يحتوي على عجلات) ، والتمسك في الجزء الخلفي منه. ارفع قدمك اليمنى واتزن على قدمك اليسرى. أمسك هذا الموقف لأطول فترة يمكنك، ثم قم بتبديل القدمين.

يجب أن يكون الهدف هو الوقوف على قدم واحدة دون التمسك بالكرسي و لمدة تصل إلى دقيقة واحدة.



التمرين ٢: رفع الساق الخلفية

هذا التمرين تدريب قوة لكبار السن يجعل أسفل الظهر والساقين اكثر قوة.

قف خلف كرسي ببطء ارفع ساقك اليمنى إلى الوراء مباشرة لا تثني ركبتيك أو أصابع قدميك. ابقى على هذا الموقف لثانية واحدة، ثم اجلب بلطف ساقك إلى أسفل. كرر هذا التمرين ١٠ إلى ١٥ مرة في الساق الواحدة.



التمرين ٣: رفع الساق الجانبية

ستحتاج إلى كرسي لهذا التمرين لتحسين التوازن.

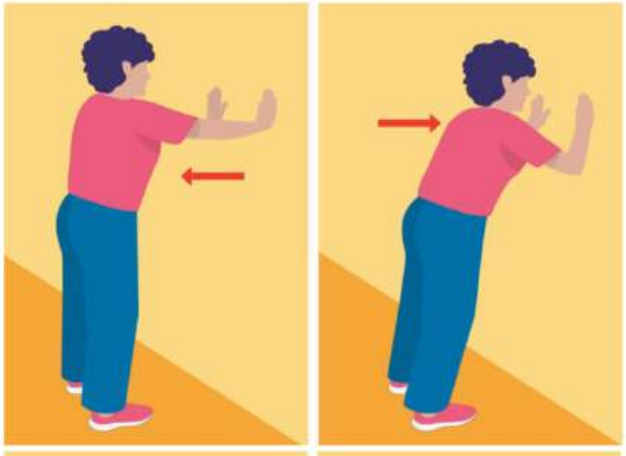
قف خلف الكرسي مع قدميك متباعدة قليلاً ببطء ارفع ساقك اليمنى إلى الجانب. حافظ على ظهرك مستقيمًا ، ومواجهة مؤخرتك للأمام ، وحدق إلى الأمام مباشرة. اخفض ساقك اليمنى ببطء كرر هذا التمرين ١٠ إلى ١٥ مرة في الساق الواحدة.



التمرين ٤: رفع اصابع القدم

هذا التمرين تدريب القوة لكبار السن يحسن أيضا التوازن. ستحتاج إلى كرسي .

قف مستقيماً و ضع ذراعيك أمامك ارفع نفسك على أصابع قدميك ثم انزل نفسك بلطف. لا تميل بجسمك إلى الأمام على كرسي. ارفع وأخفض نفسك كررها ٢٠ مرة.



التمرين ٥: دفع الجدار

طالما لديك جدار، يمكنك القيام بهذا التدريب على القوة لكبار السن.
الوقوف على طول الذراع أمام الجدار الذي لا يحتوي على أي لوحات أو زخارف أو نوافذ أو الأبواب. انحني إلى الأمام قليلاً وضع كفيك مسطحة على الحائط في ارتفاع وعرض كتفيك. قدميك ثابتة على الارض ثم ببطء اجلب جسمك نحو الجدار ثم ادفع نفسك برفق إلى الخلف حتى تكون ذراعيك مستقيمة. كررها عشرين مرة.



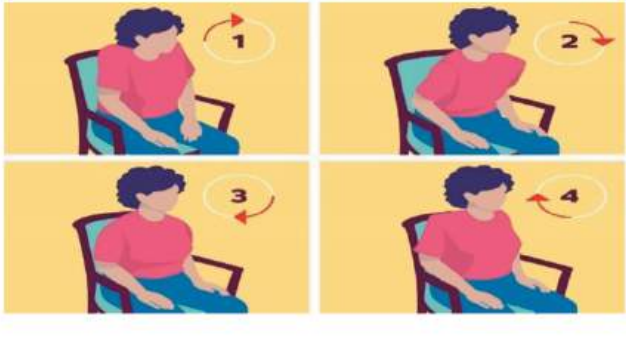
التمرين ٦: تمدد العضلة الخلفية للساق

هذه تمارين تدريب القوة لكبار السن يمكن أن يؤديها من الجلوس أو الوقوف.
للقيام بتمدد العضلة الخلفية للساق أثناء الوقوف، قم بالوقوف في مواجهة الجدار مع وضع يديك على مستوى العين. ضع ساقك اليسرى خلف ساقك اليمنى حافظ على كعبك الأيسر على الأرض واحني ركبتك اليمنى لمدة ١٥ إلى ٣٠ ثانية. كرر مرتين إلى أربع مرات في الساق الواحدة.
اجلس على الارض واستخدم قطعة قماش وضعها خلف قدمك ثم اسحبها الى الامام ببطء كرر التمرين عدد ٢-٤ لكل ساق



التمرين ٧: تمارين اليد والأصابع

وفيما يلي تمارين لتحسين المرونة. لا تحتاج إلى الوقوف في هذا التمرين تظاهر بوجود جدار أمامك أصابعك ستتسلق الجدار حتى تكون فوق رأسك ثم ابقِ بذراعيك فوق رأسك وحرك أصابعك لمدة عشر ثوان. ثم انزل ذراعك إلى أسفل.
ضع ذراعك خلف ظهر الكرسي وامسك يديك ثم قم بسحب ذراعيك ببط وانت ممسك بيديك لمدة عشرة ثواني. حاول تكرار التمرين.



التمرين ٨: دوران الكتف

هذا التمرين يعتبر بسيط ويستطيع كبار السن ممارسته بسهولة
يمكن اجراء التمرين من وقوف او من جلوس.
ارفع كتفيك ببطء الى اعلى ارتفاع ممكن ثم قدم كتفك الى الامام ثم ارجع كتفك مستقيماً بصورة طبيعية ثم ادفع كتفك الى الوراء كرر التمرين اكثر من مرة.

ملحق (٩) اداة التقييم السريري لفقدان الذاكرة

Mini-mental state examination (MMSE)

What for?	Screening of cognitive impairments
By whom?	Medical doctor
How long?	15 minutes

Tool 2 MMSE

Approach the patient with respect and encouragement.

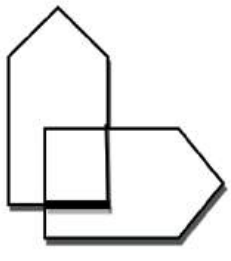
Date of examination ----------

Ask: Do you have any trouble with your memory? Yes [ ] No [ ]

May I ask you some questions about your memory? Yes [ ] No [ ]

ITEM	SCORE
Time orientation Ask : What is the year ? 1 Season ------1 Month of the year ? 1 Date ---------1 Day of the week -------1	5
Place orientation Ask : Where are we now? What is the state----------1 city ----------1 part of the city ----------1 building----------1 floor of the building---------- 1	5

Registration of 3 words Say : listen carefully . I am going to say 3 words You say them back after I stop. Ready? Here they are...**apple**..(wait one second)..**table**..(wait one second)..**pen**..(wait one second) What were those words? _____(1) _____(1) _____(1) Give 1 point for each correct answer, then repeat them until the patient learns all three	3
SERIAL 7 as a test for attention & calculation: Ask: Subtract 7 from 100 and continue to subtract 7 from each subsequent remainder until I tell you to stop . What Is 100 take away 7 ? ------- Say: Keep Going _____(1), _____(1) _____(1), _____(1), _____(1)	5
Naming: Ask: What is this? (show pencil)_____(1), What is this? (show watch)_____(1)	2
Repetition: Say: Now I am going to ask you to repeat what I say. Ready? "No ifs, ands, or buts" "بلا إذا ولا لكن ولا أو" Now you say that. _____(1)	1
Comprehension : Say: Listen carefully because I am going to ask you to do something: Take this paper in your left hand (1), fold it in half (1), and put it on the floor. (1)	3

Reading: Say: Please read the following and do what it says, but do not say it aloud. (1) **"Close your eye"**	1
writing : Say: Please write a sentence. If patient does not respond Say: Write about the weather. (1)	1
Drawing : Say: Please copy this design. 	1

SCORE:-

27-30	**Normal**
20-26	**Mild impairment**
10-19	**Moderate impairment**
Below	**Severe impairment**
For scores below 27	**Complete the memory loss evaluation form(Tool 3) and follow the flowchart for managing memory loss**

Doctor name …….. date……..

Memory loss evaluation form

What for?	Memory loss clinical questioning
By whom?	Medical doctor
How long?	5-15 minutes

History of the memory problem: yes ☐ no ☐

Psychiatric history: yes ☐ no ☐

Family History

☐ Hypertension ☐ Dementia

☐ Parkinson s disease ☐ Strokes

☐ Diabetes ☐ Cardiovascular disease

☐ Depression ☐ Down 's syndrome

Medications currently taking (mention)

1- **2-** **3-** **4-**

Symptoms (circle positives)

☐ Speech difficulty ☐ Confusion ☐ Aggressive

☐ Delusions ☐ Hallucinations

☐ Emotional change ☐ Fall, injury

☐ Balance problems ☐ Behavior changes

Main problem identified by family/caregiver

1- ……

2- ……

Doctor name …….. date……..